

Bunga Rampai

PERAN PERAWAT DALAM PENCEGAHAN RISIKO

Perilaku Kekerasan pada Pasien Gangguan Jiwa

Femi Kesumawati • Sondang Selviana • Reta Renylda

Editor: Ediyar Miharja



BUNGA RAMPAI PERAN PERAWAT DALAM PENCEGAHAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN PADA PASIEEN GANGGUAN JIWA

Penulis:

Ns. Femi Kesumawati, S.Kep., M.Kep.
Sondang Selviana, S.Kep., Ners., M.Kes., M.Kep.
Ns. Reta Renylda, M.Kep.

Editor:

Ns. Ediyar Miharja, S.Kep., S.H., M.H.



Bunga Rampai Peran Perawat dalam Pencegahan Risiko Perilaku Kekerasan pada Pasien Gangguan Jiwa

Penulis:

Ns. Femi Kesumawati, S.Kep., M.Kep.
Sondang Selviana, S.Kep., Ners., M.Kes., M.Kep.
Ns. Reta Renylda, M.Kep.

Editor:

Ns. Ediyar Miharja, S.Kep., S.H., M.H.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-49-7

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul **“Peran Perawat dalam Pencegahan Risiko Perilaku Kekerasan pada Pasien Gangguan Jiwa.”** Buku ini disusun sebagai salah satu referensi akademik dan praktis dalam bidang keperawatan jiwa, khususnya mengenai peran perawat dalam mengenali, mencegah, menangani, dan mengevaluasi risiko perilaku kekerasan pada pasien dengan gangguan jiwa. Risiko perilaku kekerasan merupakan salah satu masalah keperawatan jiwa yang membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, keluarga, tenaga kesehatan, serta lingkungan perawatan.

Buku ini membahas secara sistematis peran perawat dalam pencegahan risiko kekerasan pada pasien gangguan jiwa, termasuk pemahaman mengenai faktor predisposisi dan faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku kekerasan. Selain itu, buku ini juga menguraikan pentingnya komunikasi terapeutik dan teknik de-eskalasi sebagai keterampilan utama perawat dalam menghadapi pasien yang mengalami kecemasan, kemarahan, agitasi, atau menunjukkan tanda-tanda peningkatan agresivitas. Pembahasan mengenai konsep dasar komunikasi terapeutik, prinsip dan tahapan komunikasi, teknik komunikasi dalam keperawatan, hambatan komunikasi, serta pelaksanaan de-eskalasi diharapkan dapat memperkuat kemampuan perawat dalam menciptakan interaksi yang aman, empatik, dan tidak provokatif.

Pada bagian selanjutnya, buku ini menekankan pentingnya evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan pasien dalam mengenali penyebab marah, mengontrol dorongan agresif, menggunakan teknik pengendalian marah, menjaga keamanan diri dan lingkungan, mematuhi terapi, serta memperoleh dukungan keluarga. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat jiwa, tenaga kesehatan, keluarga pasien, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan jiwa yang aman, manusiawi, profesional, dan berorientasi pada pemulihan pasien.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PERAN RERAWAT DALAM PENCEGAHAN RESIKO KEKERASAN PADA PASIEN GANGGUAN JIWA.....

Ns. Femi Kesumawati, S.Kep., M.Kep.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Faktor Predisposisi Prilaku Kekerasan.....	2
C. Faktor Predisposisi Perilaku Kekerasan	4
D. Refrensi	4

CHAPTER 2 KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN TEKNIK DE-ESKALASI.....

Sondang Selviana, S.Kep., Ners., M.Kes., M.Kep.....	7
A. Pendahuluan.....	7
B. Konsep Dasar Komunikasi Terapeutik	10
C. Prinsip dan Tahapan Komunikasi Terapeutik.....	16
D. Teknik Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan.....	22
E. Hambatan dalam Komunikasi Terapeutik.....	27
F. Konsep Dasar Teknik De-eskalasi.....	33
G. Pelaksanaan Teknik De-eskalasi dalam Praktik Keperawatan.....	38
H. Simpulan.....	44
I. Referensi.....	45
J. Glosarium.....	46

CHAPTER 3 EVALUASI KEBERHASILAN INTERVENSI KEPERAWATAN JIWA PADA PASIEN RISIKO PERILAKU KEKERASAN

Ns. Reta Renylda, M.Kep.....	49
A. Pendahuluan/Prolog	49
B. Konsep Dasar Risiko Perilaku Kekerasan	53
C. Konsep Dasar Intervensi Keperawatan Jiwa pada Risiko Perilaku Kekerasan.....	58
D. Konsep Evaluasi Keberhasilan Intervensi Keperawatan.....	64

E. Indikator Keberhasilan Intervensi pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan	69
F. Metode Evaluasi Keberhasilan Intervensi	75
G. Evaluasi Respons Pasien terhadap Intervensi Pengendalian Marah.....	80
H. Evaluasi Keamanan Pasien dan Lingkungan.....	85
I. Evaluasi Kepatuhan Terapi dan Penggunaan Obat	90
J. Evaluasi Peran Keluarga dalam Mendukung Keberhasilan Intervensi	95
K. Simpulan.....	101
L. Referensi.....	102
M. Glosarium	104
PROFIL PENULIS	107

CHAPTER 1

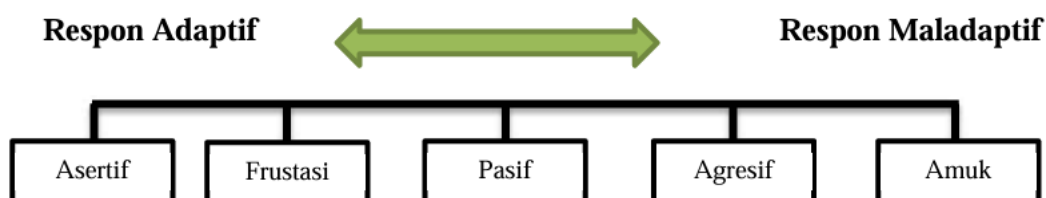
PERAN RERAWAT DALAM PENCEGAHAN RESIKO KEKERASAN PADA PASIEN GANGGUAN JIWA

Ns. Femi Kesumawati, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Reaksi maladaptif terhadap amarah, efek dari kemarahan yang ekstrem, dan teror dapat terwujud sebagai perilaku kekerasan. Salah satu gejala awal perilaku kekerasan pada penderita skizofrenia adalah keinginan untuk menghindari interaksi sosial karena perasaan tidak berharga, takut, dan ditolak (Pardede & Laia, 2020).

Salah satu cara orang mengatasi stres adalah dengan tindakan agresif, baik verbal maupun nonverbal, yang ditujukan kepada diri sendiri, orang lain, atau lingkungan. Perilaku agresif semacam ini meliputi bertindak tidak rasional, bersikap antagonis, dan menyakiti atau membuat orang lain kesal secara verbal maupun fisik (Keliat, 2015 dalam Pujiningsih, 2021).



Gambar 1.1: Rentang Respon Masalah
(Stuart, W & Sunden, S, 2013)

Keterangan Gambar :

1. Perilaku asertif artinya kepribadian pada mana seorang bisa menunjukkan pandangan tidak senang atau geram tanpa menyinggung perasaan orang lain. Sikap ini bisa menenangkan emosi seorang.
2. Frustrasi artinya reaksi dari tidak tercapainya tujuan.
3. Sikap pasif ialah sikap di mana individu tidak dapat berkata rasa marah yang dialaminya serta hal ini dilakukan buat menghindari keluhan yang nyata.

4. Sikap agresif dikaitkan dengan kemarahan, kendali mental, dan keinginan untuk bertindak. Orang yang agresif tidak peduli dengan kewenangan orang lain. Menurut mereka hidup adalah landasan perang. Individu membagikan kemampuan dan menaikkan harga dirinya buat menekan orang lain.
5. Violent (amuk) adalah rasa permusuhan atau murka yang intens serta melibatkan hilangnya cara yang dapat merugikan diri sendiri serta lingkungannya.

B. Faktor Predisposisi Prilaku Kekerasan

Faktor pembawa perilaku kekerasan terdiri atas factor predisposisi dan factor presipitasi sebagai berikut :

1. Faktor Biologis

- a. Masalah yang diperiksa di faktor biologis meliputi adanya faktor herediter menderita gangguan jiwa, kondisi penyakit atau trauma kepala, serta perihal penggunaan NAPZA (Irman et al., 2016).
- b. Dari Stuart (2013) pada (Dermawan dan Rusdi, 2013) faktor biologis penyebab perilaku kekerasan :
 - 1) Menurut Teori Dorongan Instingtual, setiap tindakan kekerasan bermula dari kebutuhan mendasar dan mendasar.
 - 2) Menurut teori psikosomatis, kondisi emosional seseorang termasuk kemarahan merupakan reaksi fisiologis terhadap Kemenkes Poltekkes Padang 10 faktor internal dan eksternal tertentu. Dalam hal melepaskan atau menekan kemarahan, sistem limbik berperan penting.

2. Faktor Psikologis

- a. Pengalaman marah merupakan hasil dari respon psikologis terhadap rangsangan eksternal, internal, atau lingkungan. Perilaku kekerasan terjadi akibat dari frustrasi yang terakumulasi. Frustrasi terjadi ketika keinginan individu untuk menerima sesuatu dikecewakan atau terhenti, seperti kesehatan fisik yang terganggu, hubungan sosial yang terganggu. Salah satu kebutuhan manusia adalah "berperilaku", jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dengan berperilaku konstruktif, maka yang akan terjadi adalah individu tersebut berperilaku destruktif (Irman et al., 2016).
- b. Sedangkan berdasarkan Stuart (2013) pada (Dermawan dan Rusdi, 2013) faktor psikologis perilaku kekerasan yaitu :
 - 1) Teori Agresi Frustrasi menyatakan bahwa orang bertindak dengan kekerasan ketika mereka merasa putus asa. Ketika harapan dan impian seseorang untuk memperoleh sesuatu tidak terpenuhi atau meresahkan,

hal itu dapat menyebabkan frustrasi. Orang-orang dalam skenario ini mungkin merespons dengan kekerasan karena mereka percaya bahwa tindakan kekerasan akan membantu mereka mengatasi perasaan gagal.

- 2) Subjek: Teori Perilaku Perilaku Kemarahan adalah alat untuk pertumbuhan; dengan lingkungan yang tepat, kemarahan dapat dipupuk.
 - 3) Manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk bertindak, dan menurut teori eksistensial (juga dikenal sebagai "teori realitas"), jika dorongan ini tidak dapat dipenuhi oleh sifat-sifat karakter yang positif, maka individu tersebut akan melakukan tindakan negatif.
- c. Psikologis menurut (Prabowo, 2014) yakni kegagalan yang dialami mampu mengakibatkan frustrasi yang lalu bisa tampak proaktif atau amuk. Perasaan ditolak, malu, dilecehkan, atau dieksekusi merupakan contoh pengalaman masa kecil yang tidak mengenakan

3. Faktor Sosiokultural

- a. Cara seseorang mengekspresikan kemarahan dapat dikaitkan dengan gangguan fungsi dan hubungan sosial serta konteks sosial yang membahayakan kebutuhan individu. Orang dapat dihipnotis untuk merespons secara agresif atau proaktif oleh norma budaya. Menurut teori pembelajaran sosial, kecenderungan agresif dapat tertanam pada anak-anak sejak usia dini dengan melihat dan meniru perilaku agresif orang tua dan kakek-nenek mereka dalam menanggapi situasi yang menantang (Irman et al., 2016).
- b. Stuart (2013) pada (Dermawan dan Rusdi, 2013) menyebutkan faktor sosiokultural perilaku kekerasan yaitu ;
 - 1) Lingkungan sosial seseorang akan menentukan bagaimana mereka bertindak saat marah, menurut Teori Lingkungan Sosial (Social Environment Theory). Respons yang tegas atau proaktif mungkin dipengaruhi oleh norma budaya.
 - 2) Menurut Teori Pembelajaran Sosial, paparan tidak langsung dan langsung dapat menyebabkan perolehan perilaku agresif.

4. Adapun faktor prediposisi lainnya berdasarkan (Prabowo, 2014) sebagai berikut :

- a. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap normalisasi perilaku kekerasan, termasuk paparan media yang mengandung kekerasan, penguatan positif untuk tindakan kekerasan, dan perilaku kekerasan seseorang di rumah dan di masyarakat.

- b. Banyak faktor sosial dan budaya yang berkontribusi terhadap penerimaan perilaku kekerasan, termasuk kurangnya dialog terbuka dan kecenderungan orang untuk bereaksi secara diam diam atau pasif agresif.

C. Faktor Predisposisi Perilaku Kekerasan

1. Stressor

- a. Komponen pencetus ini, menurut Sutejo (2017), dikaitkan dengan konsekuensi stres yang menyebabkan perilaku kekerasan pada setiap orang. Tekanan dapat berasal dari dalam maupun luar. Agresivitas fisik, kehilangan, kematian, dan kejadian traumatis lainnya merupakan contoh stres eksternal. Beberapa contoh stres internal adalah kekhawatiran akan penyakit fisik, penyakit internal, kematian orang yang dicintai, dan pengalaman serupa lainnya. Lebih jauh, perilaku agresif dapat dipicu oleh suasana yang tidak mendukung yang penuh dengan hinaan dan perilaku kekerasan.
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku agresif bersifat unik bagi setiap orang, seperti yang ditemukan oleh Dermawan dan Rusdi (2013). Sumber stres dapat berasal dari eksternal (seperti kekerasan fisik, kehilangan, atau kematian) atau internal (seperti memutuskan hubungan dengan orang penting, mengalami penurunan hubungan romantis, atau takut jatuh sakit). Tindakan kekerasan, kritik keras yang meningkat menjadi hinaan, dan Kemenkes Poltekkes Padang 13 lingkungan yang terlalu ramai dan berisik dapat menjadi katalisator perilaku agresif. 2) Lingkungan Faktor presipitasi berdasarkan (Prabowo, 2014) dapat dimulai dengan latar belakang, lingkungan sekitar, atau hubungan pasien dengan orang lain terlebih dahulu. Perilaku agresif pasien dapat berasal dari masalah kesehatan mental yang mendasarinya, seperti depresi, kurangnya rasa percaya diri, atau cacat fisik. Demikian pula, dengan menggunakan lingkungan yang ramai dan bising, kritik yang menunjukkan penghinaan, kehilangan orang yang dicintai atau pekerjaan, dan kekerasan, kita dapat menyimpulkan komponen penyebab tambahan. Perseteruan dan hubungan yang provokatif juga dapat menyebabkan tindakan agresif.

D. Refrensi

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Dermawan, D. (2013). *Keperawatan Jiwa; Konsep dan Kerangka Kerja Asuhan Keperawatan Jiwa* (T. Rahayuningsih (ed.)).
- Deepublish Publisher. Irman, V., Alwi, N. P., & Patricia, H. (2016). *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Jiwa 1*. UNP Press.

- Dermawan, D., & Rusdi. (2013). Keperawatan Jiwa; Konsep dan Kerangka Kerja Asuhan Keperawatan Jiwa (T. Rahayuningsih (ed.); 1st ed.).
- Gosyen Publishing. Direja, & Surya, A. H. (2015). Buku Asuhan Keperawatan Jiwa. Nuha Medika. Fachruddin. (2009).
- Hariyadi, & Rusdianah. (n.d.). Faktor Keturunan dengan Kejadian Skizofrenia. Jurnal Keperawatan Jiwa. Hasmiati. (2013). Kemampuan klien dalam mengontrol perilaku kekerasan dengan penerapan asuhan keperawatan dilakukan di RSJD Provinsi Sulawesi Selatan.
- Hasnawati, Subardin, Dewi, C., Muslimin, I., Hengky, H. K., Windasari, D. P., Syam, A., Syatriani, S., & Hamzah, H. (2022). Epidemiologi di Berbagai Aspek. Rizmedia.
- Hermiati, & Harahap. (2018). Faktor yang Berhubungan dengan Kasus Skizofrenia pada Pasien di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu.
- <https://doi.org/10.36565/jab.v10i1.268> 89 90 Muhith, A. (2015). Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi) (M. Bendetu (ed.); 1st ed.).
- Jurnal Keperawatan Silampari. Indra, I. M. (2019). Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian.
- Kemenkes, R. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar. Kusumawati. (2015). Buku Keperawatan Jiwa.
- Lestari, A., Jannah, S. R., & R, F. D. (2022). Penerapan Terapi Memaafkan pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan: Suatu Studi Kasus Application of Forgiveness Therapy in Patients at Risk for Violent Behavior: A Case Study. 1, 1283136.
- Makhruzah, S., Putri, V. S., & Yanti, R. D. (2021). Pengaruh Penerapan Strategi Pelaksanaan Perilaku Kekerasan terhadap Tanda Gejala Klien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi, 10(1), 39.
- Musmini. (2019). Asuhan Keperawatan pada Klien yang Mengalami Resiko Perilaku Kekerasan.
- Prabowo, E. (2014). Konsep & Aplikasi Asuhan Keperawatan Jiwa (1st ed.). Nuha Medika.
- Riskesdas. (2018). Laporan Provinsi Sumatera Barat. Rosyidah, M. (2021). Metodologi Penelitian. Deepublish Publisher.
- Saputra, M. K. F., Purwoto, A., Iriani, R., Aminuddin, & Hernawaty, T. (2023). Asuhan Keperawatan Jiwa II. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Simanjuntak, J. (2013). Konseling Gangguan Jiwa & Okultisme. Gramedia Pustaka Utama.

Smith, Johnson, & Williams. (2020). Violence Prevention in Schizophrenia. Stuart, W, G., & Sunden, S, J. (2013). Buku Saku Keperawatan Jiwa. EGC.

Suerni, T., & PH, L. (2019). Respons Pasien Perilaku Kekerasan. Jurnal Penelitian Perawat Profesional, 1.

CHAPTER 2

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DAN TEKNIK DE-ESKALASI

Sondang Selviana, S.Kep., Ners., M.Kes., M.Kep.

A. Pendahuluan

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam pelayanan keperawatan. Dalam praktik keperawatan, perawat tidak hanya memberikan tindakan fisik atau prosedur klinis, tetapi juga membangun hubungan profesional yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan percaya kepada pasien. Setiap interaksi antara perawat dan pasien memiliki makna terapeutik apabila dilakukan dengan tujuan membantu pasien memahami kondisi dirinya, mengungkapkan perasaan, mengurangi kecemasan, meningkatkan motivasi, serta mendukung proses penyembuhan. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik tidak dapat dipandang sebagai percakapan biasa, melainkan sebagai bagian dari intervensi keperawatan yang dirancang secara sadar, terarah, dan berlandaskan sikap empati serta penghargaan terhadap martabat manusia.

Pentingnya komunikasi terapeutik dalam pelayanan keperawatan berkaitan erat dengan kondisi pasien yang sering berada dalam situasi rentan. Pasien dapat mengalami rasa takut, cemas, nyeri, marah, bingung, sedih, atau tidak berdaya akibat penyakit, perubahan kondisi fisik, lingkungan perawatan, maupun pengalaman traumatis. Dalam keadaan tersebut, cara perawat berbicara, mendengarkan, memberikan informasi, dan merespons emosi pasien sangat memengaruhi kenyamanan serta kerja sama pasien selama proses perawatan. Komunikasi yang tidak tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman, meningkatkan kecemasan, memperburuk emosi pasien, bahkan menurunkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Sebaliknya, komunikasi yang dilakukan secara terapeutik dapat membantu pasien merasa dihargai, dipahami, dan dilibatkan dalam proses perawatan.

Komunikasi juga menjadi dasar hubungan profesional antara perawat dan pasien. Hubungan ini berbeda dengan hubungan sosial biasa karena memiliki tujuan khusus, yaitu membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik. Dalam hubungan profesional, perawat harus mampu menjaga batas, bersikap objektif, menghormati kerahasiaan pasien, dan menggunakan komunikasi untuk menggali masalah serta kebutuhan pasien secara tepat. Hubungan yang baik

antara perawat dan pasien akan memudahkan proses pengkajian, perumusan masalah, pelaksanaan intervensi, hingga evaluasi hasil keperawatan. Pasien yang merasa percaya kepada perawat biasanya lebih mudah mengungkapkan keluhan, perasaan, kekhawatiran, pengalaman, dan kebutuhan yang mungkin tidak disampaikan kepada orang lain.

Dalam konteks pelayanan keperawatan jiwa, gawat darurat, rawat inap, maupun pelayanan kesehatan umum, komunikasi terapeutik menjadi semakin penting karena perawat sering berhadapan dengan pasien yang mengalami perubahan emosi dan perilaku. Beberapa pasien dapat menunjukkan kecemasan berat, gelisah, marah, frustrasi, menolak tindakan, berteriak, mengancam, atau menunjukkan perilaku agresif. Situasi tersebut dapat terjadi karena pasien merasa takut, tidak memahami kondisi yang dialami, mengalami nyeri, merasa tidak dihargai, memiliki pengalaman buruk sebelumnya, atau sedang mengalami gangguan persepsi dan proses pikir. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan perawat untuk berkomunikasi secara tenang dan terapeutik menjadi kunci dalam mencegah memburuknya situasi.

Teknik de-eskalasi merupakan pendekatan penting yang digunakan untuk menurunkan ketegangan emosional pasien dan mencegah terjadinya perilaku kekerasan. De-eskalasi dilakukan melalui komunikasi verbal dan nonverbal yang bertujuan membantu pasien menjadi lebih tenang, merasa aman, dan mampu mengendalikan respons emosionalnya. Teknik ini sangat diperlukan ketika perawat menghadapi pasien yang tampak cemas, marah, gelisah, panik, atau menunjukkan tanda-tanda peningkatan agresivitas. De-eskalasi bukan sekadar meminta pasien untuk tenang, tetapi merupakan proses yang membutuhkan pemahaman terhadap penyebab emosi pasien, kemampuan membaca bahasa tubuh, penggunaan nada suara yang tepat, pengaturan jarak aman, serta penciptaan lingkungan yang tidak memicu konflik.

Pentingnya teknik de-eskalasi juga berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan pasien, perawat, keluarga, dan lingkungan pelayanan. Pasien yang sedang mengalami peningkatan emosi dapat kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan secara rasional. Jika situasi tidak ditangani dengan tepat, kecemasan dapat berubah menjadi kepanikan, kemarahan dapat berkembang menjadi agresivitas, dan konflik dapat meningkat menjadi perilaku kekerasan. Oleh karena itu, perawat perlu mengenali tanda-tanda awal eskalasi, seperti suara meninggi, wajah tegang, gerakan gelisah, mondar-mandir, mengepalkan tangan, menolak kontak, berbicara kasar, atau menunjukkan sikap mengancam. Pengenalan tanda awal ini memungkinkan perawat melakukan tindakan pencegahan sebelum kondisi menjadi lebih berbahaya.

Dalam pelaksanaannya, de-eskalasi menuntut perawat untuk tetap tenang, tidak terpancing emosi, dan tidak menunjukkan sikap mengancam. Pasien yang sedang marah atau gelisah sering kali sangat sensitif terhadap nada suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan pilihan kata yang digunakan oleh perawat. Nada suara yang tinggi, sikap memerintah, kontak mata yang terlalu tajam, gerakan tiba-tiba, atau respons yang menyalahkan dapat memperburuk keadaan. Sebaliknya, suara yang rendah dan stabil, bahasa yang sederhana, sikap tubuh terbuka, jarak yang aman, serta kalimat yang menunjukkan empati dapat membantu menurunkan ketegangan. Perawat perlu menunjukkan bahwa dirinya hadir untuk membantu, bukan untuk mengancam atau menghukum pasien.

Peran perawat dalam menciptakan suasana aman, tenang, dan suportif sangat penting dalam komunikasi terapeutik dan de-eskalasi. Suasana aman tidak hanya berarti bebas dari benda berbahaya, tetapi juga mencakup rasa aman secara psikologis. Pasien perlu merasa bahwa dirinya didengarkan, tidak dipermalukan, tidak dihakimi, dan tidak diperlakukan sebagai ancaman semata. Perawat dapat menciptakan suasana aman dengan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan komunikasi, menggunakan nama pasien, memberikan kesempatan pasien berbicara, mendengarkan keluhan tanpa memotong, serta mengakui perasaan pasien. Sikap suportif dari perawat dapat membantu pasien menurunkan pertahanan diri dan lebih mudah diarahkan pada penyelesaian masalah.

Selain berperan sebagai pemberi asuhan, perawat juga berperan sebagai pengamat, fasilitator, pelindung, dan penghubung antara pasien dengan tim kesehatan lainnya. Dalam situasi de-eskalasi, perawat perlu mengamati perubahan emosi dan perilaku pasien secara terus-menerus. Perawat juga perlu memfasilitasi pasien agar mampu mengungkapkan perasaan dengan cara yang lebih aman, misalnya dengan mengatakan apa yang dirasakan daripada bertindak agresif. Jika pasien menunjukkan risiko membahayakan diri sendiri atau orang lain, perawat harus segera mengutamakan keselamatan dengan mengatur lingkungan, menjauhkan benda berbahaya, menjaga jarak aman, dan meminta bantuan tim kesehatan bila diperlukan. Dengan demikian, de-eskalasi bukan hanya keterampilan komunikasi, tetapi juga bagian dari manajemen keselamatan pasien.

Komunikasi terapeutik dan teknik de-eskalasi memiliki hubungan yang sangat erat. Komunikasi terapeutik menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan memahami kebutuhan pasien, sedangkan de-eskalasi menjadi strategi khusus ketika komunikasi dibutuhkan dalam situasi yang penuh ketegangan. Tanpa komunikasi terapeutik, de-eskalasi dapat terasa seperti upaya mengendalikan pasien secara sepihak. Sebaliknya, dengan pendekatan terapeutik, de-eskalasi menjadi proses kolaboratif yang membantu pasien merasa tetap dihargai

meskipun sedang berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Perawat perlu memahami bahwa pasien yang marah atau agresif sering kali sebenarnya sedang menyampaikan rasa takut, nyeri, frustrasi, kebingungan, atau kebutuhan yang belum terpenuhi.

Pembahasan mengenai komunikasi terapeutik dan teknik de-eskalasi bertujuan untuk meningkatkan keterampilan perawat dalam memberikan asuhan yang aman, manusiawi, dan profesional. Melalui pemahaman yang baik, perawat diharapkan mampu menggunakan komunikasi bukan hanya sebagai alat menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun hubungan, menenangkan pasien, mencegah konflik, dan mendukung pemulihan. Keterampilan ini penting bagi seluruh perawat, baik yang bekerja di ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, pelayanan keperawatan jiwa, puskesmas, komunitas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Setiap perawat berpotensi menghadapi pasien dengan emosi tidak stabil, sehingga kemampuan berkomunikasi secara terapeutik dan melakukan de-eskalasi harus menjadi kompetensi dasar dalam praktik keperawatan.

komunikasi terapeutik dan teknik de-eskalasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan pasien dan mutu asuhan keperawatan. Pasien yang merasa dipahami cenderung lebih kooperatif, lebih percaya kepada perawat, dan lebih mudah terlibat dalam proses perawatan. Situasi yang awalnya berisiko menimbulkan konflik dapat dikendalikan dengan pendekatan yang tepat, sehingga tindakan pembatasan fisik atau intervensi yang lebih invasif dapat diminimalkan. Dengan demikian, komunikasi terapeutik dan de-eskalasi bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi merupakan bagian penting dari praktik keperawatan profesional yang berorientasi pada keselamatan, penghargaan terhadap martabat pasien, dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

B. Konsep Dasar Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik dalam keperawatan merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan untuk membantu pasien mencapai kondisi kesehatan yang lebih baik, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun emosional. Komunikasi ini bukan sekadar percakapan biasa antara perawat dan pasien, melainkan bagian dari tindakan keperawatan yang memiliki tujuan profesional. Melalui komunikasi terapeutik, perawat berupaya memahami keluhan, perasaan, kebutuhan, harapan, ketakutan, serta respons pasien terhadap kondisi yang dialaminya. Dalam praktik keperawatan, komunikasi terapeutik menjadi sarana penting untuk membangun hubungan yang bermakna antara

perawat dan pasien, sehingga pasien merasa dihargai, didengarkan, diterima, dan didukung selama proses perawatan.

Komunikasi terapeutik memiliki kedudukan yang sangat penting karena hampir seluruh proses keperawatan membutuhkan komunikasi yang efektif. Pengkajian, perumusan masalah, pemberian intervensi, edukasi kesehatan, evaluasi, hingga pendampingan emosional tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa komunikasi yang tepat. Perawat perlu menggunakan komunikasi terapeutik untuk menggali data secara akurat, memahami masalah pasien secara menyeluruh, memberikan informasi yang benar, serta membantu pasien mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatannya. Dalam konteks pasien yang sedang mengalami kecemasan, marah, gelisah, kebingungan, nyeri, atau gangguan psikologis, komunikasi terapeutik menjadi semakin penting karena dapat membantu menurunkan ketegangan emosional dan meningkatkan rasa aman.

Secara umum, komunikasi terapeutik dapat dipahami sebagai komunikasi profesional yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Artinya, fokus utama komunikasi bukan pada kepentingan perawat, tetapi pada kondisi, pengalaman, dan kebutuhan pasien. Perawat perlu hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, memberikan respons yang empatik, serta membantu pasien mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Dalam komunikasi terapeutik, perawat tidak hanya memperhatikan kata-kata yang diucapkan pasien, tetapi juga memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, sikap diam, serta perubahan perilaku. Hal ini penting karena tidak semua pasien mampu menyampaikan perasaannya secara langsung melalui kata-kata. Sebagian pasien mungkin hanya menunjukkan kecemasan melalui gelisah, menangis, menarik diri, atau menolak berbicara.

Tujuan utama komunikasi terapeutik adalah membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Hubungan saling percaya merupakan dasar dari keberhasilan asuhan keperawatan karena pasien akan lebih mudah terbuka apabila merasa aman dan tidak dihakimi. Pasien yang percaya kepada perawat cenderung lebih bersedia menceritakan keluhan, perasaan, pengalaman, riwayat penyakit, kebiasaan, serta masalah yang mungkin sulit disampaikan kepada orang lain. Kepercayaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui sikap perawat yang konsisten, jujur, ramah, empatik, menghargai privasi, dan mampu menjaga kerahasiaan informasi pasien. Jika perawat bersikap terburu-buru, tidak sabar, meremehkan keluhan, atau memberikan respons yang menghakimi, pasien dapat merasa tidak nyaman dan menutup diri.

Dalam membangun hubungan saling percaya, perawat perlu menunjukkan bahwa dirinya hadir untuk membantu pasien, bukan untuk menyalahkan atau

mengendalikan pasien secara sepihak. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan diri, memanggil pasien dengan nama yang disukai, menjelaskan tujuan komunikasi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Perawat juga perlu menunjukkan ketulusan dalam mendengarkan. Ketika pasien berbicara, perawat sebaiknya tidak memotong pembicaraan secara tiba-tiba, tidak meremehkan perasaan pasien, dan tidak langsung memberikan nasihat sebelum memahami masalah secara utuh. Sikap ini membuat pasien merasa bahwa dirinya dihargai sebagai individu yang memiliki pengalaman, nilai, dan kebutuhan yang unik.

Komunikasi terapeutik berbeda dengan komunikasi sosial. Komunikasi sosial biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bertujuan untuk menjalin hubungan umum, berbagi cerita, membangun keakraban, atau memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Dalam komunikasi sosial, topik pembicaraan dapat bersifat bebas, spontan, dan tidak selalu memiliki tujuan tertentu. Misalnya, seseorang berbicara dengan teman tentang kegiatan sehari-hari, pengalaman pribadi, atau hal-hal ringan untuk menciptakan suasana akrab. Sebaliknya, komunikasi terapeutik memiliki tujuan khusus yang berkaitan dengan proses perawatan dan pemulihan pasien. Komunikasi ini dilakukan secara profesional, terarah, dan tetap menjaga batas hubungan antara perawat dan pasien.

Perbedaan lainnya terletak pada fokus komunikasi. Dalam komunikasi sosial, kedua pihak dapat saling berbagi pengalaman pribadi secara seimbang. Namun, dalam komunikasi terapeutik, fokus utama adalah pasien. Perawat tidak menggunakan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan emosional pribadinya, melainkan untuk membantu pasien memahami dan mengatasi masalahnya. Perawat dapat menunjukkan empati dan kehangatan, tetapi tetap menjaga batas profesional. Misalnya, ketika pasien menceritakan rasa takut sebelum tindakan medis, perawat tidak mengalihkan pembicaraan pada pengalaman pribadinya secara berlebihan, tetapi membantu pasien mengungkapkan ketakutan tersebut dan memberikan penjelasan yang menenangkan. Dengan demikian, komunikasi terapeutik menuntut perawat untuk mampu mengendalikan diri, menjaga objektivitas, dan tetap berorientasi pada kepentingan pasien.

Komunikasi terapeutik juga memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan. Unsur pertama adalah perawat sebagai komunikator. Perawat memiliki peran penting dalam memulai, mengarahkan, dan mempertahankan komunikasi agar tetap terapeutik. Sebagai komunikator, perawat harus memiliki kemampuan mendengarkan, berbicara dengan jelas, menunjukkan empati, membaca bahasa tubuh, serta menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi pasien. Perawat juga

perlu memahami bahwa sikap, ekspresi wajah, nada suara, dan posisi tubuh dapat memengaruhi respons pasien. Kata-kata yang baik dapat kehilangan makna apabila disampaikan dengan nada yang kasar atau ekspresi yang tidak ramah. Oleh karena itu, perawat perlu memperhatikan kesesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal.

Unsur kedua adalah pasien sebagai penerima pesan sekaligus mitra komunikasi. Pasien bukan objek pasif dalam komunikasi terapeutik, melainkan individu yang memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam proses perawatan. Kondisi pasien dapat memengaruhi jalannya komunikasi. Pasien yang mengalami nyeri, cemas, takut, bingung, marah, atau gangguan kesadaran mungkin sulit memahami pesan yang disampaikan. Pasien dengan gangguan pendengaran, hambatan bahasa, perbedaan budaya, atau tingkat pendidikan tertentu juga membutuhkan pendekatan komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, perawat harus mampu menyesuaikan cara menyampaikan pesan agar dapat diterima dengan baik oleh pasien.

Unsur berikutnya adalah pesan. Pesan dalam komunikasi terapeutik dapat berupa informasi, pertanyaan, klarifikasi, dukungan emosional, edukasi kesehatan, arahan, atau respons terhadap perasaan pasien. Pesan yang disampaikan harus jelas, sederhana, jujur, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Perawat sebaiknya menghindari penggunaan istilah medis yang sulit dipahami tanpa penjelasan. Pesan juga tidak boleh menakut-nakuti, menyalahkan, atau membuat pasien merasa rendah diri. Misalnya, ketika memberikan edukasi tentang pengobatan, perawat perlu menjelaskan manfaat obat, cara penggunaan, efek samping yang mungkin muncul, dan pentingnya kepatuhan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pesan yang jelas akan membantu pasien memahami kondisi dan meningkatkan keterlibatannya dalam perawatan.

Media komunikasi juga menjadi unsur penting dalam komunikasi terapeutik. Media dapat berupa komunikasi langsung tatap muka, tulisan, gambar, alat bantu edukasi, bahasa tubuh, atau teknologi komunikasi. Dalam pelayanan keperawatan, komunikasi tatap muka sering menjadi media utama karena memungkinkan perawat mengamati respons verbal dan nonverbal pasien secara langsung. Namun, dalam situasi tertentu, media lain juga diperlukan, seperti leaflet edukasi, papan komunikasi, gambar, atau alat bantu visual bagi pasien yang sulit memahami penjelasan verbal. Pemilihan media harus disesuaikan dengan kondisi pasien, tingkat pemahaman, usia, budaya, dan kebutuhan informasi. Media yang tepat dapat membantu pasien memahami pesan dengan lebih baik.

Umpan balik merupakan unsur yang menunjukkan apakah pesan telah diterima dan dipahami oleh pasien. Dalam komunikasi terapeutik, perawat tidak

cukup hanya menyampaikan informasi, tetapi juga perlu memastikan bahwa pasien memahami pesan tersebut. Umpan balik dapat berupa jawaban pasien, perubahan ekspresi wajah, anggukan, pertanyaan balik, atau kemampuan pasien mengulang kembali informasi yang telah disampaikan. Jika pasien tampak bingung, diam, atau memberikan respons yang tidak sesuai, perawat perlu melakukan klarifikasi dan mengulang penjelasan dengan cara yang lebih sederhana. Umpan balik membantu perawat menilai efektivitas komunikasi dan mencegah kesalahpahaman.

Lingkungan komunikasi juga sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi terapeutik. Lingkungan yang tenang, aman, nyaman, dan memiliki privasi akan membantu pasien lebih mudah berbicara. Sebaliknya, ruangan yang bising, ramai, penuh gangguan, atau tidak menjaga privasi dapat membuat pasien sulit berkonsentrasi dan enggan mengungkapkan perasaan. Dalam situasi tertentu, terutama ketika pasien sedang cemas, marah, atau gelisah, lingkungan yang terlalu banyak stimulus dapat memperburuk kondisi emosional pasien. Oleh karena itu, perawat perlu memilih tempat yang sesuai, mengurangi gangguan, menjaga kerahasiaan, dan menciptakan suasana yang mendukung komunikasi. Lingkungan yang baik menunjukkan bahwa perawat menghargai pasien dan serius dalam memberikan perhatian.

Komunikasi terapeutik memberikan banyak manfaat bagi pasien. Pasien yang mendapatkan komunikasi terapeutik akan merasa lebih aman, lebih dipahami, dan lebih percaya kepada perawat. Hal ini dapat menurunkan kecemasan, meningkatkan kenyamanan, memperkuat motivasi, serta membantu pasien lebih kooperatif dalam menjalani perawatan. Melalui komunikasi terapeutik, pasien dapat mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam, memahami kondisi kesehatannya, dan memperoleh dukungan dalam menghadapi masalah. Pada pasien dengan gangguan emosi atau gangguan jiwa, komunikasi terapeutik dapat membantu pasien mengenali perasaan, mengontrol respons, dan membangun kembali hubungan dengan lingkungan secara lebih adaptif.

Bagi keluarga, komunikasi terapeutik juga memiliki manfaat yang besar. Keluarga sering kali mengalami kecemasan, kebingungan, atau ketidakpastian saat mendampingi pasien. Melalui komunikasi yang baik, perawat dapat memberikan informasi yang jelas kepada keluarga mengenai kondisi pasien, rencana perawatan, cara memberikan dukungan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pemulihan. Komunikasi terapeutik membantu keluarga merasa dilibatkan dan tidak diabaikan. Selain itu, keluarga dapat menjadi sumber informasi penting bagi perawat, terutama terkait riwayat kesehatan, kebiasaan, perubahan perilaku, dan kebutuhan pasien di rumah. Dengan komunikasi yang baik, kerja sama antara perawat dan keluarga dapat meningkat.

Bagi perawat, komunikasi terapeutik membantu meningkatkan kualitas pengkajian, ketepatan intervensi, dan keberhasilan asuhan keperawatan. Perawat yang mampu berkomunikasi secara terapeutik akan lebih mudah memperoleh data yang akurat, memahami masalah pasien, mencegah konflik, dan membangun kerja sama. Komunikasi yang baik juga dapat mengurangi stres kerja karena hubungan antara perawat dan pasien menjadi lebih positif. Selain itu, komunikasi terapeutik mencerminkan profesionalisme perawat dalam memberikan pelayanan yang manusiawi dan berpusat pada pasien. Dalam pelayanan kesehatan yang kompleks, keterampilan komunikasi menjadi salah satu kompetensi penting yang menentukan mutu asuhan keperawatan.

Komunikasi terapeutik juga merupakan bagian dari proses penyembuhan dan pemenuhan kebutuhan psikologis pasien. Penyembuhan tidak hanya berkaitan dengan hilangnya gejala fisik, tetapi juga mencakup rasa aman, harapan, kepercayaan diri, penerimaan diri, dan kemampuan pasien menghadapi kondisi yang dialami. Pasien yang sakit sering membutuhkan dukungan emosional, bukan hanya tindakan medis. Ketika perawat mendengarkan dengan empati, memberikan penjelasan yang menenangkan, dan menghargai perasaan pasien, pasien dapat merasa lebih kuat secara psikologis. Rasa didengar dan dipahami dapat membantu pasien mengurangi ketegangan, meningkatkan penerimaan terhadap kondisi, dan membangun motivasi untuk sembuh.

Dalam pemenuhan kebutuhan psikologis, komunikasi terapeutik membantu pasien mengungkapkan rasa takut, marah, sedih, malu, atau kecewa secara aman. Banyak pasien tidak mampu menyampaikan perasaan secara langsung karena takut dianggap lemah, menyusahkan, atau tidak dimengerti. Perawat yang menggunakan komunikasi terapeutik dapat menciptakan ruang aman bagi pasien untuk berbicara. Dengan demikian, komunikasi menjadi sarana untuk mengurangi beban emosional. Pasien yang mampu mengekspresikan perasaannya cenderung lebih mudah diajak bekerja sama dan lebih siap menerima intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik memiliki efek penyembuhan karena menyentuh aspek emosional dan psikologis pasien.

Dengan demikian, konsep dasar komunikasi terapeutik mencakup pemahaman bahwa komunikasi dalam keperawatan adalah proses profesional yang bertujuan membantu pasien mencapai kondisi yang lebih baik. Komunikasi terapeutik berbeda dari komunikasi sosial karena memiliki tujuan yang jelas, berfokus pada pasien, menjaga batas profesional, dan menjadi bagian dari asuhan keperawatan. Unsur komunikasi terapeutik meliputi perawat, pasien, pesan, media, umpan balik, dan lingkungan komunikasi yang semuanya saling memengaruhi. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh keluarga dan

perawat. Melalui komunikasi terapeutik, perawat dapat membangun hubungan saling percaya, memenuhi kebutuhan psikologis pasien, serta mendukung proses penyembuhan secara holistik.

C. Prinsip dan Tahapan Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik dalam keperawatan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena komunikasi ini memiliki tujuan profesional untuk membantu pasien mencapai kondisi yang lebih baik. Agar komunikasi dapat memberikan manfaat terapeutik, perawat perlu memahami prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap interaksi dengan pasien. Prinsip tersebut meliputi empati, penerimaan, kejujuran, keterbukaan, saling menghargai, menjaga kerahasiaan, serta sikap tidak menghakimi. Prinsip-prinsip ini sangat penting karena pasien yang sedang dirawat sering berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik maupun psikologis. Pasien dapat merasa takut, cemas, bingung, marah, malu, atau tidak berdaya sehingga membutuhkan pendekatan komunikasi yang menenangkan dan memberi rasa aman.

Empati merupakan salah satu prinsip utama dalam komunikasi terapeutik. Empati berarti kemampuan perawat untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman pasien dari sudut pandang pasien, tanpa kehilangan sikap profesional. Dengan empati, perawat tidak hanya mendengarkan kata-kata pasien, tetapi juga berusaha memahami makna emosional di balik perkataan tersebut. Misalnya, ketika pasien marah atau menolak tindakan, perawat tidak langsung menilai pasien sebagai sulit diatur, tetapi mencoba memahami kemungkinan penyebabnya, seperti rasa takut, nyeri, kurang informasi, atau pengalaman buruk sebelumnya. Sikap empatik dapat ditunjukkan melalui nada suara yang tenang, ekspresi wajah yang bersahabat, posisi tubuh yang terbuka, serta respons verbal yang menunjukkan bahwa perawat memahami perasaan pasien.

Penerimaan juga menjadi prinsip penting dalam komunikasi terapeutik. Penerimaan berarti perawat menerima pasien sebagai individu yang memiliki nilai, martabat, pengalaman, dan kebutuhan yang unik. Penerimaan tidak berarti menyetujui semua perilaku pasien, terutama jika perilaku tersebut membahayakan, tetapi menunjukkan bahwa perawat tetap menghargai pasien sebagai manusia. Dalam praktiknya, perawat mungkin menghadapi pasien yang gelisah, marah, menangis, menarik diri, banyak bertanya, atau menunjukkan perilaku yang sulit dipahami. Pada situasi tersebut, perawat perlu tetap menunjukkan sikap menerima, tidak memperlakukan pasien, dan tidak menunjukkan penolakan. Dengan adanya penerimaan, pasien akan merasa lebih aman untuk mengungkapkan perasaan dan masalah yang dialaminya.

Kejujuran merupakan dasar dalam membangun kepercayaan antara perawat dan pasien. Pasien membutuhkan informasi yang benar mengenai kondisi, tindakan, prosedur, maupun rencana perawatan yang akan dijalani. Perawat perlu menyampaikan informasi secara jujur, tetapi tetap dengan cara yang bijaksana dan sesuai dengan kemampuan pasien dalam menerima informasi. Kejujuran tidak berarti menyampaikan informasi secara kasar atau menakutkan, melainkan menjelaskan sesuatu secara jelas, sederhana, dan tidak memberikan harapan palsu. Misalnya, ketika pasien bertanya tentang tindakan yang akan dilakukan, perawat perlu menjelaskan tujuan, proses, dan kemungkinan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan. Kejujuran seperti ini membantu pasien merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses perawatan.

Keterbukaan dalam komunikasi terapeutik berkaitan dengan kesediaan perawat untuk berkomunikasi secara jelas, tidak manipulatif, dan tidak menutupi informasi yang seharusnya diketahui pasien. Keterbukaan juga berarti perawat memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan mengungkapkan kekhawatiran. Pasien yang merasa diberi ruang untuk berbicara akan lebih mudah menjalin hubungan saling percaya dengan perawat. Namun, keterbukaan tetap harus berada dalam batas profesional. Perawat tidak perlu menceritakan masalah pribadi secara berlebihan, karena fokus komunikasi terapeutik tetap berada pada kebutuhan pasien. Keterbukaan yang tepat akan membuat komunikasi menjadi lebih sehat, jelas, dan mendukung proses penyembuhan.

Prinsip saling menghargai juga sangat penting dalam komunikasi terapeutik. Setiap pasien memiliki latar belakang budaya, pendidikan, agama, kebiasaan, pengalaman, dan nilai hidup yang berbeda. Perawat perlu menghargai perbedaan tersebut dalam berkomunikasi. Penghargaan dapat ditunjukkan dengan memanggil pasien menggunakan nama yang disukai, mendengarkan tanpa memotong, menggunakan bahasa yang sopan, menjaga privasi, dan tidak merendahkan pendapat pasien. Sikap saling menghargai membantu menciptakan hubungan yang setara secara kemanusiaan, meskipun secara profesional perawat memiliki peran sebagai pemberi asuhan. Ketika pasien merasa dihargai, ia akan lebih mudah bekerja sama dalam proses perawatan.

Menjaga kerahasiaan informasi pasien merupakan prinsip etik yang sangat penting dalam komunikasi terapeutik. Selama proses perawatan, pasien dapat menyampaikan informasi pribadi, seperti riwayat penyakit, masalah keluarga, pengalaman traumatis, kondisi psikologis, kebiasaan hidup, atau hal-hal sensitif lainnya. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Perawat tidak boleh membicarakan

kondisi pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan, baik di lingkungan pelayanan maupun di luar tempat kerja. Menjaga kerahasiaan bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak pasien. Jika kerahasiaan dilanggar, pasien dapat kehilangan kepercayaan, merasa malu, dan enggan terbuka dalam komunikasi berikutnya.

Meskipun demikian, terdapat kondisi tertentu ketika informasi pasien perlu disampaikan kepada tim kesehatan, terutama jika berkaitan dengan keselamatan pasien atau orang lain. Misalnya, jika pasien menyampaikan keinginan untuk bunuh diri, rencana melukai orang lain, atau menunjukkan risiko kekerasan, perawat perlu menyampaikan informasi tersebut kepada tim yang berwenang sesuai prosedur. Tindakan ini bukan pelanggaran kerahasiaan, melainkan bagian dari upaya menjaga keselamatan. Namun, penyampaian informasi tetap harus dilakukan secara profesional, terbatas pada pihak yang berkepentingan, dan tidak disebarluaskan secara tidak perlu.

Sikap tidak menghakimi, tidak menyalahkan, dan tidak merendahkan pasien merupakan prinsip yang harus dijaga dalam setiap komunikasi terapeutik. Pasien yang sedang sakit atau mengalami masalah psikologis sering kali berada dalam kondisi emosional yang sensitif. Jika perawat menunjukkan sikap menghakimi, pasien dapat merasa ditolak, malu, marah, atau semakin menutup diri. Misalnya, ketika pasien tidak patuh minum obat, perawat sebaiknya tidak langsung menyalahkan dengan kalimat yang menyudutkan. Perawat perlu menggali alasan ketidakpatuhan tersebut, apakah karena tidak memahami aturan minum obat, takut efek samping, merasa sudah sembuh, tidak memiliki dukungan keluarga, atau mengalami hambatan ekonomi. Dengan pendekatan yang tidak menyalahkan, perawat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan membantu pasien menemukan solusi yang lebih tepat.

Sikap tidak merendahkan pasien juga perlu diterapkan dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Kadang-kadang pasien dapat merasa direndahkan bukan hanya dari kata-kata, tetapi juga dari nada suara, ekspresi wajah, atau sikap tubuh perawat. Misalnya, perawat yang berbicara dengan nada sinis, menghela napas, memutar mata, atau tertawa saat pasien menyampaikan keluhan dapat membuat pasien merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, perawat harus menyadari bahwa komunikasi nonverbal memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi pasien terhadap hubungan terapeutik. Sikap yang tenang, sopan, dan menghargai akan memperkuat kepercayaan pasien kepada perawat.

Selain memahami prinsip-prinsipnya, perawat juga perlu memahami tahapan komunikasi terapeutik. Tahapan ini membantu perawat melakukan komunikasi secara terarah dan sistematis. Komunikasi terapeutik umumnya terdiri atas fase

pra-interaksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Setiap fase memiliki tujuan dan kegiatan yang berbeda, tetapi saling berhubungan satu sama lain. Jika salah satu fase tidak dilakukan dengan baik, komunikasi terapeutik dapat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, perawat perlu menjalankan setiap fase dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab profesional.

Fase pra-interaksi merupakan tahap persiapan sebelum perawat bertemu langsung dengan pasien. Pada fase ini, perawat mempersiapkan diri secara pengetahuan, emosional, dan sikap. Perawat perlu mempelajari informasi awal tentang pasien, seperti identitas, keluhan utama, diagnosis medis atau keperawatan, kondisi psikologis, riwayat perawatan, serta kemungkinan risiko yang perlu diperhatikan. Persiapan ini membantu perawat memahami gambaran awal kondisi pasien sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan lebih tepat. Namun, perawat tetap harus berhati-hati agar tidak membentuk prasangka sebelum bertemu pasien. Informasi awal hanya digunakan sebagai panduan, bukan sebagai dasar untuk menilai pasien secara sepihak.

Pada fase pra-interaksi, perawat juga perlu mempersiapkan diri secara emosional. Perawat harus menyadari perasaan, pengalaman, atau prasangka pribadi yang mungkin memengaruhi cara berkomunikasi dengan pasien. Misalnya, jika perawat merasa cemas menghadapi pasien yang marah atau agresif, perawat perlu mengenali kecemasan tersebut dan menyiapkan strategi agar tetap tenang. Kesadaran diri sangat penting dalam komunikasi terapeutik karena perawat yang tidak mampu mengendalikan emosi dapat memberikan respons yang kurang tepat. Fase pra-interaksi juga mencakup persiapan lingkungan, seperti memilih tempat yang aman, nyaman, cukup privasi, dan sesuai dengan kondisi pasien.

Fase orientasi merupakan tahap awal pertemuan antara perawat dan pasien. Pada fase ini, perawat mulai membangun hubungan saling percaya. Perawat dapat memperkenalkan diri, menjelaskan peran, menyebutkan tujuan interaksi, serta membuat kontrak komunikasi dengan pasien. Kontrak komunikasi dapat mencakup waktu, tempat, topik, dan tujuan pembicaraan. Misalnya, perawat menjelaskan bahwa ia ingin berbicara selama beberapa menit untuk mengetahui keluhan pasien dan membantu pasien merasa lebih nyaman. Penjelasan seperti ini penting karena pasien akan lebih tenang jika mengetahui apa yang akan dilakukan dan mengapa komunikasi tersebut diperlukan.

Pada fase orientasi, perawat juga perlu mengamati respons awal pasien. Ada pasien yang langsung terbuka, tetapi ada juga pasien yang tampak diam, curiga, takut, atau menolak berbicara. Perawat tidak boleh memaksa pasien secara kasar. Jika pasien belum siap, perawat dapat memberikan waktu, menunjukkan sikap menerima, dan mencoba membangun kenyamanan secara bertahap. Fase orientasi

menjadi fondasi bagi fase berikutnya. Jika pada tahap ini pasien merasa aman dan percaya, maka komunikasi pada fase kerja akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, jika fase orientasi gagal, pasien mungkin akan menolak, memberikan informasi yang tidak lengkap, atau tidak mau bekerja sama.

Fase kerja merupakan inti dari komunikasi terapeutik. Pada fase ini, perawat mulai menggali masalah, perasaan, kebutuhan, dan respons pasien secara lebih mendalam. Perawat menggunakan berbagai teknik komunikasi terapeutik, seperti mendengarkan aktif, pertanyaan terbuka, klarifikasi, refleksi, validasi, diam terapeutik, dan pemberian informasi. Dalam fase kerja, pasien diberi kesempatan untuk menceritakan pengalaman, mengungkapkan perasaan, dan menjelaskan kebutuhan yang dirasakan. Perawat membantu pasien memahami masalah yang dialami, mengenali respons emosional, serta mencari cara yang lebih adaptif untuk menghadapi situasi.

Fase kerja membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik karena pada tahap ini sering muncul berbagai respons pasien. Pasien dapat menangis, marah, bingung, diam, atau mengungkapkan hal-hal yang sensitif. Perawat perlu menjaga sikap tenang dan tetap fokus pada kebutuhan pasien. Jika pasien menyampaikan perasaan takut, perawat dapat membantu mengidentifikasi penyebab ketakutan tersebut. Jika pasien marah, perawat dapat mendengarkan tanpa membalas dengan kemarahan. Jika pasien bingung, perawat dapat memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana. Pada fase ini, perawat juga dapat membantu pasien mengembangkan kemampuan koping, meningkatkan pemahaman tentang kondisi kesehatan, dan mempersiapkan pasien untuk menerima tindakan keperawatan atau pengobatan.

Dalam konteks teknik de-eskalasi, fase kerja menjadi sangat penting karena perawat perlu menggali penyebab ketegangan pasien dan membantu menurunkan emosi secara bertahap. Perawat dapat menanyakan apa yang membuat pasien marah atau gelisah, mengakui perasaan pasien, memberikan pilihan sederhana, dan membantu pasien merasa tetap memiliki kontrol. Pada saat yang sama, perawat harus tetap memperhatikan keselamatan, menjaga jarak aman, dan menghindari sikap yang dapat memicu peningkatan emosi. Fase kerja dalam situasi de-eskalasi tidak hanya bertujuan menggali masalah, tetapi juga membantu pasien kembali tenang dan mampu berpikir lebih jernih.

Fase terminasi merupakan tahap mengakhiri pertemuan atau hubungan komunikasi secara terapeutik. Terminasi tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba, karena pasien dapat merasa ditinggalkan atau tidak dihargai. Pada fase ini, perawat perlu memberikan tanda bahwa waktu komunikasi akan segera berakhir, merangkum hasil pembicaraan, mengevaluasi perasaan pasien setelah

berkomunikasi, serta menyepakati tindak lanjut jika diperlukan. Misalnya, perawat dapat mengatakan bahwa waktu pertemuan hampir selesai, kemudian menyampaikan kembali hal-hal penting yang telah dibicarakan dan menanyakan bagaimana perasaan pasien setelah berbicara. Cara ini membantu pasien memahami bahwa komunikasi telah berjalan dengan tujuan yang jelas dan diakhiri secara baik.

Fase terminasi juga penting untuk mengevaluasi keberhasilan komunikasi. Perawat perlu menilai apakah pasien tampak lebih tenang, lebih memahami informasi yang diberikan, lebih mampu mengungkapkan perasaan, atau lebih siap mengikuti rencana perawatan. Jika tujuan komunikasi belum tercapai, perawat dapat merencanakan pertemuan berikutnya. Terminasi juga dapat digunakan untuk memberikan penguatan positif kepada pasien, misalnya menghargai keberanian pasien untuk bercerita atau bekerja sama selama interaksi. Penguatan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri pasien dan memperkuat hubungan terapeutik.

Dalam praktik keperawatan, terminasi dapat bersifat sementara atau akhir. Terminasi sementara terjadi ketika perawat mengakhiri satu sesi komunikasi tetapi masih akan bertemu pasien pada kesempatan berikutnya. Sementara itu, terminasi akhir terjadi ketika hubungan perawatan akan berakhir, misalnya pasien pulang, pindah ruangan, atau perawat selesai bertugas dalam periode tertentu. Pada terminasi akhir, perawat perlu membantu pasien mempersiapkan diri, menyampaikan rencana tindak lanjut, dan memastikan pasien memahami hal-hal yang perlu dilakukan setelah hubungan terapeutik berakhir. Terminasi yang baik dapat mencegah rasa kehilangan, kebingungan, atau ketergantungan yang tidak sehat.

Prinsip dan tahapan komunikasi terapeutik merupakan dasar penting dalam membangun hubungan profesional antara perawat dan pasien. Prinsip empati, penerimaan, kejujuran, keterbukaan, saling menghargai, kerahasiaan, serta sikap tidak menghakimi harus diterapkan dalam setiap interaksi. Sementara itu, tahapan komunikasi terapeutik yang terdiri atas fase pra-interaksi, orientasi, kerja, dan terminasi membantu perawat menjalankan komunikasi secara sistematis dan terarah. Jika prinsip dan tahapan ini diterapkan dengan baik, komunikasi terapeutik dapat menjadi sarana yang efektif untuk menggali masalah pasien, menurunkan kecemasan, meningkatkan kerja sama, mencegah konflik, serta mendukung proses penyembuhan dan mutu asuhan keperawatan.

D. Teknik Komunikasi Terapeutik dalam Keperawatan

Teknik komunikasi terapeutik dalam keperawatan merupakan keterampilan yang digunakan perawat untuk membangun hubungan profesional, menggali kebutuhan pasien, membantu pasien mengungkapkan perasaan, serta mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh. Komunikasi terapeutik tidak hanya bergantung pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada kemampuan mendengarkan, memahami, merespons, dan memberikan dukungan secara tepat. Dalam praktik keperawatan, setiap pasien memiliki pengalaman, emosi, tingkat pemahaman, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, perawat perlu menggunakan teknik komunikasi yang sesuai agar pasien merasa aman, dihargai, dan bersedia terlibat dalam proses perawatan.

Salah satu teknik utama dalam komunikasi terapeutik adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif berarti perawat memberikan perhatian penuh kepada pasien, baik terhadap kata-kata yang diucapkan maupun pesan nonverbal yang ditunjukkan melalui ekspresi wajah, nada suara, gerakan tubuh, kontak mata, dan sikap pasien. Mendengarkan aktif berbeda dengan sekadar mendengar. Ketika perawat mendengarkan secara aktif, perawat tidak hanya menangkap suara atau ucapan pasien, tetapi juga berusaha memahami makna, perasaan, dan kebutuhan yang tersembunyi di balik ucapan tersebut. Pasien yang merasa didengarkan biasanya akan lebih mudah terbuka, lebih percaya kepada perawat, dan lebih mampu mengungkapkan keluhan atau masalah yang dialaminya.

Dalam pelaksanaan mendengarkan aktif, perawat perlu menunjukkan sikap hadir secara penuh. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pasien saat berbicara, tidak sibuk dengan hal lain, tidak memotong pembicaraan secara terburu-buru, dan memberikan respons yang menunjukkan perhatian. Perawat dapat menggunakan anggukan, kontak mata yang wajar, ekspresi wajah yang empatik, serta kalimat singkat seperti "saya mengerti", "silakan lanjutkan", atau "saya mendengarkan". Sikap seperti ini dapat membuat pasien merasa bahwa ceritanya penting dan tidak diabaikan. Mendengarkan aktif sangat bermanfaat ketika pasien sedang mengalami kecemasan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, atau kebingungan, karena pasien membutuhkan ruang untuk mengungkapkan perasaan tanpa merasa dihakimi.

Selain mendengarkan aktif, perawat juga perlu menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memungkinkan pasien menjawab secara luas sesuai pengalaman dan perasaannya. Pertanyaan seperti ini biasanya tidak cukup dijawab dengan "ya" atau "tidak", tetapi mendorong pasien untuk bercerita lebih banyak. Misalnya, perawat dapat bertanya, "Apa yang Bapak rasakan saat ini?", "Bagaimana pengalaman Ibu selama menjalani perawatan?",

atau “Apa yang membuat Bapak merasa cemas?” Pertanyaan terbuka membantu perawat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi pasien, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun emosional.

Pertanyaan terbuka juga memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan sudut pandangnya sendiri. Dalam asuhan keperawatan, pengalaman subjektif pasien sangat penting karena tidak semua masalah dapat terlihat secara langsung. Pasien mungkin tampak tenang, tetapi sebenarnya menyimpan rasa takut atau kebingungan. Pasien mungkin tampak marah, tetapi kemarahan tersebut berasal dari rasa nyeri, kecewa, atau tidak memahami prosedur yang akan dilakukan. Dengan pertanyaan terbuka, perawat dapat menggali lebih jauh apa yang sebenarnya dialami pasien. Namun, perawat perlu menggunakan pertanyaan terbuka secara bijaksana. Jika pasien tampak sangat lelah, gelisah, atau sulit berkonsentrasi, pertanyaan sebaiknya dibuat sederhana dan tidak terlalu panjang agar pasien tidak merasa terbebani.

Teknik berikutnya adalah klarifikasi. Klarifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa perawat memahami makna pernyataan pasien dengan benar. Dalam komunikasi, sering kali terjadi perbedaan pemahaman antara apa yang dimaksud pasien dan apa yang ditangkap oleh perawat. Pasien dapat menggunakan kata-kata yang tidak jelas, berbicara dengan emosi tinggi, atau menyampaikan pernyataan yang memiliki banyak kemungkinan makna. Pada situasi tersebut, perawat perlu melakukan klarifikasi agar tidak salah menafsirkan informasi. Misalnya, ketika pasien mengatakan, “Saya sudah tidak kuat lagi,” perawat tidak boleh langsung menyimpulkan maknanya. Perawat dapat mengklarifikasi dengan bertanya, “Maksud Bapak tidak kuat karena nyeri, karena lelah, atau karena merasa tertekan?” Dengan klarifikasi, perawat dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat.

Klarifikasi juga penting untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan keperawatan. Data yang tidak jelas dapat menyebabkan perawat salah menentukan masalah, salah memberikan intervensi, atau tidak memahami kebutuhan pasien secara tepat. Misalnya, jika pasien mengatakan “obat itu membuat saya tidak enak”, perawat perlu menggali lebih lanjut apakah yang dimaksud adalah mual, pusing, mengantuk, jantung berdebar, atau perasaan takut terhadap obat. Dengan demikian, klarifikasi membantu perawat memperoleh data yang lebih spesifik dan dapat dipertanggungjawabkan. Klarifikasi juga menunjukkan kepada pasien bahwa perawat benar-benar memperhatikan ucapannya dan ingin memahami dengan tepat, bukan sekadar mendengar secara sepintas.

Validasi merupakan teknik komunikasi terapeutik yang bertujuan mengakui perasaan atau pengalaman pasien. Validasi tidak selalu berarti membenarkan semua pikiran atau perilaku pasien, tetapi menunjukkan bahwa perawat memahami perasaan yang sedang dialami pasien. Misalnya, ketika pasien merasa marah karena harus menunggu lama, perawat dapat mengatakan, "Saya memahami Bapak merasa kesal karena harus menunggu." Kalimat tersebut menunjukkan bahwa perawat menerima perasaan pasien sebagai sesuatu yang nyata bagi pasien. Namun, jika pasien mengekspresikan kemarahan dengan berteriak atau mengancam, perawat tetap perlu memberikan batasan bahwa perilaku agresif tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, perawat mengakui perasaan pasien tanpa membenarkan perilaku yang tidak adaptif.

Validasi sangat penting dalam hubungan terapeutik karena banyak pasien merasa emosinya tidak dipahami oleh orang lain. Pasien yang merasa takut, malu, kecewa, atau marah sering kali membutuhkan pengakuan terhadap perasaannya sebelum mampu menerima penjelasan atau arahan. Jika perawat langsung menasihati tanpa terlebih dahulu mengakui perasaan pasien, pasien dapat merasa diabaikan atau tidak dihargai. Validasi membantu menurunkan ketegangan emosional dan membuka jalan untuk komunikasi yang lebih konstruktif. Dalam konteks de-eskalasi, validasi menjadi teknik penting untuk meredakan emosi pasien. Ketika pasien merasa perasaannya didengar, ia cenderung lebih mudah diarahkan dan lebih mampu mengendalikan responsnya.

Refleksi juga merupakan teknik komunikasi terapeutik yang penting. Refleksi dilakukan dengan cara mengembalikan atau mencerminkan kembali perasaan, pikiran, atau isi pembicaraan pasien agar pasien dapat lebih menyadari apa yang sedang dialaminya. Misalnya, jika pasien berkata, "Saya takut operasi ini gagal," perawat dapat merespons, "Bapak merasa takut karena khawatir operasi tidak berjalan sesuai harapan." Respons ini membantu pasien mengenali bahwa perasaan utama yang muncul adalah rasa takut dan kekhawatiran. Refleksi tidak bertujuan mengulang kata-kata pasien secara mekanis, tetapi membantu pasien memahami perasaannya dengan lebih jelas.

Refleksi sangat bermanfaat ketika pasien sulit mengungkapkan emosi secara langsung. Ada pasien yang menyampaikan masalah melalui keluhan fisik, kemarahan, diam, atau penolakan, padahal di baliknya terdapat rasa takut, cemas, atau sedih. Dengan refleksi, perawat dapat membantu pasien menghubungkan pengalaman dengan perasaan yang muncul. Teknik ini juga membantu pasien berpikir lebih dalam mengenai masalahnya. Misalnya, ketika pasien mengatakan bahwa ia selalu menolak minum obat karena merasa bosan, perawat dapat merefleksikan, "Ibu merasa lelah menjalani pengobatan yang harus dilakukan

terus-menerus.” Refleksi seperti ini dapat membuat pasien merasa dipahami dan mendorongnya untuk membicarakan hambatan yang sebenarnya.

Diam terapeutik merupakan teknik komunikasi yang sering kali sulit dilakukan, tetapi memiliki nilai yang besar. Diam terapeutik berarti perawat memberikan waktu kepada pasien untuk berpikir, merasakan, atau menenangkan diri tanpa terburu-buru mengisi keheningan dengan pertanyaan atau nasihat. Dalam komunikasi sehari-hari, diam sering dianggap sebagai kecanggungan. Namun, dalam komunikasi terapeutik, diam dapat menjadi ruang yang membantu pasien memproses pikiran dan emosi. Setelah pasien menyampaikan pengalaman yang berat, menangis, atau tampak bingung, perawat tidak harus segera berbicara. Kehadiran perawat yang tenang, disertai sikap empatik, dapat memberikan dukungan emosional meskipun tanpa banyak kata.

Diam terapeutik juga dapat membantu pasien merasa tidak dipaksa. Beberapa pasien membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun kata-kata, terutama ketika membicarakan pengalaman yang sensitif, menyakitkan, atau memalukan. Jika perawat terlalu cepat bertanya atau memotong keheningan, pasien dapat merasa tertekan. Namun, diam terapeutik harus digunakan dengan tepat. Perawat tetap perlu menunjukkan kehadiran melalui bahasa tubuh yang mendukung, seperti duduk dengan tenang, menjaga kontak mata yang wajar, dan tidak menunjukkan ekspresi bosan. Jika diam berlangsung terlalu lama dan pasien tampak semakin cemas, perawat dapat memberikan dorongan lembut, misalnya dengan mengatakan, “Tidak apa-apa, Bapak bisa bercerita pelan-pelan.”

Memberikan informasi secara jelas, sederhana, dan sesuai kebutuhan pasien juga merupakan bagian penting dari komunikasi terapeutik. Pasien dan keluarga sering mengalami kecemasan karena tidak memahami kondisi, tindakan, obat, prosedur, atau rencana perawatan yang akan dilakukan. Perawat berperan memberikan informasi yang benar agar pasien dapat memahami situasinya dan merasa lebih siap. Informasi yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, usia, budaya, kondisi emosi, dan kemampuan pasien dalam memahami pesan. Penggunaan istilah medis yang sulit sebaiknya dihindari atau dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya, daripada hanya mengatakan “tekanan darah Bapak hipertensi,” perawat dapat menjelaskan bahwa tekanan darah pasien lebih tinggi dari batas normal dan perlu dipantau serta dikendalikan.

Informasi yang diberikan juga tidak boleh berlebihan. Pasien yang sedang cemas atau nyeri mungkin tidak mampu menerima terlalu banyak informasi sekaligus. Oleh karena itu, perawat perlu menyampaikan informasi secara bertahap, mulai dari hal yang paling penting. Perawat juga perlu memastikan

apakah pasien memahami informasi tersebut dengan meminta pasien mengulang kembali inti penjelasan menggunakan bahasanya sendiri. Cara ini membantu perawat menilai apakah komunikasi sudah efektif. Pemberian informasi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pasien, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan keterlibatan pasien dalam perawatan. Sebaliknya, informasi yang tidak jelas dapat menimbulkan salah paham, ketakutan, dan penolakan terhadap tindakan.

Teknik terakhir yang juga penting adalah menyimpulkan pembicaraan. Menyimpulkan berarti merangkum isi komunikasi agar pasien dan perawat memiliki pemahaman yang sama mengenai hal-hal yang telah dibicarakan. Teknik ini biasanya dilakukan pada akhir interaksi atau setelah pembicaraan panjang. Misalnya, setelah pasien menceritakan keluhan dan kekhawatirannya, perawat dapat mengatakan, "Jadi, hari ini Bapak merasa nyeri, sulit tidur, dan khawatir dengan hasil pemeriksaan. Kita sudah membicarakan cara mengurangi nyeri dan Bapak setuju untuk mencoba latihan napas dalam." Kesimpulan seperti ini membantu memastikan bahwa perawat memahami pesan pasien dengan benar dan pasien juga mengetahui rencana tindak lanjut.

Menyimpulkan pembicaraan juga membantu memberikan struktur dalam komunikasi. Pasien yang sedang cemas, bingung, atau banyak bercerita dapat merasa lebih tenang ketika pembicaraan dirangkum secara jelas. Teknik ini membantu pasien melihat kembali masalah yang telah dibahas dan langkah yang akan dilakukan. Selain itu, menyimpulkan juga membantu mencegah kesalahpahaman. Jika ada bagian yang kurang tepat, pasien dapat memperbaiki atau menambahkan informasi. Dalam dokumentasi keperawatan, hasil pembicaraan yang telah disimpulkan dapat menjadi dasar untuk mencatat data subjektif, respons pasien, dan rencana intervensi.

Dalam praktiknya, teknik-teknik komunikasi terapeutik tidak digunakan secara terpisah, melainkan saling melengkapi. Perawat dapat memulai dengan mendengarkan aktif, kemudian menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali masalah, melakukan klarifikasi untuk memastikan makna, memberikan validasi terhadap perasaan pasien, menggunakan refleksi agar pasien lebih menyadari emosinya, memberi waktu melalui diam terapeutik, menyampaikan informasi yang dibutuhkan, dan menutup interaksi dengan menyimpulkan pembicaraan. Kombinasi teknik ini membuat komunikasi menjadi lebih terarah, manusiawi, dan efektif. Perawat perlu menyesuaikan teknik yang digunakan dengan kondisi pasien, tujuan komunikasi, dan situasi pelayanan.

Teknik komunikasi terapeutik juga sangat penting dalam menghadapi pasien yang mengalami emosi tidak stabil, seperti marah, gelisah, takut, atau cemas.

Dalam situasi tersebut, perawat perlu lebih banyak mendengarkan, memvalidasi perasaan, menggunakan suara yang tenang, dan memberikan informasi secara sederhana. Perawat harus menghindari sikap menggurui, menyalahkan, memerintah secara kasar, atau memotong pembicaraan pasien. Teknik komunikasi yang tepat dapat membantu menurunkan ketegangan dan mencegah terjadinya konflik. Dengan demikian, komunikasi terapeutik juga menjadi dasar dalam teknik de-eskalasi karena membantu pasien merasa lebih aman dan lebih mampu mengendalikan emosi.

teknik komunikasi terapeutik dalam keperawatan meliputi kemampuan mendengarkan aktif, menggunakan pertanyaan terbuka, melakukan klarifikasi, memberikan validasi, menggunakan refleksi, menerapkan diam terapeutik, memberikan informasi secara jelas, serta menyimpulkan pembicaraan. Setiap teknik memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan membantu pasien merasa dipahami, memperoleh informasi yang tepat, mengenali perasaan, dan terlibat dalam proses perawatan. Perawat yang menguasai teknik komunikasi terapeutik akan lebih mampu membangun hubungan saling percaya, menggali kebutuhan pasien secara akurat, mencegah kesalahpahaman, menurunkan kecemasan, serta meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

E. Hambatan dalam Komunikasi Terapeutik

Hambatan dalam komunikasi terapeutik merupakan berbagai faktor yang dapat mengganggu kelancaran, ketepatan, dan keberhasilan interaksi antara perawat dan pasien. Komunikasi terapeutik seharusnya menjadi sarana untuk membangun hubungan saling percaya, menggali kebutuhan pasien, memberikan dukungan emosional, serta membantu proses penyembuhan. Namun, dalam praktik keperawatan, komunikasi tidak selalu berjalan dengan mudah. Hambatan dapat muncul dari pihak perawat, pasien, lingkungan, maupun perbedaan budaya, bahasa, nilai, dan keyakinan. Jika hambatan tersebut tidak dikenali dan tidak diatasi dengan baik, hubungan terapeutik dapat terganggu, pasien menjadi kurang kooperatif, informasi yang diperoleh menjadi tidak lengkap, dan asuhan keperawatan tidak dapat diberikan secara optimal.

Salah satu hambatan yang sering muncul berasal dari perawat. Dalam pelayanan kesehatan yang sibuk, perawat sering dihadapkan pada beban kerja yang tinggi, jumlah pasien yang banyak, waktu yang terbatas, serta tuntutan administratif yang harus diselesaikan. Kondisi ini dapat membuat perawat terburu-buru saat berkomunikasi dengan pasien. Perawat mungkin hanya berfokus pada penyelesaian tugas, seperti pemberian obat, pengukuran tanda vital, atau dokumentasi, tanpa memberikan waktu yang cukup untuk mendengarkan keluhan

dan perasaan pasien. Komunikasi yang dilakukan secara tergesa-gesa dapat membuat pasien merasa diabaikan, tidak dihargai, atau dianggap sebagai objek tindakan semata. Padahal, bagi pasien, kesempatan untuk didengarkan sering kali sama pentingnya dengan tindakan klinis yang diberikan.

Kurangnya empati juga menjadi hambatan besar dalam komunikasi terapeutik. Empati merupakan kemampuan perawat untuk memahami perasaan dan pengalaman pasien dari sudut pandang pasien. Jika perawat kurang empati, respons yang diberikan dapat terasa dingin, kaku, atau tidak menyentuh kebutuhan emosional pasien. Misalnya, ketika pasien mengatakan takut terhadap tindakan medis, perawat yang kurang empati mungkin menjawab dengan kalimat singkat seperti "tidak usah takut" tanpa menggali penyebab ketakutan tersebut. Meskipun kalimat tersebut tampak sederhana, pasien dapat merasa bahwa perasaannya tidak dipahami. Sebaliknya, komunikasi terapeutik membutuhkan respons yang mengakui perasaan pasien, seperti memahami bahwa pasien merasa takut, lalu memberikan penjelasan dan dukungan yang sesuai.

Kurang sabar juga dapat menghambat komunikasi antara perawat dan pasien. Beberapa pasien membutuhkan waktu lebih lama untuk menjelaskan keluhan, terutama pasien lanjut usia, pasien dengan gangguan pendengaran, pasien dengan gangguan kognitif, pasien yang cemas, atau pasien yang sedang mengalami tekanan emosional. Jika perawat tidak sabar, perawat mungkin memotong pembicaraan, menyelesaikan kalimat pasien, menunjukkan ekspresi terganggu, atau memberikan respons yang terburu-buru. Sikap seperti ini dapat membuat pasien enggan melanjutkan pembicaraan. Dalam komunikasi terapeutik, kesabaran merupakan sikap penting karena perawat perlu memberikan ruang kepada pasien untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya dengan cara yang mampu dilakukan pasien.

Penggunaan istilah medis yang sulit dipahami juga menjadi hambatan dari pihak perawat. Perawat sering terbiasa menggunakan istilah kesehatan dalam lingkungan kerja, seperti diagnosis, prognosis, hipertensi, hipoglikemia, efek samping, prosedur invasif, atau istilah lain yang belum tentu dipahami pasien dan keluarga. Jika istilah tersebut digunakan tanpa penjelasan, pasien dapat merasa bingung, takut, atau salah memahami informasi. Misalnya, pasien yang tidak memahami istilah medis tertentu dapat menafsirkan kondisinya lebih buruk dari keadaan sebenarnya, atau sebaliknya menganggap remeh masalah kesehatan yang dialami. Oleh karena itu, perawat perlu menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman pasien, menggunakan kata-kata sederhana, serta memastikan pasien memahami informasi yang diberikan.

Hambatan komunikasi juga dapat berasal dari pasien. Pasien yang sedang sakit sering kali berada dalam kondisi fisik dan emosional yang tidak stabil. Rasa cemas, takut, nyeri, marah, sedih, bingung, atau tidak berdaya dapat memengaruhi kemampuan pasien untuk menerima dan menyampaikan informasi. Pasien yang cemas mungkin sulit berkonsentrasi, sering mengulang pertanyaan, atau tidak mampu menangkap penjelasan perawat dengan baik. Pasien yang takut mungkin memilih diam, menghindari kontak mata, atau menolak menjawab pertanyaan. Pasien yang sedang marah dapat berbicara dengan nada tinggi, menyalahkan tenaga kesehatan, atau menolak tindakan. Dalam situasi seperti ini, perawat perlu memahami bahwa respons pasien sering kali merupakan bentuk ekspresi dari tekanan yang sedang dialami, bukan semata-mata perilaku yang sengaja menyulitkan.

Kecurigaan juga dapat menjadi hambatan komunikasi, terutama pada pasien yang memiliki pengalaman buruk dengan pelayanan kesehatan, pasien dengan gangguan jiwa, atau pasien yang merasa tidak aman dalam lingkungan perawatan. Pasien yang curiga mungkin tidak percaya kepada perawat, menolak memberikan informasi, merasa bahwa tindakan perawat bertujuan menyakiti dirinya, atau menganggap penjelasan perawat sebagai ancaman. Dalam kondisi ini, perawat tidak dapat memaksa pasien untuk langsung terbuka. Perawat perlu membangun hubungan secara bertahap, memperkenalkan diri dengan jelas, menjelaskan tujuan tindakan, menggunakan nada suara yang tenang, serta menunjukkan konsistensi dalam sikap dan tindakan. Kepercayaan pasien biasanya tumbuh melalui pengalaman interaksi yang aman dan tidak mengancam.

Pasien yang menarik diri juga dapat menyulitkan komunikasi terapeutik. Menarik diri dapat terjadi karena pasien merasa malu, sedih, takut, depresi, kehilangan motivasi, atau tidak percaya bahwa orang lain dapat membantunya. Pasien mungkin menjawab pertanyaan dengan singkat, menunduk, menghindari percakapan, atau memilih diam. Dalam kondisi ini, perawat perlu menggunakan pendekatan yang lembut dan tidak memaksa. Diam pasien tidak selalu berarti penolakan, tetapi bisa menjadi tanda bahwa pasien membutuhkan waktu untuk merasa aman. Perawat dapat memulai dengan pertanyaan sederhana, menunjukkan kehadiran, memberikan waktu, dan menggunakan diam terapeutik. Tujuannya adalah membantu pasien merasa bahwa ia tidak dipaksa, tetapi tetap didampingi.

Kesulitan berkonsentrasi juga menjadi hambatan dari pihak pasien. Kondisi ini dapat terjadi akibat nyeri, kecemasan, gangguan tidur, efek obat, gangguan neurologis, gangguan jiwa, atau kelelahan fisik. Pasien yang sulit berkonsentrasi mungkin tidak mampu mengikuti penjelasan panjang, mudah terdistraksi, atau

lupa informasi yang baru saja diberikan. Oleh karena itu, perawat perlu menyampaikan informasi secara singkat, bertahap, dan mengulang poin penting bila diperlukan. Perawat juga dapat menggunakan alat bantu seperti tulisan, gambar, atau melibatkan keluarga untuk membantu pasien memahami dan mengingat informasi. Komunikasi yang disesuaikan dengan kemampuan konsentrasi pasien akan lebih efektif dibandingkan memaksakan penjelasan panjang dalam satu waktu.

Lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan komunikasi terapeutik. Ruangan yang bising, suasana yang ramai, banyak orang berlalu-lalang, suara alat medis, televisi yang keras, atau percakapan orang lain dapat mengganggu konsentrasi pasien dan perawat. Dalam kondisi seperti ini, pesan yang disampaikan dapat tidak terdengar jelas atau tidak dipahami dengan baik. Pasien juga dapat merasa tidak nyaman untuk membicarakan hal-hal pribadi apabila banyak orang di sekitarnya. Komunikasi terapeutik membutuhkan lingkungan yang mendukung, yaitu lingkungan yang cukup tenang, aman, dan memungkinkan pasien berbicara tanpa takut didengar oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Kurangnya privasi merupakan hambatan lingkungan yang sangat penting. Pasien sering kali harus menyampaikan informasi sensitif, seperti keluhan fisik tertentu, riwayat penyakit, masalah psikologis, konflik keluarga, pengalaman traumatis, atau kekhawatiran pribadi. Jika komunikasi dilakukan di tempat terbuka tanpa privasi, pasien mungkin tidak mau berbicara jujur atau hanya memberikan informasi yang sangat terbatas. Hal ini dapat mengganggu proses pengkajian dan membuat perawat tidak memperoleh data yang lengkap. Oleh karena itu, perawat perlu memperhatikan tempat komunikasi, menutup tirai bila diperlukan, menurunkan volume suara, atau memilih tempat yang lebih sesuai apabila pembicaraan bersifat pribadi.

Kondisi lingkungan yang tidak nyaman juga dapat menghambat komunikasi. Suhu ruangan yang terlalu panas atau dingin, pencahayaan yang kurang, tempat duduk yang tidak nyaman, posisi pasien yang nyeri, atau kondisi fisik pasien yang lemah dapat membuat pasien sulit fokus dalam berkomunikasi. Perawat perlu memastikan bahwa kebutuhan dasar pasien diperhatikan sebelum memulai komunikasi yang lebih mendalam. Misalnya, pasien yang sedang nyeri hebat mungkin tidak dapat menjelaskan masalahnya dengan baik sebelum nyerinya dikurangi. Pasien yang sesak napas tidak dapat diajak berbicara panjang. Dengan demikian, pengaturan kenyamanan fisik merupakan bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang efektif.

Perbedaan budaya, bahasa, nilai, dan keyakinan antara perawat dan pasien juga dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik. Setiap pasien membawa latar belakang budaya yang memengaruhi cara berbicara, cara mengekspresikan emosi, cara memahami penyakit, serta cara mengambil keputusan. Dalam beberapa budaya, pasien mungkin tidak terbiasa menyampaikan keluhan secara langsung, lebih memilih keluarga sebagai pengambil keputusan, atau memiliki keyakinan tertentu tentang penyebab penyakit dan pengobatan. Jika perawat tidak memahami perbedaan ini, perawat dapat salah menafsirkan sikap pasien. Misalnya, pasien yang diam dapat dianggap tidak kooperatif, padahal diam tersebut merupakan bentuk sopan santun atau rasa hormat menurut budayanya.

Perbedaan bahasa juga dapat menyebabkan kesalahpahaman. Pasien yang tidak memahami bahasa yang digunakan perawat mungkin memberikan jawaban yang tidak sesuai, mengangguk tanpa benar-benar memahami, atau merasa malu untuk bertanya. Hal ini dapat berbahaya, terutama ketika informasi yang disampaikan berkaitan dengan pengobatan, prosedur, persetujuan tindakan, atau perawatan lanjutan di rumah. Dalam situasi seperti ini, perawat perlu menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami pasien, berbicara perlahan, menggunakan kalimat sederhana, dan jika perlu melibatkan penerjemah atau anggota keluarga yang dapat membantu komunikasi tanpa melanggar privasi pasien. Perawat juga perlu memastikan pemahaman pasien dengan meminta pasien mengulang kembali informasi penting menggunakan bahasanya sendiri.

Perbedaan nilai dan keyakinan juga perlu diperhatikan. Pasien dapat memiliki pandangan tertentu tentang penyakit, pengobatan, nyeri, kematian, kesehatan jiwa, tindakan medis, atau peran keluarga. Ada pasien yang lebih mengutamakan pengobatan tradisional, ada yang memiliki keyakinan agama tertentu terkait prosedur kesehatan, dan ada pula yang merasa malu membicarakan masalah tertentu karena nilai budaya yang dianut. Perawat tidak boleh langsung menolak atau merendahkan keyakinan pasien. Sebaliknya, perawat perlu menggali makna keyakinan tersebut bagi pasien, memberikan informasi kesehatan secara bijaksana, dan mencari pendekatan yang tetap menghargai nilai pasien tanpa mengabaikan keselamatan dan kebutuhan klinis.

Komunikasi yang tidak efektif dapat berdampak negatif terhadap hubungan perawat dan pasien. Pasien dapat kehilangan kepercayaan, merasa tidak dihargai, tidak mau terbuka, menolak tindakan, atau menjadi kurang kooperatif. Hubungan yang seharusnya terapeutik dapat berubah menjadi hubungan yang penuh ketegangan. Dalam jangka panjang, komunikasi yang buruk dapat menurunkan kepuasan pasien terhadap pelayanan, meningkatkan risiko keluhan, memperpanjang proses perawatan, dan mengganggu keselamatan pasien.

Misalnya, pasien yang tidak memahami instruksi minum obat dapat menggunakan obat secara tidak tepat. Pasien yang tidak berani menyampaikan keluhan karena merasa perawat tidak peduli dapat mengalami keterlambatan penanganan.

Bagi perawat, komunikasi yang tidak efektif juga dapat menimbulkan dampak. Perawat dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh data, salah memahami kebutuhan pasien, kesulitan menyusun intervensi, dan menghadapi konflik dengan pasien atau keluarga. Situasi ini dapat meningkatkan stres kerja dan menurunkan kualitas asuhan. Komunikasi yang tidak efektif juga dapat mengganggu kerja sama tim, terutama jika informasi penting tidak disampaikan atau didokumentasikan dengan jelas. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan pasien, tetapi juga berhubungan langsung dengan mutu pelayanan dan keselamatan dalam praktik keperawatan.

Untuk mengatasi hambatan komunikasi terapeutik, perawat perlu menggunakan pendekatan empatik. Pendekatan empatik berarti perawat berusaha memahami kondisi pasien, mengakui perasaan pasien, dan merespons dengan sikap yang mendukung. Pasien yang cemas, marah, atau takut sering kali membutuhkan pengakuan terhadap perasaannya sebelum mampu menerima informasi atau arahan. Kalimat seperti "Saya memahami Ibu merasa khawatir" atau "Bapak tampak sangat tidak nyaman, mari kita bicarakan pelan-pelan" dapat membantu menurunkan ketegangan. Empati membuat pasien merasa tidak sendirian dan membuka peluang komunikasi yang lebih baik.

Penggunaan bahasa sederhana juga merupakan strategi penting. Perawat perlu menghindari istilah medis yang sulit dipahami, menjelaskan informasi secara bertahap, dan memastikan pasien memahami pesan yang diberikan. Jika pasien tampak bingung, perawat dapat mengulang informasi dengan kalimat berbeda atau menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, perawat dapat menggunakan media bantu seperti gambar, tulisan, atau demonstrasi sederhana. Informasi yang jelas akan meningkatkan pemahaman pasien, mengurangi kecemasan, dan mendorong keterlibatan pasien dalam proses perawatan.

Pengaturan lingkungan juga diperlukan untuk mengurangi hambatan komunikasi. Perawat sebaiknya memilih tempat yang tenang, menjaga privasi, mengurangi kebisingan, dan memastikan pasien berada dalam posisi yang nyaman. Jika pasien sedang marah atau gelisah, lingkungan perlu dibuat lebih aman dengan mengurangi kerumunan, menjauhkan benda berbahaya, dan menurunkan stimulus yang dapat memicu emosi. Lingkungan yang mendukung akan membantu pasien lebih fokus, lebih tenang, dan lebih mudah berkomunikasi.

Dalam situasi tertentu, pengaturan lingkungan dapat menjadi bagian dari teknik de-eskalasi untuk mencegah peningkatan ketegangan.

Peningkatan keterampilan komunikasi perawat juga menjadi strategi utama dalam mengatasi hambatan. Keterampilan komunikasi terapeutik perlu dilatih secara terus-menerus melalui pendidikan, pengalaman klinis, refleksi diri, supervisi, dan evaluasi. Perawat perlu belajar mengenali bahasa verbal dan nonverbal pasien, mengelola emosi sendiri, mendengarkan aktif, memberikan validasi, melakukan klarifikasi, serta menggunakan teknik de-eskalasi ketika menghadapi pasien yang marah atau agresif. Perawat juga perlu mengembangkan kesadaran budaya agar mampu berkomunikasi secara sensitif terhadap nilai dan keyakinan pasien.

Maka hambatan dalam komunikasi terapeutik dapat berasal dari perawat, pasien, lingkungan, serta perbedaan budaya, bahasa, nilai, dan keyakinan. Hambatan tersebut dapat mengganggu hubungan terapeutik, mengurangi ketepatan pengkajian, menurunkan kerja sama pasien, dan memengaruhi mutu asuhan keperawatan. Oleh karena itu, perawat perlu mengenali hambatan sejak awal dan menerapkan strategi yang tepat, seperti pendekatan empatik, penggunaan bahasa sederhana, pengaturan lingkungan, serta peningkatan keterampilan komunikasi. Komunikasi yang efektif akan membantu menciptakan hubungan yang saling percaya, meningkatkan keselamatan pasien, dan mendukung pelayanan keperawatan yang lebih manusiawi dan berkualitas.

F. Konsep Dasar Teknik De-eskalasi

Teknik de-eskalasi merupakan salah satu pendekatan penting dalam praktik keperawatan, terutama ketika perawat menghadapi pasien yang mengalami peningkatan emosi, seperti cemas, marah, gelisah, panik, frustrasi, atau menunjukkan tanda-tanda perilaku agresif. Secara sederhana, de-eskalasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan emosional pasien melalui pendekatan verbal dan nonverbal yang dilakukan secara tenang, aman, dan terapeutik. Teknik ini bertujuan membantu pasien kembali pada kondisi yang lebih stabil sehingga mampu berpikir lebih jernih, mengendalikan perilaku, dan berkomunikasi dengan lebih baik. Dalam pelaksanaannya, de-eskalasi tidak hanya berarti meminta pasien untuk tenang, tetapi merupakan proses profesional yang memerlukan keterampilan komunikasi, kemampuan membaca situasi, pengendalian emosi perawat, serta pemahaman terhadap kebutuhan dan perasaan pasien.

De-eskalasi dilakukan ketika situasi mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan ketegangan. Pasien dapat tampak gelisah, berbicara dengan nada

tinggi, mondar-mandir, mengepalkan tangan, menunjukkan ekspresi wajah tegang, menolak instruksi, atau mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman. Pada kondisi seperti ini, perawat perlu segera mengenali bahwa pasien sedang berada dalam keadaan emosional yang meningkat dan membutuhkan pendekatan yang tepat. Apabila perawat memberikan respons yang tidak sesuai, misalnya membentak, memaksa, mempermalukan, atau menunjukkan sikap menantang, maka situasi dapat semakin memburuk. Sebaliknya, dengan menggunakan teknik de-eskalasi, perawat dapat membantu menurunkan ketegangan dan mencegah situasi berkembang menjadi perilaku kekerasan.

De-eskalasi dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu verbal dan nonverbal. Pendekatan verbal mencakup penggunaan kata-kata, nada suara, pilihan kalimat, serta cara perawat menyampaikan pesan kepada pasien. Dalam de-eskalasi, perawat perlu menggunakan suara yang tenang, rendah, jelas, dan stabil. Kalimat yang digunakan sebaiknya singkat, sederhana, dan tidak mengandung ancaman. Perawat juga perlu mengakui perasaan pasien, misalnya dengan menyampaikan bahwa perawat memahami pasien sedang marah, takut, atau kecewa. Pengakuan terhadap perasaan pasien dapat membantu pasien merasa didengar dan tidak diabaikan. Sementara itu, pendekatan nonverbal mencakup ekspresi wajah, kontak mata, posisi tubuh, jarak fisik, gerakan tangan, dan sikap tubuh perawat. Bahasa tubuh yang tenang, terbuka, dan tidak mengancam dapat membantu menciptakan suasana yang lebih aman.

Tujuan utama teknik de-eskalasi adalah mencegah terjadinya perilaku agresif dan meningkatkan keselamatan pasien serta lingkungan sekitar. Pasien yang sedang mengalami peningkatan emosi sering kali mengalami kesulitan mengendalikan responsnya. Ia dapat bertindak impulsif, berkata kasar, mengancam, merusak benda, atau bahkan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam situasi tersebut, de-eskalasi menjadi upaya awal untuk menghentikan peningkatan ketegangan sebelum mencapai tahap krisis. Dengan menurunkan intensitas emosi pasien, perawat dapat membantu mencegah tindakan kekerasan, mengurangi risiko cedera, dan menjaga keamanan semua pihak yang terlibat.

Keselamatan merupakan aspek yang sangat penting dalam de-eskalasi. Keselamatan yang dimaksud tidak hanya mencakup keselamatan pasien, tetapi juga keselamatan perawat, keluarga, pasien lain, dan lingkungan pelayanan. Dalam menghadapi pasien yang gelisah atau agresif, perawat perlu mengatur posisi tubuh, menjaga jarak aman, memastikan tidak ada benda berbahaya di sekitar pasien, serta menghindari posisi yang membuat perawat terjebak atau tidak memiliki akses keluar. Perawat juga perlu menilai apakah situasi masih dapat

ditangani secara mandiri atau membutuhkan bantuan tim kesehatan lain. Dengan demikian, de-eskalasi bukan hanya teknik komunikasi, tetapi juga bagian dari manajemen risiko dalam pelayanan keperawatan.

De-eskalasi merupakan pendekatan non-kekerasan yang menghargai martabat pasien. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pasien yang sedang marah, gelisah, atau agresif tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak, perasaan, dan martabat. Pasien tidak boleh langsung dipandang sebagai ancaman yang harus dikendalikan secara paksa, tetapi sebagai individu yang sedang mengalami tekanan emosional dan membutuhkan bantuan untuk kembali tenang. Dengan pendekatan de-eskalasi, perawat berupaya memahami penyebab perilaku pasien, memberikan ruang bagi pasien untuk mengungkapkan perasaan, serta membantu pasien menemukan cara yang lebih aman untuk merespons situasi.

Pendekatan non-kekerasan dalam de-eskalasi sangat penting karena tindakan yang bersifat memaksa atau mengancam dapat memperburuk kondisi pasien. Pasien yang merasa dipaksa, dipojokkan, atau tidak dihargai dapat menjadi semakin defensif dan agresif. Sebaliknya, ketika pasien merasa didengarkan dan dihargai, ia cenderung lebih mudah diarahkan. Perawat perlu menunjukkan bahwa tujuan komunikasi bukan untuk menghukum atau mempermalukan pasien, tetapi untuk membantu pasien merasa lebih aman dan mengurangi ketegangan yang dirasakan. Sikap ini sangat penting terutama pada pasien dengan gangguan jiwa, pasien di instalasi gawat darurat, pasien dengan nyeri berat, atau pasien yang sedang mengalami krisis emosional.

De-eskalasi berbeda dengan restrain atau pembatasan fisik. De-eskalasi merupakan pendekatan awal yang bersifat verbal, nonverbal, suportif, dan tidak menggunakan paksaan fisik. Tujuannya adalah menurunkan ketegangan dengan cara membangun komunikasi, mengurangi stimulus pemicu, memberikan pilihan, serta membantu pasien mengontrol dirinya. Sementara itu, restrain atau pembatasan fisik merupakan tindakan membatasi gerak pasien secara fisik, biasanya dilakukan apabila pasien menunjukkan risiko tinggi mencederai diri sendiri, orang lain, atau lingkungan, dan ketika upaya lain tidak berhasil. Restrain bukan tindakan utama, melainkan pilihan terakhir yang harus dilakukan sesuai prosedur, etika, hukum, dan pengawasan ketat.

Perbedaan ini penting dipahami oleh perawat agar tidak langsung menggunakan tindakan pembatasan ketika pasien mulai menunjukkan emosi yang meningkat. Dalam banyak situasi, perilaku agresif dapat dicegah apabila perawat mampu mengenali tanda awal eskalasi dan melakukan de-eskalasi dengan tepat. Misalnya, pasien yang mulai berbicara keras karena merasa tidak dipahami dapat

menjadi lebih tenang apabila perawat mendengarkan keluhannya, mengakui perasaannya, dan menjelaskan situasi dengan bahasa sederhana. Namun, apabila perawat langsung memanggil keamanan atau mengancam akan mengikat pasien, pasien dapat merasa diserang dan semakin marah. Oleh karena itu, de-eskalasi harus menjadi pendekatan awal sebelum tindakan yang lebih restriktif dipertimbangkan.

Prinsip utama dalam de-eskalasi adalah tetap tenang. Perawat harus mampu mengendalikan emosi dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum membantu pasien menenangkan diri. Pasien yang sedang marah atau gelisah dapat sangat peka terhadap nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh perawat. Jika perawat tampak panik, takut, marah, atau terpancing emosi, pasien dapat menangkap respons tersebut sebagai ancaman atau penolakan. Oleh karena itu, perawat perlu berbicara dengan suara stabil, tidak membalas kemarahan pasien, tidak menggunakan kata-kata kasar, dan tidak menunjukkan ekspresi yang menantang. Ketenangan perawat dapat menjadi contoh dan stimulus positif bagi pasien untuk ikut menurunkan ketegangannya.

Prinsip berikutnya adalah menjaga keamanan. Keamanan dalam de-eskalasi mencakup pengaturan jarak, posisi tubuh, lingkungan, serta kesiapan meminta bantuan. Perawat perlu menjaga jarak yang cukup agar pasien tidak merasa terancam, tetapi juga tidak terlalu jauh sehingga komunikasi tetap dapat berlangsung. Posisi tubuh sebaiknya terbuka, tidak menyudutkan pasien, dan tidak menghalangi jalan keluar. Perawat perlu menghindari menyentuh pasien tanpa izin karena sentuhan tiba-tiba dapat dianggap sebagai ancaman. Selain itu, benda-benda yang dapat digunakan untuk melukai diri sendiri atau orang lain perlu dijauhkan. Dalam kondisi pasien menunjukkan risiko kekerasan tinggi, perawat harus segera melibatkan tim sesuai prosedur keselamatan.

De-eskalasi juga harus dilakukan dengan sikap tidak provokatif. Sikap provokatif dapat berupa nada suara tinggi, kata-kata yang menyalahkan, perintah kasar, ancaman, ekspresi wajah sinis, kontak mata yang terlalu tajam, atau gerakan tubuh yang mendadak. Semua hal tersebut dapat membuat pasien merasa ditantang atau direndahkan. Perawat sebaiknya menggunakan kalimat yang menenangkan dan tidak mempermalukan pasien. Misalnya, daripada mengatakan "Bapak jangan marah-marah!", perawat dapat mengatakan "Saya melihat Bapak sedang sangat marah. Mari kita bicara pelan-pelan agar saya bisa memahami apa yang Bapak butuhkan." Kalimat seperti ini lebih terapeutik karena mengakui emosi pasien tanpa memperkuat perilaku agresif.

Menghargai pasien merupakan prinsip penting lainnya. Pasien yang sedang mengalami krisis emosional tetap perlu diperlakukan dengan hormat. Perawat

sebaiknya menggunakan nama pasien, berbicara dengan sopan, tidak merendahkan, tidak mengejek, dan tidak membicarakan pasien di depan orang lain dengan cara yang memperlmalukan. Menghargai pasien juga berarti memberi kesempatan pasien untuk menyampaikan keluhannya, memberikan pilihan yang realistis, dan tidak mengambil alih kendali secara berlebihan. Misalnya, perawat dapat memberikan pilihan sederhana seperti berbicara di tempat yang lebih tenang atau duduk sejenak sambil menarik napas. Pilihan sederhana dapat membantu pasien merasa masih memiliki kontrol terhadap dirinya.

Prinsip berikutnya adalah mengurangi stimulus pemicu. Lingkungan yang ramai, bising, penuh orang, terlalu terang, atau banyak tekanan dapat memperburuk kondisi pasien yang sedang gelisah. Dalam de-eskalasi, perawat perlu berupaya menurunkan stimulus yang dapat memicu peningkatan emosi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak pasien ke tempat yang lebih tenang, mengurangi jumlah orang yang berada di sekitar pasien, menurunkan suara, menjauhkan penonton, dan menghindari banyak orang berbicara sekaligus kepada pasien. Lingkungan yang lebih tenang dapat membantu pasien mengurangi beban sensori dan lebih mudah memusatkan perhatian pada komunikasi dengan perawat.

Pentingnya de-eskalasi terlihat jelas dalam praktik keperawatan jiwa. Pada pelayanan keperawatan jiwa, perawat sering menghadapi pasien dengan halusinasi, waham, kecemasan berat, perilaku curiga, agitasi, atau risiko perilaku kekerasan. Pasien dapat merasa terancam oleh pengalaman internalnya atau salah menafsirkan tindakan orang lain. Dalam situasi seperti ini, de-eskalasi membantu perawat menjaga hubungan terapeutik, mengarahkan pasien pada realitas, mengurangi risiko kekerasan, serta mencegah penggunaan restrain yang tidak perlu. De-eskalasi juga membantu pasien belajar mengenali emosi dan mengembangkan cara yang lebih adaptif untuk menghadapi tekanan.

Dalam instalasi gawat darurat, de-eskalasi juga memiliki peran yang sangat penting. IGD merupakan lingkungan yang sering penuh tekanan, ramai, bising, dan menegangkan. Pasien atau keluarga dapat datang dalam kondisi panik, marah, takut, atau frustrasi karena menunggu lama, merasakan nyeri, menghadapi kondisi darurat, atau tidak memahami alur pelayanan. Perawat di IGD perlu memiliki kemampuan de-eskalasi agar dapat menenangkan pasien dan keluarga, mencegah konflik, serta menjaga kelancaran pelayanan. De-eskalasi di IGD harus dilakukan dengan cepat, jelas, dan tetap mempertimbangkan prioritas klinis serta keselamatan semua pihak.

Di ruang rawat inap, de-eskalasi juga diperlukan karena pasien dapat mengalami stres akibat hospitalisasi, nyeri, keterbatasan aktivitas, gangguan tidur, efek obat, kecemasan terhadap diagnosis, atau konflik dengan keluarga. Pasien

yang merasa tidak nyaman dapat menjadi mudah tersinggung, menolak tindakan, atau menunjukkan perilaku marah. Perawat yang mampu melakukan de-eskalasi dapat membantu pasien mengungkapkan keluhan secara lebih aman, memberikan informasi yang menenangkan, dan mencegah terjadinya konflik antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Dengan demikian, de-eskalasi membantu menciptakan suasana perawatan yang lebih kondusif.

Dalam pelayanan kesehatan lainnya, seperti puskesmas, klinik, layanan komunitas, maupun perawatan rumah, de-eskalasi tetap penting. Perawat dapat menghadapi pasien atau keluarga yang kecewa, cemas, bingung, menolak edukasi, atau memiliki pemahaman berbeda tentang penyakit dan pengobatan. De-eskalasi membantu perawat menjaga komunikasi tetap efektif, menghindari konflik, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pasien serta keluarga. Keterampilan ini sangat diperlukan dalam pelayanan yang berorientasi pada pasien karena setiap interaksi dapat memengaruhi kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan.

teknik de-eskalasi merupakan pendekatan penting dalam keperawatan untuk menurunkan ketegangan emosional pasien melalui komunikasi verbal dan nonverbal yang aman, tenang, dan menghargai martabat pasien. De-eskalasi bertujuan mencegah perilaku agresif, menjaga keselamatan, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi proses perawatan. Teknik ini berbeda dengan restrain karena de-eskalasi bersifat non-kekerasan dan menjadi pendekatan awal sebelum tindakan pembatasan dipertimbangkan. Prinsip utama de-eskalasi meliputi ketenangan, keamanan, sikap tidak provokatif, penghargaan terhadap pasien, dan pengurangan stimulus pemicu. Dalam praktik keperawatan jiwa, gawat darurat, ruang rawat inap, maupun pelayanan kesehatan lainnya, kemampuan melakukan de-eskalasi menjadi kompetensi penting yang mendukung keselamatan pasien, kualitas asuhan, dan profesionalisme perawat.

G. Pelaksanaan Teknik De-eskalasi dalam Praktik Keperawatan

Pelaksanaan teknik de-eskalasi dalam praktik keperawatan merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai perawat ketika menghadapi pasien yang menunjukkan peningkatan ketegangan emosional, agitasi, kemarahan, kecemasan berat, atau risiko perilaku kekerasan. De-eskalasi dilakukan sebagai upaya awal untuk menenangkan pasien secara verbal dan nonverbal sebelum situasi berkembang menjadi lebih berbahaya. Dalam praktiknya, de-eskalasi tidak hanya bergantung pada kata-kata yang digunakan perawat, tetapi juga pada sikap, nada suara, ekspresi wajah, posisi tubuh, kemampuan membaca situasi, serta kepekaan terhadap kondisi emosional pasien. Perawat perlu memahami bahwa pasien yang

sedang marah atau gelisah sering kali berada dalam kondisi tidak nyaman, merasa terancam, takut, bingung, atau tidak mampu mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat terapeutik, aman, tidak provokatif, dan tetap menghargai martabat pasien.

Tahap awal dalam pelaksanaan de-eskalasi adalah mengidentifikasi tanda-tanda awal agitasi. Agitasi merupakan kondisi ketika pasien menunjukkan peningkatan ketegangan, kegelisahan, atau ketidakmampuan untuk tetap tenang. Tanda awal agitasi dapat terlihat dari perilaku pasien yang mondar-mandir, tampak gelisah, berbicara dengan suara keras, wajah tegang, napas cepat, gerakan tubuh tidak tenang, mengepalkan tangan, menatap tajam, atau menunjukkan ekspresi marah. Pada beberapa pasien, agitasi juga dapat tampak melalui penolakan terhadap instruksi, bicara kasar, menyalahkan orang lain, mengancam, atau menunjukkan sikap curiga terhadap perawat dan lingkungan sekitar. Perawat perlu peka terhadap tanda-tanda tersebut karena semakin cepat agitasi dikenali, semakin besar peluang situasi dapat dikendalikan tanpa tindakan yang lebih restriktif.

Mengidentifikasi tanda awal agitasi tidak hanya dilakukan melalui ucapan pasien, tetapi juga melalui observasi bahasa tubuh dan perubahan perilaku. Kadang-kadang pasien tidak mengatakan bahwa dirinya marah atau takut, tetapi tubuhnya menunjukkan ketegangan. Misalnya, pasien tampak berjalan bolak-balik, tidak mau duduk, wajah memerah, suara meninggi, atau tampak mudah tersinggung ketika diajak bicara. Perawat juga perlu memperhatikan perubahan dari kondisi sebelumnya. Pasien yang awalnya tenang kemudian menjadi lebih banyak bergerak, berbicara cepat, atau mulai menolak kontak dapat menunjukkan tanda peningkatan emosi. Dalam situasi seperti ini, perawat perlu segera melakukan pendekatan sebelum pasien kehilangan kontrol terhadap perilakunya.

Setelah tanda awal agitasi dikenali, perawat perlu menilai tingkat risiko pasien mencederai diri sendiri, mencederai orang lain, atau merusak lingkungan. Penilaian risiko dilakukan untuk menentukan seberapa serius kondisi pasien dan tindakan keselamatan apa yang perlu segera dilakukan. Pasien yang hanya tampak gelisah dan masih dapat diajak bicara tentu memiliki tingkat risiko yang berbeda dengan pasien yang sudah mengancam, membawa benda berbahaya, memukul benda, atau menyatakan keinginan untuk melukai diri sendiri maupun orang lain. Dalam penilaian risiko, perawat perlu memperhatikan isi ucapan pasien, perilaku nonverbal, riwayat kekerasan sebelumnya, kondisi psikologis, adanya halusinasi atau waham yang memerintah, serta kemampuan pasien mengikuti arahan. Penilaian ini harus dilakukan dengan cepat, tetapi tetap tenang dan tidak membuat pasien merasa sedang dihakimi.

Risiko mencederai diri sendiri perlu mendapat perhatian khusus apabila pasien tampak sangat putus asa, panik, kehilangan kontrol, atau mengatakan ingin mengakhiri hidup. Sementara itu, risiko mencederai orang lain perlu diwaspadai apabila pasien menunjukkan sikap mengancam, mendekati orang lain dengan agresif, mengepalkan tangan, atau menyatakan akan memukul seseorang. Risiko terhadap lingkungan juga harus diperhatikan, misalnya pasien mulai membanting benda, menendang kursi, merusak alat, atau berada di dekat benda tajam. Dalam kondisi demikian, tujuan utama de-eskalasi adalah menjaga keselamatan semua pihak sambil berupaya menurunkan ketegangan pasien. Perawat harus tetap waspada, tetapi tidak boleh menunjukkan sikap panik atau menantang karena hal tersebut dapat memperburuk situasi.

Salah satu teknik utama dalam de-eskalasi adalah menggunakan suara yang tenang, rendah, stabil, dan tidak memancing emosi. Nada suara perawat sangat memengaruhi respons pasien. Pasien yang sedang marah atau gelisah dapat menjadi semakin terprovokasi apabila perawat berbicara dengan nada tinggi, keras, memerintah, atau terdengar menyalahkan. Sebaliknya, suara yang rendah dan stabil dapat memberi sinyal bahwa perawat tidak sedang mengancam pasien, tetapi hadir untuk membantu. Perawat perlu berbicara secara perlahan, jelas, dan tidak terburu-buru. Ketika pasien berbicara keras, perawat tidak perlu membalas dengan suara yang lebih keras. Justru perawat perlu mempertahankan nada tenang agar pasien secara perlahan dapat menyesuaikan intensitas emosinya.

Selain nada suara, pemilihan kata juga sangat penting. Dalam de-eskalasi, perawat perlu menggunakan kalimat pendek, jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Pasien yang sedang mengalami agitasi biasanya sulit memproses informasi yang panjang dan rumit. Jika perawat memberikan terlalu banyak penjelasan sekaligus, pasien dapat semakin bingung, frustrasi, atau merasa ditekan. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan harus singkat dan langsung pada inti. Misalnya, perawat dapat mengatakan, "Saya ingin membantu Bapak," "Mari kita bicara pelan-pelan," atau "Kita duduk di tempat yang lebih tenang." Kalimat sederhana seperti ini lebih mudah diterima dibandingkan penjelasan panjang yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Perawat juga sebaiknya menghindari istilah medis yang sulit, ancaman, sindiran, atau perintah yang terlalu keras.

Dalam menghadapi pasien yang marah atau gelisah, perawat perlu mengakui perasaan pasien tanpa membenarkan perilaku agresif. Mengakui perasaan berarti perawat menunjukkan bahwa emosi pasien dipahami. Misalnya, perawat dapat mengatakan, "Saya melihat Bapak sedang sangat marah," atau "Ibu tampak sangat kecewa dengan situasi ini." Kalimat seperti ini dapat membantu pasien merasa didengarkan dan tidak diabaikan. Namun, perawat tetap perlu memberikan

batasan bahwa perilaku agresif tidak dapat diterima. Misalnya, perawat dapat melanjutkan dengan kalimat, "Saya ingin mendengarkan, tetapi kita perlu berbicara tanpa saling mengancam." Dengan cara ini, perawat menghargai perasaan pasien, tetapi tetap menjaga keselamatan dan batas perilaku yang dapat diterima.

Validasi perasaan pasien merupakan bagian penting dari de-eskalasi karena banyak perilaku agresif muncul ketika pasien merasa tidak dipahami. Pasien mungkin marah karena merasa nyerinya diabaikan, takut terhadap tindakan medis, kecewa karena menunggu lama, atau merasa tidak memiliki kendali terhadap situasi. Jika perawat langsung menyalahkan perilaku pasien tanpa memahami emosinya, pasien dapat merasa semakin terpojok. Namun, jika perawat mampu mengakui perasaan pasien secara tepat, ketegangan dapat menurun. Meskipun demikian, pengakuan terhadap perasaan tidak boleh diartikan sebagai pembenaran terhadap tindakan yang membahayakan. Perawat tetap harus menunjukkan batas yang jelas bahwa memukul, mengancam, merusak benda, atau menyakiti diri sendiri bukan cara yang aman untuk menyampaikan emosi.

Memberikan pilihan sederhana juga merupakan teknik yang efektif dalam de-eskalasi. Pasien yang sedang marah atau gelisah sering kali merasa kehilangan kontrol. Jika perawat hanya memberikan perintah, pasien dapat merasa semakin ditekan dan melawan. Dengan memberikan pilihan sederhana, pasien merasa masih memiliki kendali terhadap dirinya. Pilihan yang diberikan harus realistis, aman, dan tidak terlalu banyak. Misalnya, perawat dapat bertanya, "Bapak ingin duduk di kursi ini atau di ruangan yang lebih tenang?" atau "Ibu ingin berbicara sekarang atau setelah menarik napas sebentar?" Pilihan seperti ini membantu pasien merasa dilibatkan dalam proses penyelesaian situasi. Namun, perawat tetap perlu memastikan bahwa pilihan yang diberikan tidak membahayakan pasien maupun orang lain.

Dalam pelaksanaan de-eskalasi, menjaga jarak aman sangat penting. Jarak aman membantu melindungi perawat dari kemungkinan serangan tiba-tiba dan sekaligus memberikan ruang bagi pasien agar tidak merasa terancam. Perawat sebaiknya tidak berdiri terlalu dekat, tidak menyudutkan pasien, dan tidak menghalangi jalan keluar. Posisi tubuh perawat harus memungkinkan untuk bergerak apabila situasi memburuk. Selain itu, perawat tidak boleh menyentuh pasien tanpa izin, terutama ketika pasien sedang marah, curiga, atau gelisah. Sentuhan yang dimaksudkan untuk menenangkan dapat disalahartikan sebagai ancaman atau bentuk paksaan. Jika sentuhan diperlukan, perawat harus meminta izin terlebih dahulu dan memastikan pasien menerimanya.

Bahasa tubuh perawat juga harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan menantang. Perawat perlu menghindari kontak mata yang terlalu tajam atau terlalu

lama karena dapat dianggap sebagai tantangan oleh pasien yang sedang marah. Kontak mata tetap diperlukan untuk menunjukkan perhatian, tetapi harus dilakukan secara wajar dan tidak mengintimidasi. Perawat juga harus menghindari gerakan mendadak, menunjuk-nunjuk wajah pasien, menyilangkan tangan dengan sikap kaku, berdiri terlalu tegak di depan pasien, atau mendekati pasien secara tiba-tiba. Posisi tubuh yang terbuka, sedikit menyamping, dan tidak mengancam lebih disarankan karena memberi kesan aman serta tidak konfrontatif. Bahasa tubuh yang tenang sering kali lebih kuat daripada kata-kata dalam membantu menurunkan ketegangan pasien.

Mengurangi rangsangan lingkungan merupakan bagian penting dalam teknik de-eskalasi. Lingkungan yang ramai, bising, penuh orang, atau terlalu banyak stimulus dapat memperburuk agitasi pasien. Pasien yang sedang marah atau gelisah dapat semakin tidak terkendali jika banyak orang menonton, banyak suara, atau terlalu banyak tenaga kesehatan berbicara secara bersamaan. Oleh karena itu, perawat perlu mengurangi kerumunan, menurunkan kebisingan, dan mengajak pasien ke tempat yang lebih tenang jika memungkinkan. Selain itu, benda-benda berbahaya seperti gunting, jarum, pecahan kaca, kabel, kursi ringan yang mudah dilempar, atau benda tajam perlu dijauhkan dari jangkauan pasien. Pengaturan lingkungan bertujuan menciptakan suasana yang lebih aman dan mengurangi peluang terjadinya cedera.

Dalam lingkungan pelayanan kesehatan, pengurangan stimulus juga dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orang yang berinteraksi langsung dengan pasien. Sebaiknya hanya satu orang yang berbicara kepada pasien, sementara anggota tim lain bersiap membantu jika diperlukan. Terlalu banyak orang memberikan instruksi dapat membuat pasien bingung dan merasa diserang. Perawat yang menjadi komunikator utama harus mampu menjaga nada suara, memilih kata yang tepat, dan mengamati respons pasien. Jika pasien mulai lebih tenang, perawat dapat melanjutkan komunikasi secara bertahap. Namun, jika pasien semakin meningkat emosinya, perawat perlu segera mengevaluasi strategi dan mempertimbangkan bantuan tambahan.

Melibatkan tim kesehatan menjadi langkah penting apabila pasien menunjukkan risiko kekerasan tinggi atau sulit diarahkan. De-eskalasi memang mengutamakan pendekatan verbal dan nonverbal, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jika pasien membawa benda berbahaya, mengancam akan melukai diri sendiri atau orang lain, tidak merespons komunikasi, atau semakin agresif, perawat tidak boleh menangani situasi seorang diri. Perawat perlu meminta bantuan tim sesuai prosedur fasilitas pelayanan kesehatan. Tim dapat terdiri atas perawat lain, dokter, petugas keamanan, atau tenaga kesehatan lain

yang terlatih menangani situasi krisis. Pelibatan tim harus dilakukan secara terkoordinasi agar tidak menimbulkan kesan mengepung atau mengintimidasi pasien.

Ketika tim dilibatkan, komunikasi tetap harus dikendalikan agar tidak membingungkan pasien. Satu orang sebaiknya tetap menjadi komunikator utama, sedangkan anggota tim lain menjaga keamanan lingkungan dan bersiap membantu jika diperlukan. Pendekatan yang terlalu ramai atau agresif dapat meningkatkan rasa terancam pada pasien. Oleh karena itu, koordinasi tim harus dilakukan dengan tenang, terarah, dan sesuai standar prosedur operasional. Apabila seluruh upaya de-eskalasi tidak berhasil dan pasien tetap berisiko tinggi membahayakan diri sendiri atau orang lain, tindakan lanjutan seperti pemberian terapi medis atau pembatasan fisik dapat dipertimbangkan sesuai indikasi, prosedur, etika, dan pengawasan ketat. Namun, tindakan tersebut merupakan pilihan terakhir setelah pendekatan de-eskalasi dilakukan secara optimal.

Pelaksanaan de-eskalasi dalam praktik keperawatan juga memerlukan evaluasi berkelanjutan. Perawat perlu terus menilai apakah pasien mulai lebih tenang, apakah nada bicara menurun, apakah gerakan tubuh berkurang, apakah pasien mulai mampu mendengarkan, dan apakah risiko kekerasan menurun. Jika pasien menunjukkan respons positif, perawat dapat melanjutkan komunikasi dengan menggali kebutuhan pasien dan membantu mencari solusi. Jika pasien tetap meningkat emosinya, strategi perlu diubah, lingkungan perlu diamankan lebih lanjut, dan bantuan tim harus segera diaktifkan. Evaluasi ini penting karena kondisi pasien dapat berubah dengan cepat, terutama dalam situasi krisis.

Setelah situasi terkendali, perawat perlu melakukan dokumentasi. Dokumentasi mencakup tanda awal agitasi yang ditemukan, kemungkinan pencetus, teknik de-eskalasi yang dilakukan, respons pasien, tingkat risiko, keterlibatan tim, serta tindak lanjut yang diberikan. Dokumentasi penting untuk kesinambungan asuhan dan evaluasi mutu pelayanan. Melalui dokumentasi yang baik, tim kesehatan dapat mengetahui strategi apa yang efektif untuk pasien tertentu dan faktor apa yang perlu dihindari agar kejadian serupa tidak berulang. Dokumentasi juga menjadi bukti bahwa perawat telah melakukan tindakan sesuai prosedur dan mengutamakan keselamatan pasien.

pelaksanaan teknik de-eskalasi dalam praktik keperawatan membutuhkan kemampuan mengenali tanda awal agitasi, menilai risiko, menggunakan komunikasi verbal yang tenang dan sederhana, mengakui perasaan pasien, memberikan pilihan yang aman, menjaga jarak, menghindari sikap provokatif, mengurangi stimulus lingkungan, serta melibatkan tim ketika risiko meningkat. De-eskalasi bukan hanya teknik untuk menghadapi pasien yang marah, tetapi

merupakan pendekatan terapeutik yang bertujuan menjaga keselamatan, menghargai martabat pasien, dan mencegah penggunaan tindakan yang lebih restriktif. Perawat yang mampu melaksanakan de-eskalasi dengan baik akan lebih siap menghadapi situasi krisis, mempertahankan hubungan terapeutik, serta meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan keperawatan.

H. Simpulan

Komunikasi terapeutik merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam praktik keperawatan karena menjadi fondasi hubungan profesional antara perawat dan pasien. Melalui komunikasi terapeutik, perawat dapat membangun hubungan saling percaya, menggali keluhan dan kebutuhan pasien, memberikan dukungan emosional, serta membantu pasien memahami kondisi kesehatannya. Komunikasi terapeutik tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap, nada suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, kemampuan mendengarkan, serta penghargaan terhadap martabat pasien. Dengan komunikasi yang tepat, pasien akan merasa lebih aman, dihargai, dipahami, dan lebih kooperatif dalam menjalani proses perawatan.

Dalam pelaksanaannya, komunikasi terapeutik harus memperhatikan prinsip empati, penerimaan, kejujuran, keterbukaan, saling menghargai, menjaga kerahasiaan, serta tidak menghakimi pasien. Perawat juga perlu memahami tahapan komunikasi terapeutik, mulai dari fase pra-interaksi, orientasi, kerja, hingga terminasi agar proses komunikasi berjalan sistematis dan terarah. Berbagai teknik komunikasi seperti mendengarkan aktif, pertanyaan terbuka, klarifikasi, validasi, refleksi, diam terapeutik, pemberian informasi, dan menyimpulkan pembicaraan sangat membantu perawat dalam memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Namun, komunikasi terapeutik juga dapat mengalami hambatan, baik dari perawat, pasien, lingkungan, maupun perbedaan budaya, bahasa, nilai, dan keyakinan, sehingga diperlukan pendekatan yang sabar, empatik, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Teknik de-eskalasi merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan, terutama ketika menghadapi pasien yang mengalami agitasi, kecemasan, kemarahan, kegelisahan, atau berisiko melakukan perilaku kekerasan. De-eskalasi dilakukan melalui pendekatan verbal dan nonverbal yang tenang, aman, tidak provokatif, serta tetap menghargai martabat pasien. Perawat perlu mampu mengenali tanda awal agitasi, menilai risiko keselamatan, menggunakan suara yang rendah dan stabil, memberikan kalimat yang jelas, mengakui perasaan pasien, menjaga jarak aman, mengurangi rangsangan lingkungan, serta melibatkan tim kesehatan apabila risiko meningkat. Dengan penerapan komunikasi terapeutik dan

teknik de-eskalasi yang tepat, perawat dapat mencegah konflik, menurunkan ketegangan emosional, menjaga keselamatan pasien dan lingkungan, serta meningkatkan mutu asuhan keperawatan secara profesional dan manusiawi.

I. Referensi

- American Nurses Association. (2015). *Nursing: Scope and standards of practice* (3rd ed.). American Nurses Association.
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2019). *Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses* (8th ed.). Elsevier.
- Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2022). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (11th ed.). Pearson.
- Black, D. W., & Andreasen, N. C. (2021). *Introductory textbook of psychiatry* (7th ed.). American Psychiatric Association Publishing.
- Halter, M. J. (2022). *Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing: A clinical approach* (9th ed.). Elsevier.
- Keliat, B. A. (2014). *Proses keperawatan jiwa* (Edisi 2). EGC.
- Keliat, B. A., & Akemat. (2012). *Keperawatan kesehatan jiwa komunitas: CMHN (basic course)*. EGC.
- Keliat, B. A., Akemat, & Nurhalimah. (2013). *Keperawatan kesehatan jiwa: Konsep dan aplikasi praktik klinik*. EGC.
- Kozier, B., Erb, G., Berman, A., & Snyder, S. J. (2016). *Fundamentals of nursing: Concepts, process, and practice* (10th ed.). Pearson.
- Nasir, A., & Muhith, A. (2011). *Dasar-dasar keperawatan jiwa: Pengantar dan teori*. Salemba Medika.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2015). *Violence and aggression: Short-term management in mental health, health and community settings* (NICE Guideline No. 10). NICE. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng10>
- Peplau, H. E. (1991). *Interpersonal relations in nursing: A conceptual frame of reference for psychodynamic nursing*. Springer Publishing Company.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Richmond, J. S., Berlin, J. S., Fishkind, A. B., Holloman, G. H., Zeller, S. L., Wilson, M. P., Rifai, M. A., & Ng, A. T. (2012). Verbal de-escalation of the agitated patient:

Consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup. *Western Journal of Emergency Medicine*, 13(1), 17–25. <https://doi.org/10.5811/westjem.2011.9.6864>

Stuart, G. W. (2022). *Prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa Stuart* (Edisi Indonesia 11; B. A. Keliat & J. Pasaribu, Eds.). Elsevier Health Sciences.

Suryani. (2015). *Komunikasi terapeutik: Teori dan praktik*. EGC.

Sutejo. (2018). *Keperawatan jiwa: Konsep dan praktik asuhan keperawatan kesehatan jiwa: Gangguan jiwa dan psikososial*. Pustaka Baru Press.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2020). *Essentials of psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice* (8th ed.). F. A. Davis Company.

Videbeck, S. L. (2020). *Psychiatric-mental health nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer.

Yusuf, A., Fitryasari, R., & Nihayati, H. E. (2015). *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa*. Salemba Medika.

J. Glosarium

- **Komunikasi Terapeutik**

Proses komunikasi profesional antara perawat dan pasien yang dilakukan secara sadar, terarah, dan bertujuan untuk membantu pasien mengungkapkan perasaan, memahami kondisi, mengurangi kecemasan, serta mendukung proses penyembuhan.

- **De-eskalasi**

Teknik untuk menurunkan ketegangan emosional pasien melalui pendekatan verbal dan nonverbal yang tenang, aman, tidak provokatif, serta bertujuan mencegah perilaku agresif atau kekerasan.

- **Hubungan Saling Percaya**

Hubungan profesional antara perawat dan pasien yang dibangun atas dasar rasa aman, kejujuran, empati, penerimaan, dan penghargaan sehingga pasien bersedia terbuka dalam proses perawatan.

- **Empati**

Kemampuan perawat untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman pasien dari sudut pandang pasien tanpa menghakimi atau kehilangan sikap profesional.

- **Penerimaan**

Sikap perawat dalam menghargai pasien sebagai individu yang memiliki martabat, nilai, pengalaman, dan kebutuhan unik, meskipun perilaku pasien tidak selalu sesuai dengan harapan.

- **Kerahasiaan Pasien**

Prinsip etik dalam keperawatan yang mengharuskan perawat menjaga informasi pribadi pasien dan hanya menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

- **Mendengarkan Aktif**

Teknik komunikasi terapeutik yang dilakukan dengan memberikan perhatian penuh terhadap ucapan, ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh pasien untuk memahami keluhan serta kebutuhannya secara menyeluruh.

- **Klarifikasi**

Teknik komunikasi yang digunakan perawat untuk memastikan makna pernyataan pasien agar tidak terjadi salah tafsir dalam memahami keluhan, perasaan, atau kebutuhan pasien.

- **Validasi**

Tindakan mengakui perasaan atau pengalaman pasien sebagai sesuatu yang bermakna bagi pasien, tanpa harus membenarkan perilaku yang tidak adaptif atau membahayakan.

- **Refleksi**

Teknik komunikasi terapeutik dengan cara mencerminkan kembali perasaan atau pikiran pasien agar pasien lebih mampu mengenali dan memahami kondisi emosionalnya.

- **Diam Terapeutik**

Penggunaan keheningan secara sengaja oleh perawat untuk memberi kesempatan kepada pasien berpikir, menenangkan diri, dan menyusun perasaan atau pikirannya sebelum berbicara.

- **Agitasi**

Kondisi peningkatan ketegangan emosional yang ditandai dengan gelisah, bicara keras, mondar-mandir, wajah tegang, mudah marah, atau perilaku yang menunjukkan risiko eskalasi.

- **Perilaku Agresif**

Perilaku verbal atau fisik yang berpotensi menyakiti diri sendiri, orang lain, atau merusak lingkungan, seperti mengancam, berteriak, memukul, membanting benda, atau menyerang.

- **Restrain**

Tindakan pembatasan gerak pasien secara fisik yang digunakan sebagai pilihan terakhir apabila pasien berisiko tinggi mencederai diri sendiri, orang lain, atau lingkungan, dan upaya de-eskalasi tidak berhasil.

- **Keselamatan Pasien**

Upaya untuk mencegah cedera, mengurangi risiko bahaya, dan menciptakan lingkungan pelayanan yang aman bagi pasien, perawat, keluarga, serta orang lain di sekitar pasien.

CHAPTER 3

EVALUASI KEBERHASILAN INTERVENSI KEPERAWATAN JIWA PADA PASIEN RISIKO PERILAKU KEKERASAN

□ Ns. Reta Renylda, M.Kep. □

A. Pendahuluan/Prolog

Evaluasi merupakan salah satu tahap penting dalam proses asuhan keperawatan jiwa karena melalui evaluasi perawat dapat mengetahui sejauh mana intervensi yang telah diberikan mampu menghasilkan perubahan pada kondisi pasien. Dalam keperawatan jiwa, evaluasi tidak hanya berfokus pada perubahan tanda dan gejala secara fisik, tetapi juga mencakup perubahan pikiran, emosi, perilaku, kemampuan koping, hubungan sosial, kepatuhan terapi, serta kemampuan pasien dalam mengendalikan respons maladaptif. Pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan, evaluasi menjadi sangat penting karena masalah ini berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, orang lain, dan lingkungan perawatan. Tanpa evaluasi yang tepat, perawat akan sulit menentukan apakah intervensi yang telah dilakukan sudah efektif, perlu dilanjutkan, perlu dimodifikasi, atau perlu diganti dengan pendekatan lain yang lebih sesuai.

Risiko perilaku kekerasan merupakan salah satu masalah keperawatan jiwa yang membutuhkan perhatian serius dan pemantauan berkelanjutan. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan memiliki kemungkinan melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Risiko ini dapat muncul akibat berbagai kondisi, seperti ketidakmampuan mengontrol marah, adanya halusinasi perintah, waham curiga, kecemasan berat, frustrasi, konflik interpersonal, pengalaman traumatis, penyalahgunaan zat, ketidakpatuhan pengobatan, atau gangguan dalam proses pikir. Dalam kondisi tertentu, pasien mungkin tidak langsung menunjukkan tindakan kekerasan secara nyata, tetapi sudah memperlihatkan tanda-tanda awal seperti wajah tegang, suara meninggi, mudah tersinggung, gelisah, mondar-mandir, mengepalkan tangan, mengancam, menolak diarahkan, atau menunjukkan sikap bermusuhan. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus untuk mengenali perubahan kondisi pasien sebelum risiko berkembang menjadi perilaku kekerasan aktual.

Dalam asuhan keperawatan jiwa, intervensi terhadap pasien risiko perilaku kekerasan biasanya diarahkan untuk membantu pasien mengenali penyebab

marah, mengenali tanda-tanda peningkatan emosi, mengungkapkan perasaan secara verbal, menggunakan teknik pengendalian marah, mematuhi terapi, serta menjaga keselamatan diri dan orang lain. Namun, keberhasilan intervensi tersebut tidak dapat hanya diasumsikan setelah tindakan diberikan. Perawat perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pasien benar-benar memahami apa yang diajarkan, mampu mempraktikkan teknik yang diberikan, serta menunjukkan perubahan perilaku yang lebih adaptif. Misalnya, setelah pasien diajarkan teknik napas dalam, evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah pasien mampu menggunakan teknik tersebut saat mulai marah. Setelah pasien diajarkan komunikasi asertif, perawat perlu menilai apakah pasien mampu menyampaikan ketidaknyamanan tanpa mengancam atau menyerang orang lain.

Pentingnya evaluasi juga berkaitan dengan sifat dinamis dari kondisi kejiwaan pasien. Kondisi pasien dengan risiko perilaku kekerasan dapat berubah dalam waktu singkat, terutama bila pasien mengalami stresor baru, merasa tidak dipahami, mengalami konflik dengan pasien lain atau keluarga, mendengar suara yang mengancam, merasa curiga, kurang tidur, atau tidak minum obat. Pasien yang pada satu waktu tampak tenang dapat kembali menunjukkan tanda-tanda peningkatan emosi apabila menghadapi situasi yang memicu kemarahan. Oleh sebab itu, evaluasi tidak cukup dilakukan satu kali, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan selama pasien menjalani perawatan. Evaluasi yang berkesinambungan membantu perawat mengidentifikasi perkembangan pasien dari waktu ke waktu, mengenali tanda kekambuhan, serta menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan aktual pasien.

Perilaku kekerasan dapat memberikan dampak yang luas terhadap pasien. Bagi pasien sendiri, perilaku kekerasan dapat menyebabkan cedera fisik, memperburuk kondisi psikologis, meningkatkan rasa bersalah, memperkuat stigma, memperpanjang masa perawatan, serta menghambat proses pemulihan. Pasien yang pernah melakukan kekerasan mungkin merasa malu, takut ditolak, atau semakin sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Dalam beberapa kondisi, perilaku kekerasan juga dapat menyebabkan pasien dikenai tindakan pembatasan, pengawasan ketat, atau intervensi darurat yang sebenarnya dapat diminimalkan apabila risiko dikenali dan ditangani lebih awal. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan intervensi menjadi penting untuk memastikan bahwa pasien tidak hanya berhenti melakukan perilaku berbahaya, tetapi juga mulai memiliki kemampuan mengelola emosi secara lebih sehat dan aman.

Dampak perilaku kekerasan juga dirasakan oleh keluarga. Keluarga pasien dapat mengalami ketakutan, kecemasan, kelelahan emosional, rasa tidak berdaya, bahkan trauma ketika menghadapi anggota keluarga yang berisiko melakukan

kekerasan. Keluarga mungkin menjadi takut untuk mendekati pasien, bingung menghadapi perubahan perilaku pasien, atau tidak mengetahui cara memberikan dukungan yang tepat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan konflik keluarga, penolakan, isolasi pasien, atau penurunan kualitas hubungan dalam keluarga. Oleh karena itu, evaluasi intervensi keperawatan tidak hanya perlu menilai perubahan pada pasien, tetapi juga perlu melihat sejauh mana keluarga memahami tanda-tanda risiko, mampu memberikan dukungan emosional, mampu menciptakan lingkungan yang aman, serta mampu membantu pasien menerapkan strategi pengendalian marah di rumah.

Perilaku kekerasan juga berdampak terhadap perawat dan tenaga kesehatan lain. Perawat yang merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan harus menghadapi situasi yang menuntut kewaspadaan tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, serta kesiapan dalam menjaga keselamatan. Jika risiko tidak dievaluasi dengan baik, perawat dapat mengalami ancaman verbal, cedera fisik, stres kerja, kelelahan emosional, atau rasa takut saat memberikan asuhan. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan, hubungan perawat-pasien, dan suasana kerja di unit perawatan. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan intervensi tidak hanya berfungsi untuk melihat perkembangan pasien, tetapi juga untuk melindungi perawat dan tim kesehatan melalui pengambilan keputusan yang tepat, pengaturan lingkungan yang aman, serta pelibatan tim bila diperlukan.

Lingkungan perawatan juga dapat terdampak oleh perilaku kekerasan. Suasana ruang perawatan dapat menjadi tidak aman, pasien lain merasa takut, aktivitas pelayanan terganggu, dan fasilitas dapat mengalami kerusakan apabila perilaku agresif tidak dicegah. Dalam pelayanan keperawatan jiwa, lingkungan yang aman dan terapeutik sangat penting untuk mendukung proses pemulihan. Oleh karena itu, evaluasi perlu mencakup aspek keamanan lingkungan, seperti apakah pasien masih menunjukkan kecenderungan merusak benda, apakah terdapat benda berbahaya di sekitar pasien, apakah pasien membutuhkan pengawasan lebih intensif, dan apakah stimulus lingkungan perlu dikurangi. Evaluasi terhadap lingkungan membantu perawat menciptakan suasana yang lebih kondusif, mencegah konflik, dan menjaga kenyamanan seluruh pasien.

Evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan menjadi dasar untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diberikan. Intervensi yang efektif dapat dilihat dari perubahan respons pasien ke arah yang lebih adaptif. Misalnya, pasien mulai mampu menyebutkan penyebab kemarahannya, mengenali tanda-tanda saat emosi meningkat, menggunakan teknik relaksasi, mengungkapkan perasaan secara verbal tanpa mengancam, mengikuti aturan ruangan, tidak merusak benda, tidak mencederai diri sendiri atau orang lain, serta patuh terhadap pengobatan.

Sebaliknya, bila pasien masih sering mengancam, sulit diarahkan, tidak mampu mengontrol dorongan agresif, menolak minum obat, atau terus menunjukkan tanda peningkatan emosi, maka intervensi perlu dievaluasi kembali. Perawat perlu menilai apakah metode yang digunakan sudah sesuai, apakah pasien membutuhkan pendekatan yang lebih sederhana, apakah ada faktor pencetus yang belum teratasi, atau apakah diperlukan kolaborasi lebih lanjut dengan tim kesehatan.

Evaluasi juga berperan dalam menentukan keberlanjutan intervensi. Bila intervensi terbukti efektif, perawat dapat melanjutkan dan memperkuat intervensi tersebut agar kemampuan pasien semakin stabil. Misalnya, jika pasien mampu menggunakan napas dalam untuk menurunkan marah, perawat dapat melatih pasien menggunakannya dalam berbagai situasi. Jika pasien mampu mengungkapkan marah secara verbal, perawat dapat melatih komunikasi asertif yang lebih baik. Namun, jika intervensi belum berhasil, perawat perlu memodifikasi strategi. Pasien yang sulit memahami instruksi mungkin membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan latihan berulang. Pasien yang sering kambuh karena konflik keluarga mungkin membutuhkan pelibatan keluarga. Pasien yang agresif akibat halusinasi perintah mungkin membutuhkan pengkajian ulang terhadap isi halusinasi serta kolaborasi terapi medis. Dengan demikian, evaluasi membantu perawat mengambil keputusan klinis yang lebih tepat.

Tujuan pembahasan bab ini adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan. Pembahasan ini diharapkan membantu perawat memahami bahwa evaluasi bukan sekadar tahap akhir dalam proses keperawatan, tetapi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus untuk memastikan keselamatan, efektivitas intervensi, dan keberlanjutan asuhan. Melalui evaluasi yang tepat, perawat dapat mengetahui perkembangan pasien secara objektif, menentukan prioritas masalah, menilai kemampuan pasien dalam mengendalikan emosi, serta mengidentifikasi kebutuhan intervensi lanjutan. Evaluasi yang baik juga membantu mencegah kekambuhan perilaku kekerasan dan meningkatkan kesiapan pasien untuk kembali berfungsi secara lebih adaptif di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Selain itu, pembahasan ini bertujuan meningkatkan mutu asuhan keperawatan jiwa. Mutu asuhan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya tindakan yang diberikan, tetapi juga oleh ketepatan tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, keterukuran hasil, serta kemampuan perawat menindaklanjuti perubahan kondisi pasien. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan berkesinambungan akan membantu perawat memberikan asuhan yang lebih

aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Dalam konteks risiko perilaku kekerasan, mutu asuhan sangat berkaitan dengan kemampuan perawat mencegah terjadinya cedera, menjaga hubungan terapeutik, melibatkan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan.

Pada akhirnya, evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan. Evaluasi memungkinkan perawat melihat apakah pasien mengalami perubahan dalam aspek kognitif, afektif, perilaku, sosial, dan kepatuhan terapi. Evaluasi juga membantu perawat mengidentifikasi risiko yang masih ada, hambatan dalam pelaksanaan intervensi, serta kebutuhan dukungan dari keluarga dan tim kesehatan. Dengan evaluasi yang baik, intervensi keperawatan dapat menjadi lebih terarah, responsif, dan sesuai dengan kondisi pasien. Oleh karena itu, kemampuan melakukan evaluasi secara cermat dan profesional harus menjadi kompetensi penting bagi perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien dengan risiko perilaku kekerasan.

B. Konsep Dasar Risiko Perilaku Kekerasan

Risiko perilaku kekerasan merupakan salah satu masalah penting dalam keperawatan jiwa karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dalam konteks keperawatan jiwa, risiko perilaku kekerasan dapat dipahami sebagai keadaan ketika seseorang memiliki kemungkinan melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan akibat ketidakmampuan mengontrol dorongan marah, ketegangan emosional, impuls agresif, atau respons maladaptif terhadap stresor. Risiko ini belum tentu selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik secara langsung, tetapi dapat dikenali melalui tanda-tanda awal seperti peningkatan emosi, ancaman verbal, sikap bermusuhan, gelisah, atau perilaku yang menunjukkan potensi kehilangan kontrol. Oleh karena itu, perawat perlu memahami bahwa istilah “risiko” menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya perilaku kekerasan apabila faktor pencetus tidak dikenali dan tidak ditangani secara tepat.

Dalam praktik keperawatan jiwa, risiko perilaku kekerasan tidak hanya dipandang sebagai perilaku yang mengganggu, tetapi sebagai respons pasien terhadap tekanan internal maupun eksternal yang tidak mampu dikelola secara adaptif. Pasien dapat mengalami kemarahan, frustrasi, kecurigaan, ketakutan, atau ancaman yang dirasakan sangat kuat sehingga muncul dorongan untuk menyerang, melawan, merusak benda, atau menyakiti diri sendiri. Kondisi ini sering ditemukan pada pasien dengan gangguan jiwa berat, gangguan persepsi seperti

halusinasi, gangguan isi pikir seperti waham curiga, gangguan pengendalian impuls, penyalahgunaan zat, maupun pasien yang mengalami stres berat dan tidak memiliki kemampuan koping yang memadai. Perawat perlu melihat perilaku pasien secara komprehensif, bukan hanya dari tindakan yang tampak, tetapi juga dari latar belakang emosi, pikiran, pengalaman, dan situasi yang sedang dihadapi pasien.

Risiko perilaku kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pada sebagian pasien, tanda awal terlihat dari perubahan verbal, seperti berbicara dengan nada tinggi, membentak, mengancam, mengumpat, menyalahkan orang lain, atau menyampaikan keinginan untuk memukul dan melukai. Pada pasien lain, tanda risiko lebih tampak secara nonverbal, misalnya wajah tegang, tatapan tajam, rahang mengatup, tangan mengepal, tubuh kaku, napas cepat, mondar-mandir, menendang benda, memukul meja, atau menunjukkan sikap menantang. Ada pula pasien yang menjadi sangat gelisah, sulit duduk tenang, mudah tersinggung, dan menolak diarahkan. Perawat perlu peka terhadap perubahan-perubahan tersebut karena tanda awal sering kali menjadi petunjuk penting sebelum perilaku kekerasan benar-benar terjadi.

Tanda dan gejala pasien dengan risiko perilaku kekerasan dapat dilihat dari aspek emosi, kognitif, perilaku, sosial, dan fisiologis. Dari aspek emosi, pasien biasanya menunjukkan kemarahan, kejengkelan, kecemasan, rasa terancam, frustrasi, atau ketidakmampuan menenangkan diri. Emosi tersebut dapat meningkat secara cepat apabila pasien merasa tidak dipahami, merasa diperlakukan tidak adil, mengalami konflik, atau mendapatkan stimulus yang memperkuat kemarahan. Dari aspek kognitif, pasien dapat menunjukkan pikiran curiga, merasa orang lain ingin menyakitinya, sulit berpikir jernih, salah menafsirkan situasi, atau memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan realitas. Pada pasien dengan halusinasi perintah, risiko semakin tinggi apabila suara yang didengar menyuruh pasien menyerang, membalas, atau melakukan tindakan berbahaya.

Dari aspek perilaku, pasien dengan risiko perilaku kekerasan dapat menunjukkan tindakan yang mengarah pada agresivitas, baik secara verbal maupun fisik. Agresivitas verbal dapat berupa ancaman, hinaan, makian, teriakan, atau perkataan kasar. Agresivitas fisik dapat berupa mendorong, memukul, menendang, mencakar, melempar benda, merusak fasilitas, atau melukai diri sendiri. Meskipun belum melakukan kekerasan fisik, pasien yang sudah menunjukkan ancaman verbal dan gerakan tubuh yang intens tetap perlu dinilai sebagai pasien berisiko. Dari aspek sosial, pasien dapat mengalami konflik dengan orang lain, menolak berinteraksi, menyalahkan keluarga atau petugas, atau menunjukkan sikap bermusuhan. Sementara itu, dari aspek fisiologis, kemarahan

dan agitasi dapat disertai peningkatan tekanan darah, napas cepat, wajah memerah, keringat berlebihan, ketegangan otot, dan peningkatan aktivitas motorik.

Risiko perilaku kekerasan tidak muncul tanpa sebab. Terdapat faktor predisposisi dan faktor presipitasi yang dapat memengaruhi terjadinya perilaku kekerasan. Faktor predisposisi adalah faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami perilaku kekerasan. Faktor ini dapat berasal dari aspek biologis, psikologis, sosial, maupun pengalaman masa lalu. Secara biologis, riwayat gangguan jiwa, gangguan neurokimia, cedera kepala, gangguan neurologis, penggunaan zat psikoaktif, atau riwayat keluarga dengan gangguan pengendalian emosi dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perilaku agresif. Gangguan pada fungsi otak yang berkaitan dengan pengendalian impuls, penilaian realitas, dan pengaturan emosi dapat membuat pasien lebih sulit mengontrol dorongan marah.

Faktor predisposisi psikologis juga berperan besar dalam risiko perilaku kekerasan. Pasien yang memiliki pengalaman traumatis, pernah mengalami kekerasan, penolakan, kehilangan, penghinaan, atau pola asuh yang keras dapat memiliki respons marah yang lebih kuat ketika menghadapi tekanan. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan dapat membentuk cara pasien memandang dunia sebagai tempat yang tidak aman atau penuh ancaman. Akibatnya, pasien lebih mudah merasa curiga, tersinggung, atau defensif. Perasaan tidak berdaya, harga diri rendah, kegagalan berulang, serta ketidakmampuan mengungkapkan emosi secara sehat juga dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan. Dalam kondisi tertentu, kekerasan menjadi cara maladaptif yang digunakan pasien untuk mempertahankan diri, melampiaskan tekanan, atau memperoleh kontrol terhadap situasi.

Faktor predisposisi sosial juga penting diperhatikan. Lingkungan keluarga yang penuh konflik, kurang dukungan, komunikasi yang buruk, penolakan sosial, stigma, kemiskinan, pengangguran, isolasi sosial, atau pengalaman diskriminasi dapat memperburuk kemampuan pasien dalam mengelola emosi. Pasien yang tidak memiliki dukungan sosial sering kali lebih sulit menyalurkan kemarahan secara sehat. Ketika pasien merasa tidak didengar atau tidak memiliki tempat aman untuk berbicara, tekanan emosi dapat menumpuk dan akhirnya muncul dalam bentuk agresivitas. Lingkungan yang tidak stabil, sering memicu konflik, atau tidak memahami kondisi pasien dapat menjadi faktor yang memperkuat risiko perilaku kekerasan.

Faktor presipitasi adalah faktor pencetus yang memicu munculnya perilaku kekerasan pada pasien yang telah memiliki kerentanan. Faktor pencetus dapat

berupa stres akut, konflik dengan orang lain, rasa sakit, ketidaknyamanan fisik, kurang tidur, perubahan lingkungan, penolakan terhadap keinginan pasien, perasaan dipaksa, atau komunikasi yang dianggap mengancam. Pada pasien dengan gangguan jiwa, faktor presipitasi juga dapat berupa putus obat, kekambuhan gejala, halusinasi perintah, waham curiga, atau penyalahgunaan zat. Misalnya, pasien yang mendengar suara yang menyuruhnya menyerang orang lain memiliki risiko lebih tinggi melakukan kekerasan, terutama jika pasien percaya penuh terhadap suara tersebut dan tidak mampu mengontrol dorongannya.

Putus obat atau ketidakpatuhan terhadap terapi menjadi salah satu faktor presipitasi yang sering ditemukan. Obat yang diberikan pada pasien dengan gangguan jiwa dapat membantu menstabilkan emosi, mengurangi halusinasi, menurunkan kecurigaan, dan meningkatkan kemampuan pasien mengendalikan perilaku. Ketika pasien menghentikan obat tanpa arahan tenaga kesehatan, gejala dapat muncul kembali dan memicu risiko perilaku kekerasan. Selain itu, penyalahgunaan zat seperti alkohol atau narkoba juga dapat menurunkan kontrol diri, meningkatkan impulsivitas, dan memperberat gangguan persepsi maupun proses pikir. Oleh karena itu, pengkajian terhadap riwayat penggunaan obat, kepatuhan terapi, dan penggunaan zat sangat penting dalam memahami risiko perilaku kekerasan.

Risiko perilaku kekerasan juga dapat dipahami melalui rentang respons marah hingga perilaku kekerasan. Marah pada dasarnya merupakan emosi normal yang dapat dialami setiap orang ketika merasa terancam, dirugikan, kecewa, atau tidak dipahami. Dalam rentang respons adaptif, marah dapat diungkapkan secara sehat melalui komunikasi asertif, yaitu menyampaikan perasaan, kebutuhan, atau ketidaksetujuan dengan cara yang jelas tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Pada tahap ini, individu masih mampu berpikir jernih, mengontrol ucapan, dan mencari solusi. Namun, apabila marah tidak dikelola dengan baik, respons dapat bergerak ke arah maladaptif, seperti menyimpan dendam, menyalahkan orang lain, berbicara kasar, mengancam, hingga melakukan kekerasan fisik.

Pada tahap awal, pasien mungkin hanya menunjukkan rasa tidak nyaman, kesal, atau tersinggung. Jika tidak ditangani, kemarahan dapat meningkat menjadi frustrasi, agitasi, dan perilaku verbal agresif. Pasien mulai berbicara keras, membentak, mengeluh berlebihan, atau menolak diarahkan. Jika situasi terus memanas, pasien dapat menunjukkan tanda fisik seperti mengepalkan tangan, mondar-mandir, menatap tajam, memukul meja, atau mendekati orang lain dengan sikap mengancam. Pada tahap yang lebih berat, pasien dapat melakukan perilaku kekerasan aktual, seperti memukul, menendang, mendorong, melukai diri sendiri, menyerang orang lain, atau merusak lingkungan. Pemahaman mengenai

rentang respons ini penting agar perawat dapat melakukan intervensi sejak tanda awal muncul, bukan menunggu sampai kekerasan terjadi.

Dampak risiko perilaku kekerasan terhadap keselamatan pasien dan orang lain sangat besar. Bagi pasien, perilaku kekerasan dapat menyebabkan cedera fisik, luka, kelelahan, rasa bersalah, penyesalan, peningkatan stigma, serta memburuknya hubungan sosial. Pasien yang melakukan kekerasan dapat mengalami penolakan dari keluarga, masyarakat, atau lingkungan perawatan. Selain itu, pasien dapat membutuhkan pengawasan lebih ketat atau tindakan pembatasan apabila membahayakan keselamatan. Hal ini dapat memengaruhi harga diri pasien dan memperpanjang proses pemulihan. Risiko perilaku kekerasan juga dapat menyebabkan pasien kehilangan kesempatan untuk berinteraksi secara sehat karena orang lain menjadi takut mendekatinya.

Bagi orang lain, perilaku kekerasan dapat menimbulkan cedera fisik, trauma psikologis, rasa takut, dan gangguan rasa aman. Keluarga yang merawat pasien dapat merasa cemas, tidak berdaya, atau takut berada di dekat pasien. Perawat dan tenaga kesehatan juga dapat mengalami ancaman keselamatan ketika menangani pasien dengan risiko kekerasan, terutama jika risiko tidak dikaji dan dikelola dengan baik. Pasien lain di ruang perawatan dapat merasa terganggu atau takut apabila menyaksikan perilaku agresif. Oleh karena itu, penanganan risiko perilaku kekerasan harus selalu mempertimbangkan keselamatan semua pihak, bukan hanya pasien yang bersangkutan.

Lingkungan perawatan juga dapat terdampak oleh perilaku kekerasan. Fasilitas dapat rusak, suasana ruangan menjadi tidak kondusif, proses pelayanan terganggu, dan tim kesehatan harus mengalihkan perhatian pada situasi krisis. Jika kejadian kekerasan sering terjadi, lingkungan perawatan dapat menjadi tidak aman dan menimbulkan tekanan bagi pasien lain maupun petugas. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan pengkajian risiko secara komprehensif, menjaga lingkungan bebas dari benda berbahaya, mengurangi stimulus pemicu, serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pasien yang menunjukkan tanda peningkatan emosi. Tindakan pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan setelah kekerasan terjadi.

konsep dasar risiko perilaku kekerasan mencakup pemahaman mengenai pengertian, tanda dan gejala, faktor predisposisi dan presipitasi, rentang respons marah, serta dampaknya terhadap keselamatan. Risiko perilaku kekerasan bukan hanya masalah perilaku, tetapi merupakan kondisi kompleks yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, lingkungan, dan kemampuan coping pasien. Perawat memiliki peran penting dalam mengenali tanda awal, menilai tingkat risiko, memahami faktor pencetus, serta melakukan intervensi yang aman dan

terapeutik. Pemahaman yang baik mengenai konsep ini akan membantu perawat mencegah terjadinya perilaku kekerasan, menjaga keselamatan pasien dan orang lain, serta mendukung proses pemulihan pasien secara lebih optimal.

C. Konsep Dasar Intervensi Keperawatan Jiwa pada Risiko Perilaku Kekerasan

Intervensi keperawatan jiwa pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan merupakan serangkaian tindakan profesional yang dilakukan perawat untuk membantu pasien mengenali, mengendalikan, dan menyalurkan kemarahan secara aman serta adaptif. Risiko perilaku kekerasan bukan hanya berkaitan dengan kemungkinan pasien melakukan tindakan fisik yang membahayakan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk respons maladaptif seperti mengancam, membentak, memaki, merusak benda, melukai diri sendiri, atau menunjukkan sikap bermusuhan terhadap orang lain. Oleh karena itu, intervensi keperawatan harus dirancang secara komprehensif, terarah, dan berkesinambungan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien, orang lain, dan lingkungan perawatan. Perawat perlu memahami bahwa perilaku kekerasan sering kali merupakan puncak dari akumulasi emosi yang tidak terkelola, seperti marah, takut, kecewa, frustrasi, cemas, atau merasa terancam. Dengan demikian, intervensi tidak hanya berfokus pada menghentikan perilaku agresif, tetapi juga membantu pasien memahami penyebab emosi, mengenali tanda awal peningkatan marah, dan menggunakan strategi pengendalian yang lebih sehat.

Tujuan utama intervensi keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan adalah mencegah terjadinya tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Selain itu, intervensi juga bertujuan membantu pasien meningkatkan kemampuan mengontrol emosi, mengungkapkan perasaan secara tepat, mengembangkan mekanisme koping yang adaptif, serta meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara aman. Pada tahap awal, tujuan intervensi lebih diarahkan pada stabilisasi kondisi pasien dan pencegahan cedera. Perawat perlu memastikan bahwa pasien berada dalam lingkungan yang aman, tidak memiliki akses terhadap benda berbahaya, dan mendapatkan pengawasan sesuai tingkat risiko. Setelah kondisi pasien lebih stabil, tujuan intervensi dapat diperluas pada peningkatan kesadaran pasien terhadap perilaku dan emosinya, latihan keterampilan pengendalian marah, peningkatan kepatuhan terapi, serta persiapan pasien dan keluarga dalam mencegah kekambuhan perilaku kekerasan.

Intervensi keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan juga bertujuan meningkatkan kemampuan pasien dalam mengenali hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Banyak pasien yang mengalami kesulitan mengidentifikasi

bahwa kemarahan yang muncul dapat dipengaruhi oleh cara mereka menafsirkan situasi. Misalnya, pasien yang merasa diremehkan atau diancam mungkin akan merespons dengan marah, meskipun orang lain tidak bermaksud demikian. Pada pasien dengan gangguan jiwa, kondisi ini dapat diperberat oleh halusinasi, waham curiga, gangguan proses pikir, atau ketidakmampuan membedakan realitas. Oleh karena itu, perawat membantu pasien secara perlahan untuk memahami bahwa kemarahan tidak selalu harus diekspresikan melalui tindakan agresif. Pasien perlu dibimbing agar mampu mengenali perasaan marah sebagai sinyal bahwa ada kebutuhan, ketidaknyamanan, atau masalah yang perlu diungkapkan dengan cara yang lebih aman.

Langkah penting dalam intervensi keperawatan jiwa adalah membina hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Hubungan saling percaya menjadi dasar keberhasilan seluruh intervensi karena pasien yang merasa aman dan dihargai akan lebih mudah terbuka, lebih kooperatif, dan lebih bersedia mengikuti latihan pengendalian marah. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, membangun hubungan saling percaya tidak selalu mudah karena pasien dapat tampak curiga, marah, menolak, atau merasa terancam. Perawat perlu menggunakan pendekatan yang tenang, konsisten, tidak menghakimi, dan tidak provokatif. Perawat dapat memulai interaksi dengan memperkenalkan diri, memanggil pasien dengan nama yang disukai, menjelaskan tujuan pertemuan, serta membuat kontrak komunikasi yang sederhana. Sikap perawat yang ramah, sabar, dan dapat diprediksi akan membantu pasien merasa lebih aman.

Dalam membina hubungan saling percaya, perawat harus mampu menunjukkan empati tanpa membenarkan perilaku kekerasan. Misalnya, ketika pasien tampak marah dan mengatakan bahwa ia ingin memukul seseorang, perawat perlu mengakui bahwa pasien sedang marah, tetapi tetap memberikan batasan bahwa menyakiti orang lain bukan tindakan yang dapat diterima. Perawat dapat mengatakan dengan tenang bahwa ia memahami pasien sedang sangat marah, tetapi perawat akan membantu pasien mengungkapkan kemarahannya dengan cara yang aman. Pendekatan seperti ini penting karena pasien tidak merasa langsung disalahkan, tetapi juga memahami bahwa ada batas perilaku yang harus dijaga. Hubungan saling percaya dibangun melalui konsistensi perawat dalam menjaga keamanan, mendengarkan pasien, memberikan informasi yang jelas, dan memenuhi janji yang telah disepakati.

Intervensi berikutnya adalah membantu pasien mengenali penyebab marah dan tanda-tanda emosi meningkat. Kemampuan mengenali penyebab marah merupakan dasar penting agar pasien dapat mencegah kemarahan berkembang menjadi perilaku kekerasan. Perawat dapat membantu pasien mengidentifikasi

situasi, orang, pikiran, atau peristiwa yang sering memicu kemarahan. Penyebab marah dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa rasa takut, kecewa, cemas, harga diri rendah, halusinasi, waham curiga, nyeri, kelelahan, atau perasaan tidak berdaya. Faktor eksternal dapat berupa konflik dengan keluarga, teguran dari orang lain, lingkungan yang bising, perasaan tidak dihargai, keterbatasan aktivitas, atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dengan mengenali penyebab marah, pasien dapat mulai memahami pola emosinya dan belajar menghindari atau menghadapi pencetus dengan cara yang lebih adaptif.

Selain penyebab marah, pasien juga perlu dibantu mengenali tanda-tanda saat emosinya mulai meningkat. Tanda-tanda tersebut dapat muncul pada aspek fisik, emosional, kognitif, dan perilaku. Secara fisik, pasien mungkin merasakan jantung berdebar, napas menjadi cepat, wajah terasa panas, otot menegang, tangan mengepal, atau tubuh terasa ingin bergerak. Secara emosional, pasien dapat merasa kesal, tersinggung, cemas, takut, atau tidak sabar. Secara kognitif, pasien mungkin mulai berpikir bahwa orang lain sedang mengancam, merendahkan, atau sengaja memancing kemarahannya. Secara perilaku, pasien dapat mulai berbicara keras, mondar-mandir, menatap tajam, menolak instruksi, membanting benda, atau mengeluarkan ancaman. Perawat perlu membantu pasien menyadari bahwa tanda-tanda awal tersebut merupakan sinyal untuk segera menggunakan teknik pengendalian marah sebelum kondisi menjadi lebih berat.

Proses membantu pasien mengenali marah perlu dilakukan secara bertahap dan tidak menyalahkan. Perawat dapat mengajak pasien mengingat situasi sebelumnya ketika pasien marah, kemudian mendiskusikan apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang dilakukan pasien saat itu. Perawat perlu menghindari kalimat yang membuat pasien merasa dihakimi, seperti menyebut pasien kasar atau berbahaya. Sebaliknya, perawat dapat menggunakan pertanyaan terapeutik untuk membantu pasien memahami dirinya, misalnya dengan menanyakan apa yang biasanya membuat pasien marah, bagaimana tubuh pasien bereaksi ketika marah, atau apa yang biasanya dilakukan pasien saat merasa tidak mampu mengendalikan emosi. Dengan cara ini, pasien didorong untuk melakukan refleksi diri dan belajar mengenali pola perilakunya.

Latihan mengontrol marah merupakan inti dari intervensi keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan. Pengendalian marah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu secara fisik, verbal, spiritual, dan farmakologis. Latihan secara fisik bertujuan membantu pasien menyalurkan energi marah dengan cara yang aman dan tidak membahayakan. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah latihan napas dalam. Ketika pasien mulai merasa marah, perawat dapat

membimbing pasien menarik napas perlahan melalui hidung, menahan sebentar, kemudian menghembuskan perlahan melalui mulut. Latihan ini membantu menurunkan ketegangan tubuh, memperlambat napas, dan memberikan waktu bagi pasien untuk berpikir sebelum bertindak. Teknik ini sederhana, mudah diajarkan, dan dapat dilakukan pasien secara mandiri apabila dilatih secara berulang.

Selain napas dalam, latihan relaksasi otot juga dapat digunakan untuk membantu pasien mengurangi ketegangan fisik akibat marah. Pasien dapat diajarkan untuk mengenali bagian tubuh yang tegang, kemudian mengendurkannya secara perlahan. Aktivitas fisik terarah juga dapat menjadi cara aman untuk menyalurkan energi, seperti berjalan di area aman, melakukan peregangan ringan, meremas bola stres, atau memukul bantal sesuai arahan perawat. Namun, aktivitas fisik harus disesuaikan dengan kondisi pasien dan tetap diawasi, terutama jika pasien masih menunjukkan risiko agresif tinggi. Tujuan aktivitas fisik bukan untuk memperkuat perilaku kekerasan, tetapi untuk menyediakan saluran energi yang aman sehingga pasien tidak melampiaskan marah kepada diri sendiri, orang lain, atau benda di lingkungan.

Pengendalian marah secara verbal bertujuan membantu pasien mengungkapkan kemarahan melalui kata-kata yang tepat, bukan melalui ancaman atau tindakan fisik. Banyak pasien dengan risiko perilaku kekerasan belum mampu menyampaikan ketidaknyamanan secara asertif. Mereka mungkin langsung membentak, mengancam, atau memukul ketika merasa marah. Perawat dapat melatih pasien menggunakan komunikasi asertif, yaitu menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan batasan dengan jelas tanpa menyakiti orang lain. Misalnya, pasien dapat dilatih mengatakan bahwa ia sedang marah dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, atau mengatakan bahwa ia tidak suka diperlakukan dengan cara tertentu. Komunikasi asertif membantu pasien merasa tetap memiliki kendali atas dirinya tanpa harus menggunakan kekerasan.

Latihan verbal juga mencakup kemampuan meminta bantuan ketika pasien mulai merasa tidak mampu mengontrol marah. Pasien dapat diajarkan untuk segera mendekati perawat, keluarga, atau orang yang dipercaya ketika tanda-tanda marah mulai muncul. Pasien juga dapat dilatih menggunakan kalimat pendek yang aman, seperti meminta waktu untuk sendiri di tempat yang aman, meminta ditemani, atau meminta bantuan untuk melakukan latihan napas dalam. Kemampuan meminta bantuan merupakan tanda penting bahwa pasien mulai mampu mengenali risiko dan memilih cara yang lebih adaptif. Perawat perlu memberikan penguatan positif ketika pasien berhasil mengungkapkan marah secara verbal tanpa mengancam atau menyakiti orang lain.

Pengendalian marah secara spiritual juga dapat menjadi bagian penting dari intervensi keperawatan, terutama bagi pasien yang memiliki keyakinan agama atau nilai spiritual tertentu. Pendekatan spiritual dapat membantu pasien memperoleh ketenangan, makna, harapan, dan kekuatan dalam menghadapi emosi. Perawat dapat membantu pasien menggunakan kegiatan spiritual sesuai keyakinannya, seperti berdoa, berzikir, membaca kitab suci, meditasi, atau melakukan refleksi diri. Intervensi spiritual harus dilakukan dengan menghormati agama, budaya, dan pilihan pasien. Perawat tidak boleh memaksakan praktik spiritual tertentu, tetapi dapat memfasilitasi pasien untuk menggunakan sumber kekuatan yang sesuai dengan keyakinannya. Pada beberapa pasien, pendekatan spiritual dapat membantu menurunkan ketegangan, meningkatkan kesabaran, dan memperkuat motivasi untuk mengontrol perilaku.

Pengendalian marah secara farmakologis dilakukan melalui kolaborasi dengan dokter dan tim kesehatan. Pada pasien dengan gangguan jiwa, obat dapat membantu menurunkan gejala yang berkontribusi terhadap perilaku kekerasan, seperti halusinasi, waham, kecemasan berat, impulsivitas, agitasi, atau gangguan mood. Perawat berperan penting dalam memastikan pasien memahami manfaat obat, memantau kepatuhan minum obat, mengobservasi efek terapi, serta mengenali efek samping yang mungkin muncul. Perawat juga perlu membantu pasien memahami bahwa obat bukan bentuk hukuman, tetapi bagian dari upaya membantu pasien mengendalikan gejala dan menjaga keselamatan. Ketidakpatuhan minum obat dapat meningkatkan risiko kekambuhan dan perilaku kekerasan, sehingga edukasi dan dukungan terhadap kepatuhan terapi menjadi bagian penting dari intervensi.

Perawat juga memiliki peran besar dalam menjaga keamanan pasien dan lingkungan. Pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan, keamanan harus menjadi prioritas sejak awal. Perawat perlu melakukan pengkajian risiko secara berkala, mengamati tanda-tanda peningkatan emosi, dan memastikan lingkungan bebas dari benda yang dapat digunakan untuk mencederai diri sendiri atau orang lain. Benda tajam, tali, kaca, alat berat, atau benda yang mudah dilempar perlu dijauhkan dari jangkauan pasien apabila risiko meningkat. Perawat juga perlu mengatur lingkungan agar tidak terlalu bising, tidak terlalu ramai, dan tidak memicu ketegangan. Lingkungan yang aman dan tenang dapat membantu pasien lebih mudah mengontrol emosi.

Dalam menjaga keamanan, perawat juga harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dan tim. Perawat perlu menjaga jarak aman ketika pasien tampak gelisah atau marah, tidak menyudutkan pasien, tidak menghalangi jalan keluar, dan tidak menyentuh pasien tanpa izin. Bila pasien menunjukkan tanda risiko tinggi

seperti membawa benda berbahaya, mengancam, tidak dapat diarahkan, atau mulai menyerang, perawat harus segera meminta bantuan tim sesuai prosedur. Keamanan tidak berarti memperlakukan pasien secara kasar atau merendahkan, tetapi menciptakan kondisi yang mencegah cedera sekaligus tetap menghargai martabat pasien. Tindakan pembatasan fisik hanya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir apabila semua upaya lain tidak berhasil dan pasien berada dalam risiko tinggi mencederai diri sendiri atau orang lain, serta harus dilakukan sesuai prosedur dan pengawasan ketat.

Pelibatan keluarga merupakan komponen penting dalam pengendalian perilaku kekerasan, terutama karena proses pemulihan pasien tidak hanya berlangsung di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga berlanjut di rumah dan masyarakat. Keluarga sering menjadi pihak yang paling dekat dengan pasien dan dapat membantu mengenali perubahan perilaku sejak dini. Perawat perlu memberikan edukasi kepada keluarga mengenai tanda-tanda awal peningkatan marah, faktor pencetus, cara berkomunikasi yang tidak memicu emosi, serta langkah yang perlu dilakukan ketika pasien mulai menunjukkan risiko kekerasan. Keluarga perlu memahami bahwa perilaku kekerasan sering kali berkaitan dengan ketidakmampuan pasien mengelola emosi atau gejala gangguan jiwa, sehingga respons keluarga harus tetap tenang, aman, dan tidak provokatif.

Keluarga juga perlu dilibatkan dalam membantu pasien menjalankan latihan pengendalian marah. Misalnya, keluarga dapat mengingatkan pasien untuk melakukan napas dalam, menjauh dari situasi yang memicu marah, berbicara dengan lebih tenang, melakukan aktivitas fisik yang aman, atau menggunakan pendekatan spiritual sesuai keyakinan pasien. Selain itu, keluarga dapat membantu memantau kepatuhan minum obat dan jadwal kontrol. Dukungan keluarga yang baik dapat menurunkan risiko kekambuhan dan meningkatkan keberhasilan intervensi. Namun, perawat juga perlu mengkaji kesiapan keluarga, karena tidak semua keluarga memiliki pemahaman, kesabaran, atau sumber daya yang cukup. Keluarga yang mengalami kelelahan, ketakutan, atau konflik dengan pasien juga membutuhkan dukungan dan edukasi lanjutan.

Dalam pelibatan keluarga, perawat perlu mengajarkan cara menciptakan lingkungan rumah yang aman dan suportif. Keluarga perlu menghindari komunikasi yang menyudutkan, mengejek, membentak, atau mempermalukan pasien. Ketika pasien mulai marah, keluarga sebaiknya tidak membalas dengan kemarahan, tidak menantang, dan tidak mengerumuni pasien. Sebaliknya, keluarga perlu berbicara dengan suara tenang, memberikan ruang aman, mengurangi stimulus, dan meminta bantuan tenaga kesehatan apabila risiko meningkat. Keluarga juga perlu mengetahui kapan harus membawa pasien ke fasilitas

pelayanan kesehatan, terutama jika pasien mulai mengancam, membawa benda berbahaya, tidak tidur sehari-hari, mendengar suara yang menyuruh melakukan kekerasan, atau berhenti minum obat.

intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan mencakup berbagai tindakan yang saling berkaitan, mulai dari membina hubungan saling percaya, membantu pasien mengenali penyebab marah dan tanda-tanda emosi meningkat, melatih pengendalian marah secara fisik, verbal, spiritual, dan farmakologis, menjaga keamanan pasien dan lingkungan, hingga melibatkan keluarga dalam proses perawatan. Intervensi ini harus dilakukan secara bertahap, konsisten, dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Keberhasilan intervensi tidak hanya terlihat dari tidak terjadinya perilaku kekerasan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan pasien mengenali emosi, memilih cara pengendalian yang aman, meminta bantuan saat diperlukan, mematuhi terapi, serta berinteraksi dengan lingkungan secara lebih adaptif. Perawat berperan sebagai pendamping, pendidik, fasilitator, pengamat, dan pelindung yang membantu pasien mencapai kondisi yang lebih stabil, aman, dan produktif.

D. Konsep Evaluasi Keberhasilan Intervensi Keperawatan

Evaluasi dalam proses keperawatan jiwa merupakan tahap penting yang dilakukan untuk menilai sejauh mana intervensi keperawatan yang telah diberikan mampu menghasilkan perubahan pada kondisi pasien. Evaluasi tidak hanya berarti melihat apakah tindakan telah dilakukan, tetapi juga menilai apakah tindakan tersebut memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan asuhan keperawatan. Dalam konteks pasien dengan risiko perilaku kekerasan, evaluasi menjadi sangat penting karena masalah yang dihadapi berhubungan langsung dengan keselamatan pasien, perawat, keluarga, pasien lain, dan lingkungan sekitar. Perawat perlu mengetahui apakah pasien mengalami penurunan dorongan agresif, mampu mengenali tanda-tanda marah, dapat menggunakan teknik pengendalian emosi, serta tidak menunjukkan perilaku yang membahayakan.

Evaluasi dalam keperawatan jiwa memiliki karakteristik yang berbeda dengan evaluasi pada beberapa kondisi fisik karena perubahan yang dinilai sering kali berkaitan dengan aspek psikologis, emosional, kognitif, perilaku, dan sosial. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, keberhasilan intervensi tidak hanya dilihat dari tidak adanya tindakan kekerasan, tetapi juga dari kemampuan pasien memahami penyebab kemarahannya, mengungkapkan perasaan secara verbal, memilih cara yang aman saat emosi meningkat, mengikuti arahan perawat, serta menunjukkan peningkatan kontrol diri. Dengan demikian, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada satu indikator. Pasien yang tidak

melakukan kekerasan secara fisik, tetapi masih sering mengancam, mudah tersinggung, atau belum mampu mengontrol emosi, tetap membutuhkan intervensi lanjutan.

Pengertian evaluasi dalam proses keperawatan jiwa dapat dipahami sebagai proses membandingkan respons pasien setelah diberikan intervensi dengan tujuan atau kriteria hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah masalah keperawatan mengalami perbaikan, tetap, atau memburuk. Jika tujuan asuhan telah tercapai, maka intervensi dapat dipertahankan, dilanjutkan sebagai penguatan, atau secara bertahap dihentikan. Jika tujuan belum tercapai, perawat perlu meninjau kembali intervensi yang digunakan, faktor penghambat, kondisi pasien, serta dukungan yang tersedia. Evaluasi juga membantu perawat menentukan apakah diagnosis keperawatan masih relevan atau perlu diperbarui sesuai perkembangan pasien.

Dalam kasus risiko perilaku kekerasan, evaluasi mencakup penilaian terhadap perubahan respons pasien setelah diberikan intervensi pengendalian marah. Misalnya, sebelum intervensi pasien tampak sering membentak, mengepalkan tangan, sulit diarahkan, dan mengancam orang lain. Setelah intervensi diberikan, perawat menilai apakah pasien mulai mampu berbicara lebih tenang, menyampaikan marah tanpa mengancam, menggunakan latihan napas dalam, meminta bantuan saat emosi meningkat, atau menjauh dari situasi pemicu. Perubahan-perubahan tersebut menjadi bukti bahwa intervensi memberikan dampak positif. Namun, jika pasien tetap menunjukkan perilaku agresif, menolak latihan, atau semakin sulit dikendalikan, maka evaluasi menunjukkan perlunya modifikasi intervensi atau kolaborasi lebih lanjut dengan tim kesehatan.

Tujuan utama evaluasi adalah menilai perubahan respons pasien. Respons pasien dapat mencakup respons kognitif, afektif, perilaku, sosial, dan fisiologis. Respons kognitif berkaitan dengan kemampuan pasien memahami penyebab marah, mengenali tanda-tanda emosi meningkat, dan mengetahui cara yang tepat untuk mengendalikan marah. Respons afektif berkaitan dengan kemampuan pasien mengenali perasaannya, mengungkapkan emosi secara lebih sehat, dan menunjukkan penurunan kecemasan atau kemarahan. Respons perilaku dapat dilihat dari berkurangnya perilaku mengancam, meningkatnya kemampuan mengikuti arahan, tidak merusak benda, dan tidak mencederai diri sendiri maupun orang lain. Respons sosial tampak dari kemampuan pasien berinteraksi lebih baik dengan perawat, keluarga, atau pasien lain. Sementara itu, respons fisiologis dapat terlihat dari penurunan ketegangan tubuh, napas lebih teratur, wajah lebih rileks, dan penurunan aktivitas motorik berlebihan.

Evaluasi juga bertujuan untuk menilai apakah pasien mampu menerapkan keterampilan yang telah diajarkan. Dalam intervensi keperawatan jiwa, pasien risiko perilaku kekerasan sering diajarkan berbagai cara mengontrol marah, seperti menarik napas dalam, relaksasi, menyalurkan energi secara aman, berbicara asertif, berdoa atau menggunakan pendekatan spiritual, serta minum obat sesuai anjuran. Perawat perlu mengevaluasi apakah pasien hanya mengetahui teknik tersebut secara teori atau sudah mampu mempraktikkannya dalam situasi nyata. Misalnya, pasien mungkin dapat menyebutkan cara mengontrol marah saat ditanya, tetapi belum mampu menggunakannya ketika benar-benar marah. Oleh karena itu, evaluasi tidak cukup dilakukan melalui wawancara, tetapi juga melalui observasi langsung terhadap perilaku pasien.

Evaluasi menjadi dasar penting untuk menentukan keberlanjutan, modifikasi, atau penghentian intervensi keperawatan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pasien mengalami perkembangan positif, intervensi dapat dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan yang sudah terbentuk. Contohnya, jika pasien mulai mampu melakukan napas dalam saat marah, perawat dapat melanjutkan latihan tersebut secara terjadwal dan meningkatkan penerapannya dalam situasi yang lebih menantang. Jika pasien sudah mampu mengungkapkan marah secara verbal tanpa mengancam, perawat dapat melanjutkan latihan komunikasi asertif agar kemampuan tersebut semakin stabil. Keberlanjutan intervensi diperlukan agar perilaku adaptif menjadi kebiasaan baru yang dapat dipertahankan oleh pasien.

Sebaliknya, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa intervensi belum efektif, maka perawat perlu melakukan modifikasi. Modifikasi dapat dilakukan dengan menyesuaikan cara penyampaian, frekuensi latihan, tingkat kesulitan, pendekatan komunikasi, atau melibatkan dukungan tambahan. Misalnya, pasien yang sulit memahami instruksi mungkin memerlukan penjelasan yang lebih sederhana dan latihan yang lebih sering. Pasien yang mudah marah saat berada di lingkungan ramai mungkin membutuhkan pengaturan lingkungan yang lebih tenang. Pasien yang menunjukkan perilaku kekerasan karena halusinasi perintah memerlukan intervensi yang juga berfokus pada manajemen halusinasi. Pasien yang tidak patuh obat memerlukan edukasi tambahan dan pelibatan keluarga. Dengan demikian, evaluasi membantu perawat menyesuaikan intervensi agar lebih tepat dengan kebutuhan pasien.

Penghentian intervensi dapat dipertimbangkan apabila tujuan telah tercapai secara konsisten dan pasien menunjukkan kemampuan yang stabil dalam mengendalikan perilaku. Namun, pada pasien risiko perilaku kekerasan, penghentian intervensi tidak berarti perawat berhenti memantau kondisi pasien sepenuhnya. Penghentian biasanya bersifat bertahap dan tetap disertai

pemantauan lanjutan, terutama jika pasien memiliki riwayat kekambuhan, gangguan jiwa kronis, atau faktor pencetus yang masih ada. Misalnya, pasien yang sudah mampu mengontrol marah selama perawatan tetap perlu mendapatkan rencana tindak lanjut, edukasi keluarga, jadwal kontrol, dan strategi pencegahan kekambuhan setelah pulang. Dengan demikian, keputusan menghentikan intervensi harus dibuat secara hati-hati berdasarkan data yang objektif dan berkesinambungan.

Dalam evaluasi keperawatan, dikenal evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses berfokus pada pelaksanaan intervensi, yaitu apakah tindakan keperawatan telah dilakukan sesuai rencana, bagaimana respons pasien selama tindakan, serta apakah terdapat hambatan saat intervensi berlangsung. Misalnya, ketika perawat mengajarkan teknik napas dalam kepada pasien, evaluasi proses mencakup apakah pasien bersedia mengikuti latihan, apakah pasien memahami instruksi, apakah pasien mampu melakukan langkah-langkah dengan benar, dan bagaimana kondisi emosi pasien selama latihan. Evaluasi proses membantu perawat menilai kualitas pelaksanaan intervensi dan memperbaiki cara pemberian tindakan jika diperlukan.

Evaluasi hasil berfokus pada perubahan yang terjadi setelah intervensi dilakukan. Evaluasi ini menilai apakah tujuan atau kriteria hasil yang telah ditetapkan tercapai. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, evaluasi hasil dapat mencakup apakah pasien tidak lagi mengancam, tidak mencederai diri sendiri atau orang lain, mampu menyebutkan penyebab marah, mampu menggunakan teknik pengendalian marah, dan mampu meminta bantuan saat emosi meningkat. Evaluasi hasil biasanya dilakukan dengan membandingkan kondisi pasien sebelum dan sesudah intervensi. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai, perawat perlu meninjau kembali apakah tujuan terlalu tinggi, intervensi kurang tepat, atau ada faktor lain yang menghambat keberhasilan.

Perbedaan antara evaluasi proses dan evaluasi hasil penting dipahami agar perawat tidak hanya menilai akhir dari intervensi, tetapi juga memperhatikan bagaimana intervensi tersebut dilakukan. Ada kalanya hasil belum tercapai bukan karena pasien tidak mampu, tetapi karena proses intervensi kurang sesuai. Misalnya, pasien tidak berhasil melakukan teknik relaksasi bukan karena menolak, tetapi karena penjelasan terlalu cepat atau lingkungan terlalu bising. Evaluasi proses membantu menemukan hambatan tersebut. Sebaliknya, intervensi dapat terlaksana dengan baik, tetapi hasil belum optimal karena faktor lain seperti gejala psikotik masih aktif, dukungan keluarga kurang, atau obat belum bekerja optimal. Oleh karena itu, kedua jenis evaluasi harus dilakukan bersama agar perawat memperoleh gambaran yang lengkap.

Prinsip pertama dalam evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan adalah objektif. Evaluasi harus didasarkan pada data nyata, bukan asumsi atau kesan pribadi perawat. Data objektif dapat berupa perilaku pasien yang tampak, kemampuan pasien mempraktikkan teknik pengendalian marah, frekuensi ancaman yang berkurang, tidak adanya tindakan kekerasan, serta respons pasien dalam interaksi. Data subjektif dari pasien juga tetap penting, misalnya pasien mengatakan merasa lebih tenang, mampu menahan marah, atau mengetahui cara meminta bantuan. Namun, data subjektif perlu dikaitkan dengan data objektif agar evaluasi lebih akurat. Evaluasi yang objektif membantu mencegah kesalahan dalam menyimpulkan keberhasilan intervensi.

Prinsip kedua adalah sistematis. Evaluasi harus dilakukan secara teratur dan mengikuti kerangka proses keperawatan. Perawat perlu menilai tujuan yang telah ditetapkan, mengumpulkan data, membandingkan data dengan kriteria hasil, menentukan tingkat keberhasilan, dan menetapkan tindak lanjut. Evaluasi yang tidak sistematis dapat menyebabkan perkembangan pasien tidak terpantau dengan baik. Misalnya, perawat hanya menilai pasien tampak tenang tanpa mengevaluasi apakah pasien benar-benar mampu menggunakan teknik kontrol marah. Evaluasi sistematis memastikan bahwa setiap aspek penting dinilai, mulai dari kemampuan kognitif, emosi, perilaku, kepatuhan terapi, hingga keamanan lingkungan.

Prinsip ketiga adalah terukur. Evaluasi yang baik harus memiliki kriteria hasil yang jelas sehingga perubahan pasien dapat dinilai secara lebih konkret. Misalnya, tujuan "pasien lebih tenang" perlu dijabarkan menjadi kriteria yang lebih terukur, seperti pasien mampu berbicara dengan nada suara normal, tidak mengancam selama interaksi, mampu melakukan napas dalam sebanyak beberapa kali saat marah, atau tidak melakukan tindakan merusak selama periode tertentu. Kriteria yang terukur membantu perawat menentukan apakah tujuan tercapai sepenuhnya, sebagian, atau belum tercapai. Dalam dokumentasi, hasil yang terukur juga memudahkan perawat lain dan tim kesehatan memahami perkembangan pasien.

Prinsip keempat adalah berkesinambungan. Evaluasi pada pasien risiko perilaku kekerasan tidak dapat dilakukan hanya sekali karena kondisi emosi dan perilaku pasien dapat berubah dari waktu ke waktu. Pasien yang tampak stabil pada pagi hari dapat kembali gelisah pada malam hari, terutama jika ada pencetus seperti konflik, kurang tidur, atau perubahan lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara berulang sesuai kondisi pasien. Evaluasi berkesinambungan membantu perawat mendeteksi perubahan lebih awal, mencegah terjadinya kekerasan, dan memperkuat intervensi yang telah berhasil. Prinsip ini juga penting

dalam perencanaan pulang, karena pasien tetap membutuhkan pemantauan dan dukungan setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Evaluasi yang baik juga harus melibatkan pasien sebagai subjek aktif dalam proses perawatan. Perawat perlu mengajak pasien menilai perkembangan dirinya, misalnya dengan menanyakan apakah pasien merasa lebih mampu mengontrol marah, teknik apa yang paling membantu, situasi apa yang masih sulit dihadapi, dan bantuan apa yang masih dibutuhkan. Dengan melibatkan pasien, evaluasi menjadi lebih bermakna karena pasien belajar mengenali kemajuan dan hambatan dirinya sendiri. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pasien terhadap proses pemulihan. Pada pasien yang sudah cukup stabil, evaluasi bersama dapat menjadi sarana untuk memperkuat motivasi dan kemandirian dalam mengelola emosi.

Keluarga juga dapat dilibatkan dalam evaluasi, terutama jika pasien akan kembali ke rumah. Keluarga dapat memberikan informasi mengenai perilaku pasien di rumah, kepatuhan minum obat, kemampuan menggunakan teknik kontrol marah, serta faktor pencetus yang masih sering muncul. Keterlibatan keluarga membantu perawat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan menyusun tindak lanjut yang lebih realistis. Namun, pelibatan keluarga harus tetap memperhatikan kerahasiaan, persetujuan pasien, dan hubungan keluarga dengan pasien. Jika keluarga menjadi salah satu sumber konflik, perawat perlu melakukan pendekatan yang hati-hati agar evaluasi tidak menambah ketegangan.

konsep evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan mencakup pengertian evaluasi sebagai proses membandingkan respons pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan, tujuan evaluasi untuk menilai perubahan respons pasien, serta fungsi evaluasi sebagai dasar menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Evaluasi proses dan evaluasi hasil harus dipahami sebagai dua hal yang saling melengkapi. Evaluasi proses menilai bagaimana intervensi dilakukan, sedangkan evaluasi hasil menilai perubahan yang terjadi setelah intervensi. Agar evaluasi bermakna, perawat harus menerapkan prinsip objektif, sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Melalui evaluasi yang tepat, asuhan keperawatan jiwa menjadi lebih aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

E. Indikator Keberhasilan Intervensi pada Pasien Risiko Perilaku Kekerasan

Indikator keberhasilan intervensi pada pasien risiko perilaku kekerasan merupakan ukuran atau tanda yang digunakan perawat untuk menilai apakah tindakan keperawatan yang telah diberikan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan asuhan. Pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan, keberhasilan

intervensi tidak hanya dilihat dari tidak terjadinya tindakan kekerasan secara fisik, tetapi juga dari kemampuan pasien mengenali emosi, memahami penyebab kemarahan, mengontrol dorongan agresif, berkomunikasi secara lebih adaptif, mematuhi terapi, serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Dengan adanya indikator keberhasilan yang jelas, perawat dapat mengevaluasi perkembangan pasien secara lebih objektif dan menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan, diperkuat, dimodifikasi, atau dihentikan secara bertahap.

Salah satu indikator penting keberhasilan intervensi adalah pasien mampu mengenali penyebab kemarahan. Kemampuan ini menunjukkan bahwa pasien mulai memahami faktor-faktor yang memicu munculnya emosi marah dalam dirinya. Sebelum mendapatkan intervensi, pasien dengan risiko perilaku kekerasan sering kali tidak menyadari penyebab kemarahannya. Pasien mungkin langsung bereaksi dengan membentak, mengancam, memukul, merusak benda, atau menarik diri tanpa mampu menjelaskan apa yang sebenarnya membuatnya marah. Melalui intervensi keperawatan, pasien dibantu untuk mengidentifikasi situasi, orang, pikiran, perasaan, atau pengalaman tertentu yang menjadi pemicu kemarahan. Misalnya, pasien mulai menyadari bahwa ia mudah marah ketika merasa tidak dihargai, ketika permintaannya ditolak, ketika berada di lingkungan yang ramai, ketika merasa dicurigai, atau ketika mendengar suara yang memerintahkannya melakukan sesuatu.

Kemampuan mengenali penyebab kemarahan menjadi dasar penting dalam pengendalian perilaku kekerasan karena pasien tidak dapat mengontrol sesuatu yang belum ia pahami. Ketika pasien mampu menyebutkan penyebab marah, perawat dapat membantu pasien merencanakan strategi pencegahan. Misalnya, jika pasien menyadari bahwa ia mudah marah saat berada di lingkungan bising, maka perawat dapat membantu pasien mencari tempat yang lebih tenang atau mengajarkan cara meminta bantuan sebelum emosi meningkat. Jika pasien marah karena merasa tidak dipahami, perawat dapat melatih pasien mengungkapkan kebutuhan dengan kata-kata yang lebih jelas. Dengan demikian, keberhasilan intervensi tampak ketika pasien tidak lagi hanya bereaksi secara impulsif, tetapi mulai mampu menghubungkan kemarahan dengan penyebab yang mendasarinya.

Indikator berikutnya adalah pasien mampu menyebutkan tanda dan gejala saat emosi meningkat. Tanda peningkatan emosi dapat muncul pada tubuh, pikiran, perasaan, maupun perilaku. Pada aspek fisik, pasien dapat merasakan jantung berdebar, napas menjadi cepat, wajah terasa panas, otot menegang, tangan mengepal, tubuh terasa gelisah, atau suara mulai meninggi. Pada aspek psikologis, pasien dapat merasa tersinggung, kecewa, curiga, takut, tidak sabar,

atau merasa ingin menyerang. Pada aspek perilaku, pasien dapat mulai mondar-mandir, membanting benda, menatap tajam, berbicara kasar, menolak arahan, atau mendekati orang lain dengan sikap mengancam. Ketika pasien mampu mengenali tanda-tanda ini sejak awal, peluang untuk mencegah perilaku kekerasan menjadi lebih besar.

Kemampuan mengenali tanda emosi meningkat menunjukkan bahwa pasien mulai memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri ini sangat penting karena perilaku kekerasan sering terjadi ketika pasien tidak mampu mengenali perubahan emosi sejak awal. Pasien baru menyadari dirinya marah ketika emosi sudah sangat tinggi dan sulit dikendalikan. Dengan latihan dan bimbingan perawat, pasien dapat belajar bahwa kemarahan biasanya memiliki tanda awal sebelum berkembang menjadi tindakan agresif. Perawat dapat mengevaluasi keberhasilan ini dengan menanyakan kepada pasien apa yang biasanya dirasakan tubuhnya ketika mulai marah, bagaimana perubahan pikirannya, dan perilaku apa yang biasanya muncul sebelum ia kehilangan kontrol. Jika pasien mampu menjelaskan tanda-tanda tersebut, maka intervensi telah membantu pasien memahami proses peningkatan emosinya.

Indikator keberhasilan lainnya adalah pasien mampu mengungkapkan perasaan marah secara verbal tanpa mengancam. Hal ini sangat penting karena tujuan intervensi bukan menghilangkan emosi marah sepenuhnya, melainkan membantu pasien mengekspresikan marah dengan cara yang aman dan dapat diterima. Marah merupakan emosi manusiawi yang dapat muncul ketika seseorang merasa kecewa, terluka, takut, atau tidak dihargai. Masalah muncul ketika marah diekspresikan dalam bentuk ancaman, hinaan, kekerasan verbal, kekerasan fisik, atau perusakan lingkungan. Pasien yang mulai berhasil mengikuti intervensi akan mampu mengatakan bahwa ia sedang marah, kecewa, atau tidak nyaman tanpa harus membentak, mengancam, atau menyerang orang lain.

Kemampuan mengungkapkan marah secara verbal dapat terlihat ketika pasien mulai menggunakan kalimat yang lebih terkontrol. Misalnya, pasien mengatakan bahwa ia sedang kesal dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, atau pasien menyampaikan bahwa ia tidak suka diperlakukan dengan cara tertentu. Perawat dapat menilai keberhasilan ini melalui observasi saat pasien berinteraksi dengan perawat, keluarga, atau pasien lain. Jika sebelumnya pasien mudah berteriak atau mengancam, kemudian setelah intervensi pasien mulai mampu berbicara dengan nada lebih rendah dan menyampaikan perasaan secara jelas, maka hal tersebut merupakan tanda kemajuan. Kemampuan ini juga menunjukkan bahwa pasien mulai menggunakan komunikasi sebagai alat penyelesaian masalah, bukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan emosi.

Pasien juga dikatakan menunjukkan keberhasilan intervensi apabila mampu menggunakan teknik napas dalam atau relaksasi ketika emosi meningkat. Teknik napas dalam merupakan salah satu cara sederhana tetapi efektif untuk membantu pasien menurunkan ketegangan fisik dan emosional. Saat marah, tubuh pasien biasanya berada dalam kondisi tegang. Napas menjadi lebih cepat, otot menegang, jantung berdebar, dan dorongan untuk bertindak impulsif meningkat. Dengan melakukan napas dalam, pasien belajar memberi jeda antara emosi dan tindakan. Jeda ini sangat penting karena memberi kesempatan kepada pasien untuk berpikir sebelum bereaksi. Perawat dapat mengevaluasi kemampuan pasien dengan meminta pasien mempraktikkan teknik napas dalam dan mengamati apakah pasien dapat melakukannya secara benar.

Relaksasi juga dapat membantu pasien menurunkan intensitas marah. Relaksasi dapat berupa latihan mengendurkan otot, duduk tenang, memusatkan perhatian pada napas, atau melakukan aktivitas menenangkan sesuai kemampuan pasien. Keberhasilan teknik ini dapat dilihat ketika pasien mampu menggunakan latihan tersebut tanpa selalu diingatkan oleh perawat. Misalnya, saat mulai tampak gelisah, pasien secara mandiri duduk, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan diri. Kemampuan ini menunjukkan bahwa pasien mulai memiliki strategi pengendalian diri yang lebih adaptif. Meskipun pada awalnya pasien mungkin masih membutuhkan arahan, keberhasilan bertahap dapat dilihat dari meningkatnya kemandirian pasien dalam menggunakan teknik tersebut.

Indikator keberhasilan selanjutnya adalah pasien mampu menyalurkan energi secara aman. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, kemarahan sering disertai peningkatan energi fisik yang kuat. Jika energi ini tidak disalurkan secara tepat, pasien dapat memukul orang lain, menendang benda, merusak fasilitas, atau melukai diri sendiri. Oleh karena itu, intervensi keperawatan dapat membantu pasien menyalurkan energi melalui cara yang tidak membahayakan. Contohnya adalah memukul bantal, melakukan aktivitas fisik terarah, berjalan di area aman, meremas bola stres, membersihkan ruangan, menggambar, menulis, atau melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi pasien. Aktivitas tersebut harus diarahkan agar menjadi sarana pelepasan ketegangan, bukan memperkuat perilaku agresif.

Keberhasilan dalam menyalurkan energi secara aman dapat dilihat dari pilihan perilaku pasien saat marah. Jika pasien sebelumnya melampiaskan marah dengan membanting barang atau mengancam orang lain, kemudian mulai memilih memukul bantal, berjalan menjauh, atau melakukan aktivitas fisik yang disepakati, maka hal tersebut menunjukkan perkembangan positif. Perawat perlu memastikan bahwa aktivitas yang digunakan benar-benar aman dan tidak meningkatkan

agresivitas. Pasien juga perlu dibantu memahami bahwa tujuan aktivitas fisik adalah menurunkan ketegangan, bukan membalas kemarahan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati apakah pasien mampu memilih cara penyaluran energi yang aman saat emosi meningkat dan apakah setelah melakukannya pasien menjadi lebih tenang.

Kemampuan menggunakan komunikasi asertif juga menjadi indikator penting keberhasilan intervensi. Komunikasi asertif adalah kemampuan menyampaikan perasaan, pikiran, kebutuhan, atau ketidaksetujuan secara jelas, jujur, dan tetap menghargai orang lain. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan sering kali mengalami kesulitan dalam menyampaikan kebutuhan secara asertif. Sebagian pasien menekan perasaan terlalu lama hingga akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan. Sebagian lainnya langsung menyampaikan ketidakpuasan dengan nada mengancam atau menyerang. Melalui latihan komunikasi asertif, pasien diajarkan untuk berbicara secara tegas tetapi tidak agresif. Misalnya, pasien dapat mengatakan, "Saya merasa marah karena belum mendapat penjelasan," daripada berteriak atau mengancam petugas.

Keberhasilan komunikasi asertif dapat dilihat dari perubahan cara pasien menyampaikan keluhan. Pasien yang mulai mampu menggunakan kata-kata yang tepat, menjaga nada suara, tidak mengancam, dan tetap mendengarkan respons orang lain menunjukkan bahwa ia mengalami peningkatan keterampilan sosial dan kontrol emosi. Perawat dapat mengevaluasi hal ini melalui simulasi, observasi interaksi sehari-hari, atau wawancara dengan pasien dan keluarga. Komunikasi asertif tidak hanya mencegah kekerasan, tetapi juga membantu pasien membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Kemampuan ini sangat penting untuk keberlanjutan pemulihan, terutama setelah pasien kembali ke rumah atau masyarakat.

Kepatuhan minum obat sesuai anjuran juga merupakan indikator penting, terutama pada pasien risiko perilaku kekerasan yang memiliki gangguan jiwa dengan gejala seperti halusinasi, waham, agitasi, gangguan mood, atau impulsivitas. Obat yang diberikan oleh dokter dapat membantu menstabilkan kondisi emosi, mengurangi gejala psikotik, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan kemampuan pasien mengontrol perilaku. Namun, manfaat obat hanya dapat dirasakan secara optimal apabila pasien meminumnya sesuai anjuran. Ketidakepatuhan minum obat dapat menyebabkan kekambuhan gejala, peningkatan kemarahan, kecurigaan, gangguan tidur, hingga meningkatnya risiko perilaku kekerasan. Oleh karena itu, perawat perlu mengevaluasi kepatuhan pasien terhadap terapi farmakologis.

Kepatuhan minum obat dapat dinilai melalui wawancara, observasi, catatan pemberian obat, serta informasi dari keluarga. Pasien yang patuh biasanya mampu menyebutkan jadwal minum obat, memahami manfaat obat, bersedia minum obat sesuai arahan, dan melaporkan efek samping yang dirasakan. Jika pasien menolak obat, perawat perlu mengevaluasi penyebabnya. Penolakan dapat terjadi karena pasien merasa sudah sembuh, takut efek samping, tidak memahami manfaat obat, merasa obat adalah hukuman, atau dipengaruhi oleh gejala seperti halusinasi dan waham. Keberhasilan intervensi tampak ketika pasien mulai memahami pentingnya obat, bersedia mengikuti terapi, dan mampu bekerja sama dalam pengobatan. Dukungan keluarga juga sangat penting untuk mempertahankan kepatuhan setelah pasien pulang.

Indikator keberhasilan yang paling utama adalah pasien tidak mencederai diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Keselamatan merupakan prioritas dalam asuhan keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan. Intervensi dikatakan berhasil apabila pasien tidak melakukan tindakan yang membahayakan selama proses perawatan, seperti memukul, menendang, menggigit, mencakar, melempar benda, merusak fasilitas, melukai diri sendiri, atau mengancam secara serius. Namun, indikator ini perlu dinilai bersama indikator lain. Pasien yang tidak melakukan kekerasan karena diawasi ketat belum tentu sudah mampu mengontrol dirinya secara mandiri. Oleh karena itu, perawat perlu melihat apakah pasien tidak melakukan kekerasan karena memang mampu menggunakan strategi kontrol marah atau hanya karena situasi sangat dibatasi.

Tidak mencederai lingkungan juga menjadi bagian dari keberhasilan intervensi. Pasien yang mampu menjaga benda di sekitarnya, tidak membanting barang, tidak merusak fasilitas, dan tidak menggunakan benda sebagai alat ancaman menunjukkan peningkatan kontrol perilaku. Perawat dapat mengevaluasi aspek ini melalui observasi langsung dan catatan perkembangan pasien. Jika pasien mulai mampu berada di lingkungan perawatan tanpa menimbulkan ancaman, mengikuti aturan ruangan, dan berinteraksi dengan orang lain secara aman, maka hal tersebut menunjukkan perkembangan yang bermakna. Keberhasilan ini penting karena lingkungan yang aman mendukung pemulihan pasien dan kenyamanan orang lain di sekitarnya.

Indikator-indikator keberhasilan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pasien yang mampu mengenali penyebab marah akan lebih mudah mengenali tanda emosi meningkat. Pasien yang mampu mengenali tanda emosi meningkat akan lebih cepat menggunakan teknik napas dalam, relaksasi, atau penyaluran energi secara aman. Pasien yang mampu mengungkapkan marah secara verbal dan menggunakan komunikasi asertif akan lebih kecil kemungkinannya melakukan

kekerasan. Pasien yang patuh minum obat juga memiliki peluang lebih besar untuk menjaga kestabilan emosi dan mengurangi risiko kekambuhan. Dengan demikian, keberhasilan intervensi tidak dinilai dari satu aspek saja, tetapi dari perubahan menyeluruh pada cara pasien memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya.

Dalam praktik keperawatan, perawat perlu melakukan evaluasi indikator keberhasilan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada awal intervensi, pasien mungkin baru mampu mengenali sebagian penyebab marah atau masih membutuhkan bantuan untuk melakukan teknik napas dalam. Hal tersebut tetap dapat dianggap sebagai kemajuan awal. Seiring waktu, diharapkan pasien menjadi lebih mandiri dalam mengontrol emosi. Perawat perlu memberikan penguatan positif terhadap setiap kemajuan pasien, sekecil apa pun, karena penguatan dapat meningkatkan motivasi pasien untuk terus menggunakan perilaku adaptif. Misalnya, ketika pasien berhasil mengatakan bahwa ia sedang marah tanpa mengancam, perawat dapat memberikan pujian bahwa pasien telah memilih cara yang lebih aman.

Indikator keberhasilan intervensi pada pasien risiko perilaku kekerasan mencakup kemampuan pasien mengenali penyebab kemarahan, menyebutkan tanda emosi meningkat, mengungkapkan marah secara verbal tanpa mengancam, menggunakan teknik napas dalam atau relaksasi, menyalurkan energi secara aman, berkomunikasi secara asertif, patuh minum obat, serta tidak mencederai diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Indikator-indikator ini menjadi dasar bagi perawat untuk menilai efektivitas intervensi dan menentukan tindak lanjut asuhan. Semakin banyak indikator yang tercapai, semakin baik kemampuan pasien dalam mengendalikan perilaku kekerasan dan semakin besar peluang pasien untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara lebih aman, adaptif, dan produktif.

F. Metode Evaluasi Keberhasilan Intervensi

Metode evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan merupakan cara yang digunakan perawat untuk menilai sejauh mana intervensi yang telah diberikan menghasilkan perubahan positif pada pasien. Evaluasi tidak hanya dilakukan dengan melihat apakah pasien tidak melakukan kekerasan, tetapi juga dengan menilai perubahan pada aspek pikiran, emosi, perilaku, komunikasi, kemampuan mengontrol marah, kepatuhan terapi, serta kemampuan pasien berinteraksi secara aman dengan orang lain. Oleh karena itu, metode evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, objektif, sistematis, dan berkesinambungan. Perawat perlu menggunakan berbagai sumber data agar hasil evaluasi benar-benar menggambarkan kondisi pasien secara utuh.

Salah satu metode utama dalam evaluasi adalah wawancara terapeutik dengan pasien. Wawancara terapeutik dilakukan untuk menggali pengalaman, perasaan, pemahaman, dan perubahan yang dirasakan pasien setelah mendapatkan intervensi. Melalui wawancara, perawat dapat mengetahui apakah pasien sudah mampu mengenali penyebab kemarahannya, memahami tanda-tanda ketika emosi mulai meningkat, serta mengetahui cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan marah. Wawancara juga membantu perawat menilai apakah pasien merasa lebih tenang, lebih mampu mengontrol diri, atau masih mengalami kesulitan dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam melakukan wawancara, perawat perlu menggunakan komunikasi yang empatik, tenang, tidak menghakimi, dan memberi kesempatan kepada pasien untuk menjelaskan pengalamannya secara bebas.

Wawancara terapeutik juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pasien memahami intervensi yang telah diajarkan. Misalnya, perawat dapat menanyakan kepada pasien apa yang biasanya membuat pasien marah, apa yang dirasakan tubuh pasien ketika mulai marah, dan apa yang dilakukan pasien untuk menenangkan diri. Jawaban pasien dapat menunjukkan tingkat pemahaman dan kesadaran dirinya. Apabila pasien mampu menjelaskan penyebab marah dan menyebutkan cara mengontrolnya, maka hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan kognitif yang baik. Namun, jika pasien masih belum mampu menjelaskan dengan jelas, perawat perlu memberikan edukasi ulang dengan bahasa yang lebih sederhana dan latihan yang lebih terarah.

Selain wawancara, observasi perilaku pasien selama perawatan merupakan metode evaluasi yang sangat penting. Dalam keperawatan jiwa, tidak semua perubahan dapat diketahui hanya dari perkataan pasien. Kadang pasien mengatakan dirinya sudah tenang, tetapi perilakunya masih menunjukkan gelisah, mudah tersinggung, atau sulit diarahkan. Oleh karena itu, perawat perlu mengamati perilaku pasien secara langsung dalam berbagai situasi, baik saat pasien sedang sendiri, berinteraksi dengan perawat, berbicara dengan keluarga, maupun berada bersama pasien lain. Observasi membantu perawat menilai apakah pasien benar-benar mampu mengontrol dorongan agresif dalam kehidupan sehari-hari selama perawatan.

Perilaku yang perlu diamati meliputi cara pasien berbicara, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, kemampuan mengikuti arahan, respons terhadap stimulus, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Pasien yang menunjukkan perkembangan positif biasanya tampak lebih tenang, mampu berbicara dengan nada suara yang lebih terkendali, tidak mudah tersinggung, tidak mengancam, tidak merusak benda, dan mampu meminta bantuan ketika mulai

merasa marah. Sebaliknya, jika pasien masih sering mondar-mandir, mengepalkan tangan, berbicara keras, menatap tajam, atau menunjukkan sikap bermusuhan, maka risiko perilaku kekerasan masih perlu diwaspadai. Observasi yang dilakukan secara berulang akan membantu perawat melihat pola perkembangan pasien dari waktu ke waktu.

Pemeriksaan respons verbal dan nonverbal pasien juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Respons verbal mencakup apa yang dikatakan pasien, cara pasien menyampaikan perasaan, kemampuan pasien menggunakan kata-kata yang tepat, serta kemampuan pasien berbicara tanpa mengancam. Pasien yang berhasil mengikuti intervensi biasanya mulai mampu mengatakan bahwa ia sedang marah, kecewa, atau tidak nyaman tanpa menggunakan kata-kata kasar atau ancaman. Pasien juga mulai mampu menyampaikan kebutuhan secara lebih jelas dan meminta bantuan secara tepat. Respons verbal ini menunjukkan bahwa pasien mulai menggunakan komunikasi sebagai cara menyelesaikan masalah, bukan kekerasan sebagai bentuk pelampiasan emosi.

Respons nonverbal juga perlu diperhatikan karena sering kali mencerminkan kondisi emosional pasien yang sebenarnya. Perawat perlu mengamati apakah wajah pasien tampak tegang atau rileks, apakah tangan pasien mengepal, apakah pasien tampak gelisah, apakah kontak mata terlalu tajam, atau apakah posisi tubuh pasien menunjukkan sikap menantang. Pasien yang mulai mampu mengontrol marah biasanya menunjukkan bahasa tubuh yang lebih tenang, gerakan tubuh lebih terkendali, wajah tidak terlalu tegang, dan tidak menunjukkan perilaku mengancam. Perawat perlu membandingkan respons verbal dan nonverbal pasien. Jika pasien mengatakan sudah tenang tetapi tubuhnya masih tampak tegang dan gelisah, maka perawat perlu melakukan evaluasi lebih lanjut dan membantu pasien menggunakan teknik pengendalian marah.

Metode evaluasi berikutnya adalah penilaian kemampuan pasien melakukan latihan pengendalian marah. Intervensi keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan biasanya mencakup latihan napas dalam, relaksasi, aktivitas fisik terarah, komunikasi asertif, pendekatan spiritual, dan kepatuhan minum obat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pasien hanya memahami teknik tersebut secara teori atau benar-benar mampu mempraktikkannya. Misalnya, ketika pasien diajarkan napas dalam, perawat perlu meminta pasien mempraktikkan cara menarik napas perlahan, menahan sebentar, dan menghembuskan napas dengan tenang. Perawat kemudian menilai apakah teknik dilakukan dengan benar dan apakah setelah latihan pasien tampak lebih rileks.

Penilaian kemampuan pasien juga perlu dilakukan dalam situasi nyata. Pasien mungkin mampu melakukan latihan saat kondisi tenang, tetapi belum tentu

mampu menggunakannya ketika emosi meningkat. Oleh karena itu, perawat perlu mengevaluasi apakah pasien dapat menerapkan teknik pengendalian marah saat mulai terlihat gelisah atau marah. Misalnya, ketika pasien mulai kesal karena permintaannya belum terpenuhi, perawat dapat mengamati apakah pasien mampu menarik napas dalam, menjauh dari situasi pemicu, berbicara dengan lebih tenang, atau meminta bantuan. Keberhasilan intervensi terlihat ketika pasien mulai menggunakan keterampilan yang telah diajarkan secara mandiri atau dengan sedikit arahan.

Penggunaan format evaluasi keperawatan, seperti SOAP atau catatan perkembangan, juga sangat penting dalam menilai keberhasilan intervensi. Format SOAP terdiri atas data subjektif, data objektif, analisis, dan rencana tindak lanjut. Data subjektif berisi pernyataan pasien, misalnya pasien mengatakan sudah lebih mampu menahan marah atau merasa lebih tenang setelah melakukan napas dalam. Data objektif berisi hasil pengamatan perawat, misalnya pasien tampak tenang, tidak mengancam, mampu mengikuti latihan relaksasi, atau tidak merusak benda selama perawatan. Analisis berisi penilaian perawat terhadap perkembangan masalah, apakah risiko perilaku kekerasan menurun, tetap, atau meningkat. Rencana berisi tindak lanjut intervensi, seperti melanjutkan latihan, memberikan edukasi ulang, melibatkan keluarga, atau meningkatkan pengawasan.

Catatan perkembangan membantu memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi yang lengkap memudahkan perawat lain dan tim kesehatan memahami perkembangan pasien. Misalnya, jika pada hari pertama pasien masih sering mengancam, hari kedua mulai mampu melakukan napas dalam, dan hari ketiga mampu menyampaikan marah secara verbal tanpa mengancam, maka catatan perkembangan akan menunjukkan adanya kemajuan yang jelas. Dokumentasi juga penting untuk menentukan apakah intervensi yang diberikan efektif atau perlu dimodifikasi. Tanpa dokumentasi yang baik, perkembangan pasien dapat terlewat atau tidak tersampaikan kepada tim yang bertugas berikutnya.

Diskusi dengan keluarga atau orang terdekat juga merupakan metode evaluasi yang penting, terutama jika pasien akan kembali ke rumah atau menjalani perawatan lanjutan di komunitas. Keluarga sering mengetahui perubahan perilaku pasien di luar lingkungan perawatan, termasuk bagaimana pasien biasanya marah, apa pencetusnya, bagaimana pasien merespons konflik, dan apakah pasien patuh minum obat. Informasi dari keluarga dapat melengkapi data yang diperoleh dari pasien dan observasi perawat. Misalnya, pasien mungkin tampak tenang di ruang perawatan, tetapi keluarga menyampaikan bahwa pasien sering marah di rumah

ketika menghadapi suara bising atau konflik tertentu. Informasi ini penting untuk menyusun rencana tindak lanjut yang lebih realistis.

Diskusi dengan keluarga juga membantu mengevaluasi sejauh mana keluarga memahami cara mendukung pasien. Perawat dapat menilai apakah keluarga mampu mengenali tanda awal kemarahan pasien, mengetahui cara berkomunikasi yang tidak memicu konflik, mampu mengingatkan pasien menggunakan teknik kontrol marah, serta mendukung kepatuhan pasien dalam minum obat. Jika keluarga belum memahami cara menghadapi pasien, perawat perlu memberikan edukasi tambahan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfokus pada pasien, tetapi juga pada kesiapan keluarga sebagai sistem pendukung utama setelah pasien keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Kolaborasi dengan tim kesehatan juga sangat diperlukan dalam menilai perkembangan pasien. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan sering membutuhkan penanganan multidisiplin, melibatkan perawat, dokter, psikiater, psikolog, pekerja sosial, terapis okupasi, dan tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan. Setiap anggota tim dapat memberikan sudut pandang berbeda mengenai perkembangan pasien. Dokter atau psikiater dapat mengevaluasi respons pasien terhadap terapi farmakologis, psikolog dapat menilai kemampuan koping dan proses emosional pasien, sedangkan perawat dapat memberikan data observasi harian mengenai perilaku dan respons pasien terhadap intervensi. Kolaborasi ini membantu menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif.

Melalui kolaborasi, perawat dapat menentukan apakah intervensi keperawatan perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dikombinasikan dengan intervensi lain. Misalnya, jika pasien masih menunjukkan agresivitas meskipun sudah dilatih teknik kontrol marah, tim kesehatan dapat menilai kemungkinan adanya gejala psikotik aktif, efek obat yang belum optimal, stresor lingkungan, atau kebutuhan terapi tambahan. Kolaborasi juga penting untuk menentukan tingkat pengawasan pasien, kesiapan pasien pulang, kebutuhan rujukan, dan rencana tindak lanjut. Dengan bekerja bersama tim, keputusan klinis menjadi lebih tepat dan keselamatan pasien lebih terjamin.

Metode evaluasi keberhasilan intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi tidak cukup dilakukan hanya setelah satu kali intervensi, karena kondisi pasien risiko perilaku kekerasan dapat berubah sesuai situasi, emosi, pengobatan, dan lingkungan. Perawat perlu melakukan evaluasi setiap kali berinteraksi dengan pasien, terutama saat pasien menunjukkan perubahan emosi atau perilaku. Evaluasi yang berulang membantu perawat mengenali pola, melihat perkembangan, dan mencegah kekambuhan perilaku kekerasan. Jika pasien menunjukkan kemajuan, perawat dapat memberikan

penguatan positif. Jika pasien belum menunjukkan perubahan, perawat perlu mencari penyebab hambatan dan menyesuaikan pendekatan.

metode evaluasi keberhasilan intervensi pada pasien risiko perilaku kekerasan mencakup wawancara terapeutik, observasi perilaku, pemeriksaan respons verbal dan nonverbal, penilaian kemampuan melakukan latihan pengendalian marah, penggunaan format evaluasi seperti SOAP atau catatan perkembangan, diskusi dengan keluarga, serta kolaborasi dengan tim kesehatan. Setiap metode memiliki fungsi yang saling melengkapi. Wawancara membantu menggali pengalaman subjektif pasien, observasi memberikan data objektif, penilaian latihan menunjukkan kemampuan praktis pasien, dokumentasi memastikan kesinambungan asuhan, keluarga memberikan informasi kontekstual, dan tim kesehatan membantu menilai pasien secara multidisiplin. Dengan menggunakan berbagai metode evaluasi secara tepat, perawat dapat menilai keberhasilan intervensi secara lebih akurat dan memberikan asuhan yang lebih aman, efektif, serta berpusat pada kebutuhan pasien.

G. Evaluasi Respons Pasien terhadap Intervensi Pengendalian Marah

Evaluasi respons pasien terhadap intervensi pengendalian marah merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pasien mampu memahami, menerima, dan menerapkan strategi yang telah diajarkan perawat dalam mengendalikan marah. Pengendalian marah bukan berarti menghilangkan emosi marah sepenuhnya, karena marah merupakan respons emosional yang wajar dialami manusia. Yang menjadi fokus utama dalam intervensi keperawatan adalah bagaimana pasien mampu mengenali marah, memahami penyebabnya, mengungkapkannya secara tepat, serta menyalurkan dorongan emosi tanpa mencederai diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi respons pasien harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup respons kognitif, afektif, perilaku, kemampuan memilih cara aman, perubahan intensitas marah, dan kemampuan meminta bantuan.

Respons kognitif pasien merupakan salah satu aspek awal yang perlu dievaluasi. Respons kognitif berkaitan dengan kemampuan pasien memahami penyebab marah, mengenali situasi pencetus, dan menyadari hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan sering kali mengalami kesulitan memahami mengapa dirinya marah. Sebagian pasien hanya merasakan dorongan emosi yang kuat tanpa mampu menjelaskan penyebabnya. Sebagian lainnya menyalahkan orang lain atau lingkungan sepenuhnya tanpa mampu melihat faktor internal, seperti rasa takut, kecewa, curiga, atau perasaan

tidak dihargai. Melalui intervensi keperawatan, pasien dibantu untuk mengidentifikasi penyebab kemarahan secara lebih jelas. Evaluasi dilakukan dengan menilai apakah pasien sudah mampu menyebutkan hal-hal yang biasanya memicu marah, seperti konflik dengan orang lain, lingkungan yang bising, penolakan terhadap keinginannya, rasa nyeri, halusinasi, kecurigaan, atau perasaan diperlakukan tidak adil.

Kemampuan memahami penyebab marah menunjukkan bahwa pasien mulai memiliki kesadaran terhadap proses emosinya. Kesadaran ini penting karena pasien yang mampu mengenali penyebab marah akan lebih mudah melakukan pencegahan sebelum emosi meningkat menjadi perilaku agresif. Misalnya, pasien yang menyadari bahwa dirinya mudah marah ketika merasa tidak didengarkan dapat belajar menyampaikan kebutuhan secara lebih jelas. Pasien yang mengetahui bahwa dirinya menjadi marah saat berada di tempat ramai dapat belajar menjauh sementara ke tempat yang lebih tenang. Dalam evaluasi, perawat dapat menggunakan wawancara terapeutik untuk menanyakan kepada pasien apa yang membuatnya marah, apa yang dipikirkan ketika marah, dan apa akibat dari perilaku marah yang pernah dilakukan. Bila pasien mampu menjawab dengan lebih terarah, hal ini menunjukkan perkembangan respons kognitif yang positif.

Selain memahami penyebab marah, respons kognitif juga mencakup kemampuan pasien memahami manfaat strategi pengendalian marah. Pasien perlu mengetahui bahwa teknik seperti napas dalam, relaksasi, komunikasi asertif, aktivitas fisik terarah, atau meminta bantuan bukan sekadar perintah dari perawat, tetapi cara untuk membantu dirinya tetap aman. Jika pasien memahami tujuan intervensi, ia akan lebih termotivasi untuk menggunakannya. Perawat perlu mengevaluasi apakah pasien mampu menjelaskan mengapa ia perlu mengontrol marah, apa risiko jika marah tidak dikendalikan, dan bagaimana teknik pengendalian marah dapat membantunya. Pemahaman ini menjadi dasar agar pasien tidak hanya mengikuti latihan secara mekanis, tetapi benar-benar menyadari pentingnya perubahan perilaku.

Respons afektif pasien juga harus dievaluasi secara mendalam. Respons afektif berkaitan dengan kemampuan pasien mengenali, menerima, dan mengungkapkan emosinya. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan sering mengalami kesulitan membedakan berbagai bentuk emosi. Mereka mungkin menyebut semua perasaan tidak nyaman sebagai marah, padahal di dalamnya terdapat rasa takut, kecewa, malu, sedih, tidak berdaya, atau cemas. Ketidakmampuan mengenali emosi dapat membuat pasien langsung bereaksi secara agresif. Oleh karena itu, intervensi keperawatan bertujuan membantu pasien

menyadari apa yang sebenarnya dirasakan sebelum emosi berubah menjadi tindakan kekerasan.

Evaluasi respons afektif dapat dilakukan dengan menilai apakah pasien mampu menyebutkan perasaan yang dialaminya. Misalnya, pasien mulai mampu mengatakan, "Saya merasa kesal karena tidak dipahami," "Saya takut jika orang lain mendekat," atau "Saya kecewa karena keinginan saya tidak dipenuhi." Kemampuan seperti ini menunjukkan bahwa pasien mulai mampu menghubungkan pengalaman dengan emosi yang muncul. Pasien yang sebelumnya hanya membentak atau mengancam ketika marah, kemudian mulai mampu menyampaikan perasaannya dengan kata-kata, menunjukkan perkembangan afektif yang baik. Perawat perlu memberikan penguatan ketika pasien berhasil mengungkapkan emosi secara verbal karena hal tersebut merupakan langkah penting dalam mencegah perilaku kekerasan.

Respons afektif juga dapat dilihat dari perubahan intensitas emosi pasien selama proses perawatan. Pasien yang berhasil mengikuti intervensi biasanya menunjukkan penurunan kecemasan, kemarahan, ketegangan, atau rasa terancam. Wajah pasien dapat tampak lebih rileks, nada suara lebih rendah, dan pasien lebih mampu menerima arahan. Namun, perawat perlu memahami bahwa perubahan afektif tidak selalu terjadi secara cepat. Pada beberapa pasien, marah masih sering muncul, tetapi pasien mulai mampu menyadari dan menyebutkan emosinya. Hal ini tetap merupakan perkembangan positif karena pasien mulai memiliki kemampuan untuk mengenali emosi sebelum kehilangan kontrol. Evaluasi afektif harus dilakukan dengan sabar dan berkesinambungan.

Respons perilaku pasien menjadi aspek yang sangat penting dalam evaluasi intervensi pengendalian marah. Respons perilaku menunjukkan apakah pasien mampu mengubah cara bertindak ketika emosi meningkat. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, perilaku yang perlu dievaluasi mencakup kemampuan menahan dorongan agresif, tidak mengancam, tidak memukul, tidak merusak benda, tidak melukai diri sendiri, dan mampu mengikuti arahan perawat. Perubahan perilaku menjadi indikator nyata bahwa intervensi mulai berhasil. Misalnya, pasien yang sebelumnya langsung membanting barang ketika marah, kemudian mulai memilih duduk, menarik napas, atau meminta waktu untuk menenangkan diri, menunjukkan perkembangan yang bermakna.

Evaluasi respons perilaku perlu dilakukan melalui observasi langsung karena tidak semua pasien mampu melaporkan perilakunya secara akurat. Perawat perlu mengamati bagaimana pasien bereaksi ketika menghadapi situasi pemicu, seperti menunggu, menerima penolakan, berinteraksi dengan pasien lain, atau mendapatkan teguran. Apakah pasien mampu tetap tenang, apakah pasien mulai

berbicara keras, apakah pasien meninggalkan situasi dengan aman, atau apakah pasien meminta bantuan. Observasi ini memberikan data objektif mengenai kemampuan pasien mengendalikan dorongan agresif. Jika pasien masih menunjukkan perilaku mengancam atau agresif, perawat perlu mengevaluasi kembali faktor penyebab, tingkat risiko, dan kesesuaian intervensi yang diberikan.

Kemampuan pasien memilih cara yang aman saat marah merupakan hasil penting dari intervensi pengendalian marah. Pasien yang berisiko melakukan kekerasan sering kali memiliki pola respons yang terbatas ketika marah, seperti menyerang, mengancam, diam penuh dendam, atau merusak benda. Intervensi keperawatan bertujuan memperluas pilihan respons pasien agar ia memiliki alternatif yang lebih aman. Cara aman yang dapat dipilih pasien antara lain melakukan napas dalam, relaksasi, berbicara dengan perawat atau keluarga, menjauh dari situasi pemicu, melakukan aktivitas fisik terarah, memukul bantal, berdoa, menulis perasaan, atau menggunakan komunikasi asertif. Evaluasi dilakukan dengan menilai apakah pasien mampu memilih salah satu cara tersebut ketika marah mulai muncul.

Kemampuan memilih cara yang aman menunjukkan bahwa pasien mulai memiliki kontrol terhadap perilakunya. Pasien tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh dorongan impulsif, tetapi mulai mampu berhenti sejenak dan menentukan tindakan yang tidak membahayakan. Dalam evaluasi, perawat dapat menanyakan kepada pasien apa yang akan dilakukan jika ia mulai marah, lalu mengamati apakah pasien benar-benar menerapkan pilihan tersebut dalam situasi nyata. Misalnya, jika pasien mengatakan akan melakukan napas dalam, perawat perlu melihat apakah pasien mampu menggunakan teknik tersebut ketika mulai gelisah. Jika pasien mengatakan akan berbicara kepada perawat, perawat perlu menilai apakah pasien benar-benar meminta bantuan sebelum emosinya meningkat. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari jawaban pasien, tetapi dari konsistensi perilaku dalam praktik.

Perubahan intensitas marah sebelum dan sesudah intervensi juga menjadi aspek penting dalam evaluasi. Intensitas marah menggambarkan seberapa kuat emosi marah yang dirasakan pasien dan seberapa besar pengaruhnya terhadap perilaku. Sebelum intervensi, pasien mungkin mengalami marah dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan teriakan, ancaman, tindakan merusak, atau dorongan menyerang. Setelah intervensi, diharapkan intensitas marah menurun, baik dari segi frekuensi, durasi, maupun tingkat keparahan. Pasien mungkin masih merasa marah, tetapi tidak lagi sampai kehilangan kontrol atau melakukan tindakan agresif. Penurunan intensitas ini menunjukkan bahwa pasien mulai mampu mengelola emosi secara lebih adaptif.

Perawat dapat mengevaluasi intensitas marah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah meminta pasien menilai tingkat marahnya menggunakan skala sederhana, misalnya dari 0 sampai 10, dengan 0 berarti tidak marah dan 10 berarti sangat marah. Perawat dapat menanyakan tingkat marah sebelum melakukan latihan napas dalam dan setelah latihan dilakukan. Jika pasien mengatakan tingkat marahnya turun dari 8 menjadi 4, hal ini menunjukkan bahwa intervensi membantu menurunkan intensitas emosi. Selain menggunakan skala, perawat juga dapat mengamati tanda objektif, seperti perubahan nada suara, ekspresi wajah, ketegangan tubuh, gerakan motorik, dan kemampuan pasien mengikuti arahan. Kombinasi data subjektif dan objektif akan memberikan gambaran yang lebih akurat.

Perubahan intensitas marah juga perlu dievaluasi dari waktu ke waktu. Perawat dapat melihat apakah pasien semakin jarang mengalami ledakan marah, apakah durasi marah semakin pendek, dan apakah pasien lebih cepat kembali tenang setelah menggunakan teknik pengendalian. Misalnya, pada awal perawatan pasien membutuhkan waktu lama untuk tenang setelah marah, tetapi setelah beberapa kali intervensi pasien mampu menenangkan diri dalam waktu lebih singkat. Perubahan ini menunjukkan perkembangan positif meskipun pasien belum sepenuhnya bebas dari kemarahan. Evaluasi yang realistis perlu mempertimbangkan bahwa pengendalian marah merupakan proses bertahap, terutama pada pasien dengan gangguan jiwa berat atau riwayat perilaku kekerasan berulang.

Kemampuan pasien meminta bantuan ketika merasa tidak mampu mengontrol diri merupakan indikator keberhasilan yang sangat penting. Pasien yang mampu meminta bantuan menunjukkan bahwa ia mulai mengenali batas kemampuannya dan memilih cara aman untuk mencegah perilaku kekerasan. Sebelum intervensi, pasien mungkin langsung bertindak agresif ketika merasa marah. Setelah intervensi, pasien diharapkan mampu mengatakan kepada perawat, keluarga, atau orang terdekat bahwa ia mulai marah dan membutuhkan bantuan. Kemampuan ini menunjukkan peningkatan kesadaran diri, kontrol impuls, dan kepercayaan terhadap orang lain. Perawat perlu memberikan penguatan positif ketika pasien mampu meminta bantuan sebelum kehilangan kontrol.

Meminta bantuan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pasien dapat memanggil perawat, menyampaikan bahwa ia mulai gelisah, meminta ditemani, meminta pindah ke tempat yang lebih tenang, meminta diingatkan untuk melakukan napas dalam, atau meminta waktu untuk menenangkan diri. Keluarga juga perlu dilibatkan agar pasien memiliki dukungan saat berada di rumah. Perawat perlu mengevaluasi apakah pasien mengetahui siapa yang dapat dihubungi ketika

merasa tidak mampu mengontrol marah, serta apakah pasien bersedia meminta bantuan tanpa merasa malu atau takut dianggap lemah. Kemampuan meminta bantuan menjadi keterampilan penting dalam pencegahan kekambuhan perilaku kekerasan.

Evaluasi respons pasien terhadap intervensi pengendalian marah juga harus mempertimbangkan hambatan yang mungkin dialami pasien. Tidak semua pasien langsung mampu menunjukkan respons yang baik. Beberapa pasien masih sulit memahami penyebab marah, menolak latihan, tidak percaya kepada perawat, mengalami halusinasi atau waham yang kuat, atau kurang dukungan keluarga. Dalam kondisi seperti ini, perawat perlu melakukan evaluasi secara sabar dan menyesuaikan intervensi dengan kemampuan pasien. Jika respons kognitif belum baik, edukasi perlu disederhanakan. Jika respons afektif masih tidak stabil, perawat perlu lebih fokus pada validasi emosi dan rasa aman. Jika respons perilaku masih berisiko, pengawasan dan pengamanan lingkungan harus ditingkatkan.

evaluasi respons pasien terhadap intervensi pengendalian marah mencakup penilaian terhadap respons kognitif, afektif, perilaku, kemampuan memilih cara aman, perubahan intensitas marah, serta kemampuan meminta bantuan. Respons kognitif menunjukkan pemahaman pasien terhadap penyebab marah dan manfaat pengendalian emosi. Respons afektif menunjukkan kemampuan pasien mengenali dan mengungkapkan perasaan. Respons perilaku menunjukkan kemampuan pasien mengendalikan dorongan agresif dan bertindak lebih aman. Kemampuan memilih cara yang aman, menurunkan intensitas marah, serta kesediaan meminta bantuan menjadi tanda bahwa pasien mulai memiliki kontrol diri yang lebih baik. Evaluasi yang dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berkesinambungan akan membantu perawat menentukan keberhasilan intervensi serta merancang tindak lanjut yang sesuai untuk menjaga keselamatan dan mendukung pemulihan pasien.

H. Evaluasi Keamanan Pasien dan Lingkungan

Evaluasi keamanan pasien dan lingkungan merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien, orang lain, perawat, keluarga, pasien lain, serta lingkungan perawatan berada dalam kondisi aman selama proses asuhan berlangsung. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, keselamatan menjadi prioritas utama karena perubahan emosi dan perilaku dapat terjadi secara cepat, terutama ketika pasien mengalami kemarahan, kecurigaan, halusinasi, waham, frustrasi, kecemasan berat, atau kehilangan kontrol diri. Oleh karena itu, evaluasi keamanan tidak cukup dilakukan hanya sekali, melainkan harus

dilakukan secara berulang dan berkesinambungan sesuai perkembangan kondisi pasien.

Penilaian risiko mencederai diri sendiri merupakan salah satu aspek utama dalam evaluasi keamanan. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan tidak selalu mengarahkan agresivitas kepada orang lain, tetapi juga dapat mengarahkannya kepada diri sendiri. Risiko mencederai diri dapat muncul ketika pasien merasa putus asa, sangat marah, merasa bersalah, mendengar suara yang memerintah, atau merasa tidak mampu mengendalikan tekanan emosional yang dialami. Perawat perlu mengevaluasi apakah pasien memiliki pikiran untuk menyakiti diri, pernah melakukan percobaan melukai diri, menunjukkan luka pada tubuh, membenturkan kepala, menolak makan dan minum, atau melakukan tindakan impulsif yang membahayakan keselamatan dirinya. Penilaian ini harus dilakukan dengan komunikasi yang tenang, empatik, dan tidak menghakimi agar pasien bersedia mengungkapkan perasaan atau dorongan yang dialami.

Dalam mengevaluasi risiko mencederai diri sendiri, perawat juga perlu memperhatikan tanda-tanda tidak langsung. Tidak semua pasien secara terbuka mengatakan bahwa dirinya ingin melukai diri. Beberapa pasien mungkin menunjukkan perubahan perilaku seperti menarik diri, tampak murung, gelisah berlebihan, tidak mau berbicara, tampak putus asa, atau mengatakan kalimat yang mengarah pada hilangnya harapan. Pada pasien dengan gangguan persepsi, misalnya halusinasi perintah, perawat perlu menggali apakah pasien mendengar suara yang menyuruhnya melukai diri sendiri. Bila risiko tersebut ditemukan, perawat harus segera meningkatkan pengawasan, mengamankan lingkungan, menjauhkan benda berbahaya, dan melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan untuk menentukan tindakan lanjutan yang tepat.

Penilaian risiko mencederai orang lain juga menjadi aspek penting dalam evaluasi keamanan. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan dapat menunjukkan dorongan untuk menyerang, memukul, mendorong, melukai, atau mengancam orang lain, terutama ketika merasa marah, terancam, tersinggung, atau salah menafsirkan perilaku orang di sekitarnya. Perawat perlu mengevaluasi apakah pasien pernah mengancam orang lain, menunjukkan sikap bermusuhan, memiliki riwayat kekerasan, merasa curiga kepada orang tertentu, atau mendengar halusinasi yang menyuruhnya menyerang. Risiko mencederai orang lain harus dinilai secara serius karena dapat membahayakan keluarga, pasien lain, perawat, maupun tenaga kesehatan lainnya.

Penilaian risiko terhadap orang lain tidak hanya dilakukan melalui wawancara, tetapi juga melalui observasi perilaku. Pasien yang tampak menatap tajam, mengepalkan tangan, mendekati orang lain dengan sikap mengancam, berbicara

kasar, berteriak, atau menolak diarahkan dapat menunjukkan peningkatan risiko. Perawat perlu mengamati bagaimana pasien berinteraksi dengan orang lain, apakah pasien mudah tersinggung, apakah pasien mampu menerima batasan, dan apakah pasien dapat mengikuti arahan ketika emosinya meningkat. Jika pasien menunjukkan risiko tinggi, perawat perlu segera mengambil langkah pengamanan, seperti menjaga jarak aman, mengurangi stimulus lingkungan, meminta bantuan tim, dan memastikan pasien lain atau keluarga berada pada posisi aman.

Selain risiko terhadap diri sendiri dan orang lain, perawat juga perlu menilai risiko pasien merusak benda atau lingkungan. Perilaku merusak lingkungan dapat menjadi bentuk pelampiasan kemarahan atau tanda bahwa pasien mulai kehilangan kontrol terhadap dorongan agresif. Pasien dapat membanting barang, menendang pintu, memukul meja, melempar kursi, merusak alat kesehatan, atau menggunakan benda di sekitarnya sebagai alat untuk mengancam. Kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian fasilitas, tetapi juga dapat meningkatkan risiko cedera bagi pasien dan orang lain. Misalnya, benda yang pecah dapat menghasilkan serpihan tajam, kursi yang dilempar dapat mengenai pasien lain, atau alat kesehatan yang rusak dapat mengganggu pelayanan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap risiko merusak benda atau lingkungan, perawat perlu mengamati perilaku pasien saat menghadapi frustrasi atau penolakan. Pasien yang belum mampu mengungkapkan marah secara verbal mungkin lebih mudah melampiaskan emosi melalui benda. Oleh karena itu, perawat perlu mengevaluasi apakah pasien mulai memukul dinding, membanting barang, menendang perabot, atau memperlakukan benda dengan kasar. Bila tanda-tanda tersebut muncul, perawat perlu segera menurunkan stimulus, mengarahkan pasien ke tempat yang lebih aman, dan membantu pasien menggunakan teknik pengendalian marah yang telah diajarkan. Evaluasi ini penting agar kerusakan lingkungan tidak berkembang menjadi kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain.

Pemantauan tanda-tanda peningkatan agresivitas harus dilakukan secara terus-menerus. Agresivitas biasanya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi didahului oleh tanda-tanda awal yang dapat diamati. Tanda tersebut dapat berupa perubahan ekspresi wajah, suara meninggi, bicara cepat, gelisah, mondar-mandir, napas cepat, tangan mengepal, rahang mengatup, tatapan tajam, atau sikap tubuh yang tegang. Pada sebagian pasien, peningkatan agresivitas juga tampak dari penolakan terhadap instruksi, peningkatan kecurigaan, mudah tersinggung, berbicara kasar, atau mengeluarkan ancaman. Perawat harus peka terhadap perubahan kecil karena tanda awal yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi perilaku kekerasan.

Pemantauan tanda peningkatan agresivitas juga perlu memperhatikan faktor pencetus. Pasien dapat menjadi lebih agresif ketika berada di lingkungan yang terlalu ramai, merasa diabaikan, mengalami konflik dengan pasien lain, mendengar suara yang mengganggu, merasa dipaksa, atau mengalami nyeri dan ketidaknyamanan fisik. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya mencatat perilaku pasien, tetapi juga situasi yang menyertainya. Misalnya, bila pasien menjadi gelisah setiap kali berada di ruangan ramai, maka lingkungan ramai dapat menjadi pencetus yang perlu dikendalikan. Bila pasien menjadi marah setelah berbicara dengan anggota keluarga tertentu, maka interaksi keluarga perlu dievaluasi lebih lanjut. Pemahaman terhadap pencetus membantu perawat menyusun tindakan pencegahan yang lebih efektif.

Evaluasi kebutuhan pengawasan ketat atau lingkungan yang lebih aman perlu dilakukan berdasarkan tingkat risiko pasien. Tidak semua pasien risiko perilaku kekerasan membutuhkan tingkat pengawasan yang sama. Pasien yang masih mampu mengontrol diri, kooperatif, dan dapat menggunakan teknik pengendalian marah mungkin cukup dipantau secara berkala. Namun, pasien yang menunjukkan ancaman serius, membawa benda berbahaya, mengalami halusinasi perintah, tidak dapat diarahkan, atau memiliki riwayat kekerasan berulang memerlukan pengawasan lebih ketat. Pengawasan ketat bertujuan mencegah terjadinya cedera dan memastikan intervensi dapat dilakukan segera jika kondisi pasien memburuk.

Lingkungan yang lebih aman dapat berupa ruang yang lebih tenang, minim stimulus, mudah diawasi, dan bebas dari benda berbahaya. Perawat perlu mengevaluasi apakah pasien lebih stabil ketika berada di tempat yang tidak terlalu ramai, apakah pasien membutuhkan pendampingan lebih sering, atau apakah pasien perlu dipindahkan dari situasi yang memicu kemarahan. Dalam melakukan pengawasan, perawat tetap harus menjaga martabat pasien. Pengawasan tidak boleh dilakukan dengan cara memperlakukan, menakut-nakuti, atau membuat pasien merasa diperlakukan seperti ancaman semata. Perawat perlu menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien dan orang lain, bukan sebagai bentuk hukuman.

Pengurangan benda berbahaya di sekitar pasien merupakan tindakan penting dalam evaluasi keamanan lingkungan. Benda-benda seperti gunting, pisau, pecahan kaca, tali, kabel, korek api, alat makan tajam, benda berat, atau barang yang mudah dilempar perlu dijauhkan apabila pasien menunjukkan risiko kekerasan. Selain itu, perawat perlu memperhatikan benda yang tampak sederhana tetapi dapat menjadi berbahaya dalam situasi tertentu, seperti pulpen, ikat pinggang, kursi ringan, botol kaca, atau alat kesehatan yang mudah dilepas.

Evaluasi lingkungan harus dilakukan secara cermat karena pasien yang sedang kehilangan kontrol dapat menggunakan benda di sekitarnya secara impulsif.

Pengurangan benda berbahaya tidak berarti lingkungan harus dibuat kaku atau tidak manusiawi. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang aman, tenang, dan terapeutik. Perawat perlu menata ruangan agar tetap nyaman, tetapi tidak memberikan peluang bagi pasien untuk mencederai diri sendiri atau orang lain. Ruangan yang terlalu penuh barang dapat meningkatkan risiko, sedangkan ruangan yang terlalu kosong dan menyerupai hukuman dapat memperburuk perasaan pasien. Oleh karena itu, penataan lingkungan harus seimbang antara keamanan dan kenyamanan. Pasien tetap perlu merasa dihargai, memiliki ruang pribadi yang layak, dan mendapatkan suasana yang mendukung proses pemulihan.

Tindakan pencegahan kekerasan berulang menjadi bagian penting dari evaluasi keamanan. Kekerasan berulang dapat terjadi apabila faktor pencetus tidak dikenali, intervensi tidak konsisten, pasien tidak memahami cara mengontrol marah, atau keluarga belum mampu memberikan dukungan yang tepat. Oleh karena itu, perawat perlu mengevaluasi pola kejadian kekerasan, termasuk kapan biasanya pasien mulai marah, apa pencetusnya, bagaimana tanda awalnya, apa yang dilakukan pasien, dan tindakan apa yang berhasil menurunkan ketegangan. Dari evaluasi tersebut, perawat dapat menyusun rencana pencegahan yang lebih terarah.

Pencegahan kekerasan berulang dapat dilakukan dengan memperkuat kemampuan pasien mengenali tanda awal marah, menggunakan teknik relaksasi, mengungkapkan perasaan secara verbal, meminta bantuan, serta menghindari situasi pencetus yang tidak aman. Perawat juga perlu memberikan penguatan positif ketika pasien berhasil mengontrol dorongan agresif. Misalnya, ketika pasien mampu mengatakan bahwa ia mulai marah dan meminta waktu untuk menenangkan diri, perawat dapat memberikan apresiasi karena pasien memilih cara yang aman. Penguatan positif membantu pasien memahami bahwa perilaku adaptif dihargai dan bermanfaat bagi dirinya.

Keluarga juga perlu dilibatkan dalam pencegahan kekerasan berulang. Sebelum pasien kembali ke rumah, perawat perlu mengevaluasi apakah keluarga mampu mengenali tanda-tanda awal kemarahan, mengetahui cara menenangkan pasien, mampu menghindari komunikasi yang memicu konflik, dan memahami kapan harus mencari bantuan tenaga kesehatan. Keluarga perlu diberi edukasi bahwa membentak, memermalukan, mengejek, atau menantang pasien dapat meningkatkan risiko kekerasan. Sebaliknya, keluarga perlu diajarkan untuk berbicara dengan tenang, menjaga jarak aman, mengurangi stimulus, dan

membantu pasien menggunakan teknik pengendalian marah. Dengan dukungan keluarga yang tepat, risiko kekerasan berulang dapat ditekan.

Evaluasi keamanan pasien dan lingkungan juga harus didokumentasikan secara lengkap. Dokumentasi mencakup hasil penilaian risiko mencederai diri sendiri, risiko mencederai orang lain, risiko merusak lingkungan, tanda-tanda agresivitas, tindakan pengamanan yang dilakukan, benda berbahaya yang telah diamankan, tingkat pengawasan yang diberikan, serta respons pasien terhadap tindakan pencegahan. Dokumentasi yang baik membantu kesinambungan asuhan antarperawat dan tim kesehatan. Selain itu, dokumentasi menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah tindakan pencegahan sudah efektif atau perlu ditingkatkan. Dalam kasus risiko perilaku kekerasan, dokumentasi yang akurat sangat penting karena kondisi pasien dapat berubah dengan cepat.

Dengan demikian, evaluasi keamanan pasien dan lingkungan merupakan proses penting dalam asuhan keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan. Evaluasi ini mencakup penilaian risiko mencederai diri sendiri, mencederai orang lain, merusak benda atau lingkungan, pemantauan tanda peningkatan agresivitas, penentuan kebutuhan pengawasan ketat, pengurangan benda berbahaya, serta pencegahan kekerasan berulang. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, tetapi tetap dilakukan dengan pendekatan yang terapeutik dan menghargai martabat pasien. Melalui evaluasi keamanan yang objektif, sistematis, dan berkesinambungan, perawat dapat mencegah terjadinya cedera, menjaga lingkungan tetap kondusif, meningkatkan efektivitas intervensi, dan mendukung proses pemulihan pasien secara optimal.

I. Evaluasi Kepatuhan Terapi dan Penggunaan Obat

Evaluasi kepatuhan terapi dan penggunaan obat merupakan bagian penting dalam menilai keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan. Pada pasien dengan gangguan jiwa, terapi farmakologis sering menjadi salah satu komponen penting dalam membantu menstabilkan kondisi emosi, mengurangi gejala yang memicu agresivitas, menurunkan kecemasan, memperbaiki pola tidur, serta membantu pasien mengontrol dorongan perilaku yang membahayakan. Namun, keberhasilan terapi obat sangat bergantung pada kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat sesuai anjuran. Oleh karena itu, perawat perlu melakukan evaluasi secara sistematis untuk mengetahui apakah pasien benar-benar minum obat secara teratur, memahami manfaat obat, merasakan efek terapi, mampu mengenali efek samping, serta mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga dalam menjalani pengobatan.

Kepatuhan pasien dalam minum obat menjadi indikator penting dalam evaluasi keberhasilan intervensi. Kepatuhan tidak hanya berarti pasien meminum obat ketika berada di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup kesediaan pasien untuk melanjutkan pengobatan setelah pulang, mengikuti jadwal kontrol, serta tidak menghentikan obat tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, ketidakpatuhan minum obat dapat meningkatkan kemungkinan kekambuhan gejala, seperti mudah marah, gelisah, curiga, sulit tidur, halusinasi, waham, atau dorongan agresif. Oleh karena itu, perawat perlu mengevaluasi kepatuhan pasien melalui wawancara, observasi, catatan pemberian obat, serta informasi dari keluarga atau orang terdekat. Evaluasi ini membantu perawat mengetahui apakah pasien meminum obat sesuai dosis dan waktu yang telah ditentukan oleh dokter, atau masih sering lupa, menolak, menyembunyikan, bahkan menghentikan obat secara mandiri.

Dalam mengevaluasi kepatuhan, perawat perlu menggunakan pendekatan terapeutik dan tidak menyalahkan. Banyak pasien tidak patuh bukan semata-mata karena tidak mau sembuh, tetapi karena berbagai alasan yang perlu dipahami lebih dalam. Pasien mungkin merasa sudah sembuh sehingga menganggap obat tidak lagi diperlukan. Ada pula pasien yang menolak obat karena takut ketergantungan, tidak nyaman dengan efek samping, tidak memahami manfaat obat, merasa obat sebagai bentuk hukuman, atau memiliki keyakinan tertentu yang membuatnya ragu terhadap pengobatan. Pada pasien dengan gangguan persepsi atau isi pikir, seperti halusinasi dan waham, penolakan obat dapat terjadi karena pasien curiga bahwa obat akan mencelakakan dirinya. Oleh sebab itu, perawat perlu menggali alasan ketidakpatuhan secara sabar agar intervensi yang diberikan sesuai dengan penyebab masalah.

Pemahaman pasien terhadap manfaat obat juga perlu dievaluasi secara menyeluruh. Pasien yang memahami manfaat obat biasanya lebih mudah menerima terapi dan lebih termotivasi untuk meminumnya secara teratur. Perawat perlu menilai apakah pasien mengetahui bahwa obat dapat membantu mengurangi gejala yang mengganggu, menstabilkan emosi, membantu tidur lebih baik, menurunkan ketegangan, mengurangi halusinasi atau kecurigaan, serta membantu pasien mengontrol dorongan marah. Pemahaman ini penting karena pasien yang tidak mengetahui tujuan pengobatan cenderung menganggap obat sebagai sesuatu yang tidak perlu. Perawat dapat mengevaluasi pemahaman pasien dengan menanyakan kembali, menggunakan bahasa sederhana, apa manfaat obat yang diminum dan apa yang mungkin terjadi jika obat dihentikan tanpa arahan tenaga kesehatan.

Pemberian edukasi tentang obat harus disesuaikan dengan kemampuan pasien dalam menerima informasi. Pada pasien yang masih gelisah, sulit berkonsentrasi, atau memiliki gejala psikotik aktif, penjelasan yang terlalu panjang dapat sulit dipahami. Perawat sebaiknya memberikan informasi secara bertahap, singkat, dan jelas. Misalnya, perawat dapat menjelaskan bahwa obat membantu pasien menjadi lebih tenang, membantu pikiran lebih terarah, dan membantu mengurangi dorongan marah. Setelah itu, perawat dapat meminta pasien mengulang kembali informasi tersebut dengan kata-katanya sendiri. Cara ini membantu perawat menilai apakah pasien benar-benar memahami penjelasan yang diberikan. Bila pasien belum memahami, edukasi perlu diulang dengan pendekatan yang lebih sederhana dan suportif.

Respons pasien terhadap efek terapi obat juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Efek terapi mengacu pada perubahan positif yang muncul setelah pasien menjalani pengobatan. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, efek terapi dapat terlihat dari berkurangnya gelisah, menurunnya intensitas marah, pasien lebih mudah diarahkan, tidur lebih baik, tidak lagi mengancam, lebih mampu berkomunikasi, serta berkurangnya gejala seperti halusinasi atau kecurigaan yang dapat memicu agresivitas. Perawat perlu mengamati perubahan tersebut dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan kondisi sebelum terapi diberikan. Evaluasi respons terapi tidak hanya dilakukan melalui pernyataan pasien, tetapi juga melalui observasi perilaku sehari-hari selama perawatan.

Dalam menilai respons terhadap terapi obat, perawat perlu memperhatikan bahwa efek obat pada gangguan jiwa tidak selalu muncul secara langsung. Beberapa pasien mungkin membutuhkan waktu sebelum menunjukkan perubahan yang nyata. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Perawat dapat mencatat apakah pasien tampak lebih tenang setelah beberapa hari terapi, apakah frekuensi marah berkurang, apakah pasien lebih mampu mengikuti instruksi, dan apakah intervensi pengendalian marah lebih mudah dilakukan setelah kondisi pasien stabil. Jika tidak ada perbaikan atau justru muncul perburukan, perawat perlu melaporkan kepada dokter atau tim kesehatan untuk dilakukan evaluasi lanjutan. Perawat tidak berwenang mengubah dosis atau menghentikan obat secara mandiri, tetapi berperan penting dalam memberikan data perkembangan pasien kepada tim medis.

Kemampuan pasien mengenali efek samping obat juga perlu dievaluasi. Efek samping dapat menjadi salah satu penyebab utama pasien tidak patuh minum obat. Pasien mungkin menghentikan obat karena merasa mengantuk berlebihan, pusing, mulut kering, kaku otot, tremor, gelisah, perubahan nafsu makan, atau keluhan lain yang dirasakan mengganggu. Jika pasien tidak memahami bahwa

keluhan tersebut perlu dilaporkan, ia mungkin langsung berhenti minum obat tanpa berkonsultasi. Oleh karena itu, perawat perlu mengedukasi pasien agar mampu mengenali perubahan yang dirasakan setelah minum obat dan segera melaporkannya kepada perawat, dokter, atau tenaga kesehatan. Evaluasi ini penting untuk mencegah ketidakpatuhan dan menjaga keamanan terapi.

Perawat perlu menjelaskan kepada pasien bahwa munculnya efek samping bukan berarti pasien harus menghentikan obat sendiri. Pasien perlu memahami bahwa keluhan akibat obat dapat didiskusikan dengan tenaga kesehatan agar dapat ditangani secara tepat. Perawat juga perlu mengevaluasi apakah pasien mampu menyebutkan efek samping yang perlu diperhatikan dan apakah pasien mengetahui kepada siapa harus melapor bila keluhan muncul. Dalam proses ini, perawat perlu menggunakan bahasa yang tidak menakutkan agar pasien tidak menjadi semakin cemas terhadap pengobatan. Tujuannya adalah membantu pasien lebih sadar terhadap kondisi tubuhnya, lebih terbuka melaporkan keluhan, dan tetap menjalani terapi dengan aman di bawah pemantauan tenaga kesehatan.

Hambatan pasien dalam menjalani terapi farmakologis juga harus dievaluasi secara mendalam. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kurangnya pengetahuan, rendahnya daya tilik diri, ketakutan terhadap efek samping, rasa bosan minum obat jangka panjang, penolakan terhadap diagnosis, atau keyakinan bahwa obat tidak diperlukan. Faktor eksternal dapat berupa kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan biaya, jarak fasilitas kesehatan yang jauh, kesulitan mendapatkan obat, jadwal kontrol yang tidak teratur, atau stigma dari lingkungan. Bila hambatan ini tidak dikaji dan diatasi, pasien berisiko mengalami putus obat dan kekambuhan.

Pada pasien dengan risiko perilaku kekerasan, hambatan terapi dapat memperbesar risiko keselamatan. Misalnya, pasien yang berhenti minum obat dapat kembali mengalami gangguan tidur, mudah tersinggung, halusinasi, waham curiga, atau peningkatan impulsivitas. Kondisi tersebut dapat memicu kemarahan dan perilaku agresif, terutama bila pasien menghadapi konflik atau tekanan. Oleh karena itu, perawat perlu menanyakan secara terbuka apa yang membuat pasien sulit minum obat secara teratur. Jika hambatannya adalah lupa, perawat dapat membantu menyusun jadwal minum obat atau melibatkan keluarga. Jika hambatannya adalah efek samping, perawat perlu melaporkan kepada dokter. Jika hambatannya adalah kurangnya pemahaman, perawat perlu memberikan edukasi ulang. Dengan demikian, evaluasi hambatan menjadi dasar untuk menentukan intervensi lanjutan yang lebih tepat.

Peran keluarga dalam mengawasi kepatuhan minum obat sangat penting, terutama bagi pasien yang masih memiliki keterbatasan dalam memahami

penyakit, mengingat jadwal obat, atau mengontrol gejala. Keluarga dapat membantu mengingatkan jadwal minum obat, memastikan obat tersedia, mendampingi pasien kontrol, mengamati perubahan perilaku, serta melaporkan efek samping atau tanda kekambuhan kepada tenaga kesehatan. Dalam evaluasi, perawat perlu menilai apakah keluarga memahami pentingnya pengobatan, mengetahui jadwal obat, mampu memberikan dukungan tanpa memaksa secara kasar, dan mengetahui langkah yang harus dilakukan jika pasien menolak obat. Keluarga yang memahami terapi dengan baik dapat menjadi faktor pelindung yang membantu mencegah kekambuhan perilaku kekerasan.

Namun, tidak semua keluarga siap menjalankan peran tersebut. Sebagian keluarga mungkin merasa lelah, takut, tidak memahami penyakit pasien, atau justru memiliki keyakinan keliru tentang obat. Ada keluarga yang menghentikan obat karena pasien tampak sudah membaik, ada yang takut obat menyebabkan ketergantungan, dan ada pula yang tidak mampu mengawasi karena kesibukan atau konflik keluarga. Oleh karena itu, perawat perlu mengevaluasi kesiapan keluarga secara realistis. Edukasi kepada keluarga harus mencakup manfaat obat, risiko putus obat, cara mengamati efek samping, tanda awal kekambuhan, serta cara berkomunikasi dengan pasien agar tidak memicu kemarahan. Keluarga perlu dilibatkan sebagai mitra perawatan, bukan hanya sebagai pengawas.

Hubungan antara kepatuhan terapi dengan penurunan risiko perilaku kekerasan sangat erat. Ketika pasien minum obat secara teratur dan mendapatkan terapi sesuai anjuran, gejala yang dapat memicu perilaku kekerasan cenderung lebih terkendali. Pasien dapat menjadi lebih stabil secara emosional, lebih mudah tidur, lebih mampu mengikuti arahan, dan lebih mampu menggunakan teknik pengendalian marah yang telah diajarkan. Sebaliknya, ketika pasien tidak patuh terapi, gejala dapat kambuh atau memburuk, sehingga risiko agresivitas meningkat. Misalnya, halusinasi perintah yang tidak terkontrol dapat mendorong pasien melakukan tindakan berbahaya, atau waham curiga yang meningkat dapat membuat pasien merasa harus menyerang untuk melindungi diri. Oleh karena itu, evaluasi kepatuhan terapi merupakan bagian penting dalam pencegahan perilaku kekerasan.

Kepatuhan terapi juga mendukung keberhasilan intervensi nonfarmakologis. Latihan napas dalam, komunikasi asertif, relaksasi, pendekatan spiritual, dan strategi pengendalian marah akan lebih mudah dilakukan apabila kondisi pasien cukup stabil. Pasien yang sangat gelisah, curiga, atau dikuasai gejala psikotik mungkin sulit mengikuti latihan tersebut. Dengan terapi obat yang sesuai dan kepatuhan yang baik, pasien memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam intervensi keperawatan. Dengan demikian, terapi farmakologis dan

intervensi keperawatan saling melengkapi dalam menurunkan risiko perilaku kekerasan.

Evaluasi kepatuhan terapi dan penggunaan obat harus didokumentasikan secara lengkap. Dokumentasi mencakup apakah pasien minum obat sesuai jadwal, respons pasien terhadap obat, keluhan efek samping, alasan jika pasien menolak obat, edukasi yang telah diberikan, keterlibatan keluarga, dan tindak lanjut yang direncanakan. Dokumentasi yang baik membantu kesinambungan asuhan antarperawat dan tim kesehatan. Selain itu, dokumentasi membantu tim menilai pola kepatuhan pasien dan menentukan strategi yang paling sesuai untuk meningkatkan keberhasilan terapi. Pada pasien risiko perilaku kekerasan, dokumentasi kepatuhan obat juga penting sebagai bagian dari penilaian risiko kekambuhan dan keselamatan.

Dengan demikian, evaluasi kepatuhan terapi dan penggunaan obat pada pasien risiko perilaku kekerasan mencakup penilaian terhadap kepatuhan minum obat, pemahaman pasien tentang manfaat obat, respons terhadap efek terapi, kemampuan mengenali efek samping, hambatan dalam menjalani terapi farmakologis, peran keluarga dalam pengawasan, serta hubungan kepatuhan terapi dengan penurunan risiko kekerasan. Evaluasi ini harus dilakukan secara terapeutik, objektif, dan berkesinambungan. Perawat memiliki peran penting sebagai pendidik, pengamat, pendamping, dan penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Dengan kepatuhan terapi yang baik, risiko perilaku kekerasan dapat ditekan, kestabilan emosi pasien dapat meningkat, dan proses pemulihan dapat berjalan lebih optimal.

J. Evaluasi Peran Keluarga dalam Mendukung Keberhasilan Intervensi

Evaluasi peran keluarga dalam mendukung keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan merupakan bagian penting dalam proses asuhan yang berkelanjutan. Keluarga memiliki posisi strategis karena sebagian besar waktu pasien berada bersama keluarga, terutama setelah pasien pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam banyak kasus, keberhasilan intervensi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pasien mengontrol marah selama dirawat, tetapi juga oleh sejauh mana keluarga mampu memahami kondisi pasien, mengenali tanda awal kekambuhan, memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan yang aman, mengingatkan pasien menggunakan teknik pengendalian marah, serta mendukung kepatuhan terapi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap keluarga perlu dilakukan secara menyeluruh agar perawat dapat mengetahui kesiapan keluarga dalam melanjutkan perawatan di rumah.

Kemampuan keluarga mengenali tanda awal kemarahan pasien menjadi aspek pertama yang penting untuk dievaluasi. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu sebelum emosi meningkat menjadi tindakan agresif. Tanda tersebut dapat berupa perubahan ekspresi wajah, suara mulai meninggi, tampak gelisah, mondar-mandir, tangan mengepal, mudah tersinggung, menarik diri, menolak diajak bicara, atau mulai mengucapkan kata-kata bernada ancaman. Pada beberapa pasien, tanda awal juga dapat berupa sulit tidur, bicara sendiri, tampak curiga, menatap tajam, atau menjadi lebih sensitif terhadap komentar orang lain. Keluarga perlu mampu mengenali tanda-tanda tersebut agar dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal sebelum pasien kehilangan kontrol.

Evaluasi terhadap kemampuan keluarga dapat dilakukan dengan menanyakan kepada keluarga tanda apa saja yang biasanya muncul ketika pasien mulai marah. Perawat dapat menggali apakah keluarga mampu membedakan antara marah biasa dan tanda risiko perilaku kekerasan. Misalnya, keluarga perlu mengetahui bahwa pasien yang mulai berbicara keras, memukul meja, menolak diarahkan, atau tampak sangat curiga perlu segera ditangani dengan pendekatan yang tenang. Bila keluarga belum mampu mengenali tanda awal tersebut, risiko kekerasan berulang dapat meningkat karena keluarga mungkin baru bereaksi setelah pasien sudah berada dalam kondisi agresif. Oleh sebab itu, perawat perlu memastikan keluarga memahami tanda-tanda awal kemarahan dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika tanda tersebut muncul.

Kemampuan keluarga memberikan dukungan emosional juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan intervensi. Pasien dengan risiko perilaku kekerasan sering mengalami kesulitan mengelola emosi, merasa tidak dipahami, mudah tersinggung, atau memiliki pengalaman ditolak oleh lingkungan. Dukungan emosional dari keluarga dapat membantu pasien merasa diterima, dihargai, dan tidak sendirian dalam menghadapi masalahnya. Dukungan emosional dapat diberikan melalui sikap mendengarkan, berbicara dengan tenang, tidak menghakimi, tidak mempermalukan pasien, serta menunjukkan kepedulian terhadap perasaan pasien. Keluarga yang mampu memberikan dukungan emosional dapat membantu menurunkan ketegangan pasien dan mencegah meningkatnya dorongan agresif.

Dalam evaluasi, perawat perlu menilai bagaimana keluarga merespons ketika pasien mulai marah atau gelisah. Respons keluarga yang tenang, empatik, dan tidak memancing emosi dapat membantu pasien merasa lebih aman. Sebaliknya, respons keluarga yang membentak, menyalahkan, mengejek, menantang, atau mempermalukan pasien dapat memperburuk kemarahan dan meningkatkan risiko

perilaku kekerasan. Perawat dapat menanyakan kepada keluarga apa yang biasanya dilakukan ketika pasien marah, bagaimana cara keluarga berbicara kepada pasien, dan apakah keluarga memberi kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan perasaannya. Bila keluarga masih menggunakan pendekatan yang keras atau menyudutkan, perawat perlu memberikan edukasi agar keluarga memahami bahwa pasien membutuhkan dukungan yang menenangkan, bukan tekanan yang memperberat emosinya.

Kemampuan keluarga menciptakan lingkungan rumah yang aman juga perlu dievaluasi secara cermat. Lingkungan rumah yang aman sangat penting bagi pasien risiko perilaku kekerasan karena situasi rumah dapat menjadi faktor pelindung atau justru menjadi pencetus kekambuhan. Lingkungan yang aman bukan hanya berarti bebas dari benda tajam atau benda berbahaya, tetapi juga mencakup suasana emosional yang tenang, komunikasi keluarga yang baik, dan pengurangan stimulus yang dapat memicu kemarahan pasien. Keluarga perlu memahami bahwa suasana rumah yang penuh konflik, bising, tidak teratur, atau sering terjadi pertengkaran dapat meningkatkan risiko pasien mengalami peningkatan emosi.

Perawat perlu mengevaluasi apakah keluarga mampu mengatur rumah agar lebih aman bagi pasien dan anggota keluarga lain. Hal ini dapat mencakup upaya menyimpan benda tajam di tempat yang tidak mudah dijangkau, menghindari benda yang mudah digunakan untuk melukai diri atau orang lain, mengatur ruang yang tenang bagi pasien, serta mengurangi situasi yang memicu konflik. Keluarga juga perlu memahami pentingnya tidak mengerumuni pasien ketika pasien sedang marah, tidak memaksakan pembicaraan saat pasien belum siap, dan tidak menghalangi pasien secara fisik apabila hal tersebut dapat membuat pasien merasa terancam. Lingkungan yang aman membantu pasien memiliki ruang untuk menenangkan diri dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan agresif.

Selain menciptakan lingkungan fisik yang aman, keluarga juga perlu menciptakan lingkungan psikologis yang suportif. Pasien perlu merasa bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk beristirahat, berbicara, dan memperoleh dukungan. Lingkungan psikologis yang aman dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penghargaan terhadap pasien, pemberian kesempatan kepada pasien untuk berpartisipasi dalam aktivitas keluarga, serta penerimaan terhadap proses pemulihan pasien. Keluarga juga perlu menghindari stigma, label negatif, atau ucapan yang merendahkan, seperti menyebut pasien berbahaya, tidak berguna, atau merepotkan. Ucapan seperti itu dapat memperburuk harga diri pasien dan memicu kemarahan atau perilaku menarik diri.

Kemampuan keluarga mengingatkan pasien menggunakan teknik kontrol marah merupakan bagian penting dari evaluasi keberhasilan intervensi. Selama perawatan, pasien biasanya diajarkan berbagai teknik pengendalian marah, seperti napas dalam, relaksasi, menjauh dari situasi pemicu, mengungkapkan marah secara verbal, menggunakan komunikasi asertif, melakukan aktivitas fisik yang aman, atau pendekatan spiritual sesuai keyakinan pasien. Namun, setelah pasien kembali ke rumah, pasien mungkin lupa atau belum mampu menerapkan teknik tersebut secara mandiri. Dalam hal ini, keluarga berperan sebagai pendamping yang membantu mengingatkan pasien dengan cara yang tepat dan tidak memicu perlawanan.

Evaluasi dilakukan dengan menilai apakah keluarga mengetahui teknik kontrol marah yang telah diajarkan kepada pasien. Perawat dapat menanyakan kepada keluarga apakah mereka memahami cara membimbing pasien menarik napas dalam, bagaimana mengingatkan pasien untuk menenangkan diri, atau bagaimana membantu pasien memilih aktivitas yang aman ketika marah. Keluarga perlu diingatkan bahwa cara mengingatkan pasien harus dilakukan dengan tenang dan tidak memerintah secara kasar. Misalnya, keluarga dapat mengatakan, "Mari kita tarik napas pelan-pelan dulu," atau "Kita duduk sebentar sampai lebih tenang," bukan mengatakan, "Kamu jangan marah terus!" atau "Kamu harus diam sekarang!" Cara keluarga memberikan arahan sangat menentukan apakah pasien merasa dibantu atau justru merasa disudutkan.

Kemampuan keluarga mendukung kepatuhan minum obat dan kontrol ulang juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan intervensi. Pada pasien risiko perilaku kekerasan yang memiliki gangguan jiwa, terapi obat sering berperan dalam menstabilkan emosi, mengurangi gejala psikotik, memperbaiki tidur, dan menurunkan dorongan agresif. Ketidakpatuhan minum obat dapat meningkatkan risiko kekambuhan, termasuk munculnya kembali kemarahan berlebihan, halusinasi, waham curiga, atau perilaku agresif. Oleh karena itu, keluarga perlu memahami jadwal minum obat, manfaat obat, kemungkinan efek samping, dan pentingnya kontrol ulang secara teratur.

Perawat perlu mengevaluasi apakah keluarga mampu membantu pasien minum obat sesuai anjuran tanpa menimbulkan konflik. Keluarga dapat membantu dengan menyiapkan obat, membuat jadwal minum obat, mengingatkan pasien secara lembut, serta memperhatikan apakah pasien benar-benar meminum obat. Namun, pengawasan obat harus dilakukan dengan tetap menghargai pasien. Jika keluarga terlalu memaksa, mencurigai secara berlebihan, atau memperlakukan pasien seperti anak kecil, pasien dapat merasa tidak dihargai dan menolak obat. Oleh karena itu, keluarga perlu diajarkan cara mendukung kepatuhan dengan

pendekatan kolaboratif, misalnya mengajak pasien memahami manfaat obat dan melibatkan pasien dalam pengaturan jadwal minum obat.

Kontrol ulang juga perlu menjadi perhatian keluarga. Banyak pasien mengalami kekambuhan karena tidak melanjutkan kontrol setelah merasa membaik. Keluarga perlu memahami bahwa kontrol ulang bukan hanya dilakukan saat pasien kambuh, tetapi juga untuk memantau perkembangan, menyesuaikan terapi, mengevaluasi efek obat, dan mencegah kekambuhan. Dalam evaluasi, perawat perlu menilai apakah keluarga mengetahui jadwal kontrol, memiliki akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, mampu mendampingi pasien, dan memahami tanda-tanda yang mengharuskan pasien segera dibawa kembali ke layanan kesehatan. Bila keluarga mengalami hambatan transportasi, biaya, atau kurang informasi, perawat perlu membantu merencanakan solusi sesuai sumber daya yang tersedia.

Hambatan keluarga dalam merawat pasien risiko perilaku kekerasan juga harus dievaluasi secara mendalam. Merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan dapat menimbulkan beban fisik, emosional, sosial, dan ekonomi bagi keluarga. Keluarga dapat merasa takut, lelah, bingung, malu, atau tidak mampu menghadapi perubahan perilaku pasien. Sebagian keluarga mungkin memiliki pengalaman traumatis akibat pernah menjadi korban kekerasan pasien. Ada pula keluarga yang merasa khawatir terhadap stigma masyarakat, sehingga cenderung menyembunyikan kondisi pasien dan tidak mencari bantuan. Hambatan-hambatan ini dapat mengurangi kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan yang konsisten.

Perawat perlu menggali hambatan keluarga dengan sikap empatik dan tidak menyalahkan. Keluarga yang tampak kurang mendukung belum tentu tidak peduli, tetapi mungkin belum memiliki pengetahuan, keterampilan, atau sumber daya yang cukup. Beberapa keluarga mungkin tidak memahami bahwa perilaku kekerasan dapat berkaitan dengan gangguan jiwa atau ketidakmampuan pasien mengontrol emosi. Ada keluarga yang menganggap pasien sengaja berperilaku buruk, sehingga merespons dengan kemarahan. Ada juga keluarga yang terlalu takut sehingga memilih menjauh dan membiarkan pasien sendiri. Evaluasi hambatan keluarga membantu perawat menentukan edukasi dan dukungan apa yang paling dibutuhkan agar keluarga dapat menjalankan perannya secara lebih baik.

Hambatan lain yang sering muncul adalah konflik dalam keluarga. Pasien yang tinggal di lingkungan keluarga dengan komunikasi buruk, pertengkaran berulang, tuntutan tinggi, atau penolakan emosional memiliki risiko lebih besar mengalami kekambuhan perilaku agresif. Dalam evaluasi, perawat perlu menilai

apakah hubungan keluarga mendukung pemulihan atau justru menjadi pencetus kemarahan pasien. Perawat dapat menggali pola komunikasi keluarga, siapa yang paling sering berinteraksi dengan pasien, apakah ada anggota keluarga yang menjadi pemicu konflik, serta bagaimana keluarga menyelesaikan masalah. Bila ditemukan konflik yang signifikan, intervensi keluarga atau rujukan ke layanan yang sesuai dapat dipertimbangkan.

Edukasi lanjutan yang dibutuhkan keluarga harus disusun berdasarkan hasil evaluasi. Edukasi tidak cukup diberikan satu kali, karena keluarga membutuhkan pemahaman bertahap dan kesempatan untuk bertanya. Materi edukasi dapat mencakup pengertian risiko perilaku kekerasan, tanda awal kemarahan, faktor pencetus, cara berkomunikasi dengan pasien, teknik de-eskalasi sederhana, cara membantu pasien melakukan kontrol marah, pentingnya minum obat, jadwal kontrol, efek samping obat yang perlu dilaporkan, serta tanda bahaya yang membutuhkan pertolongan segera. Edukasi juga perlu mencakup cara menjaga keselamatan keluarga tanpa memperlakukan pasien secara kasar atau merendahkan.

Edukasi lanjutan juga perlu menekankan pentingnya perawatan diri bagi keluarga. Keluarga yang merawat pasien dengan risiko perilaku kekerasan dapat mengalami kelelahan emosional. Jika keluarga terlalu lelah, respons mereka terhadap pasien dapat menjadi kurang sabar dan memicu konflik. Oleh karena itu, keluarga perlu diberi pemahaman bahwa mereka juga membutuhkan istirahat, dukungan sosial, dan bantuan dari anggota keluarga lain atau layanan kesehatan. Perawat dapat mendorong keluarga untuk membagi peran, mencari dukungan komunitas, dan tidak ragu menghubungi tenaga kesehatan jika merasa kewalahan. Keluarga yang sehat secara emosional akan lebih mampu mendukung pasien secara konsisten.

Evaluasi peran keluarga juga perlu memperhatikan kesiapan keluarga menjelang pasien pulang. Sebelum pasien kembali ke rumah, perawat perlu memastikan bahwa keluarga memahami rencana perawatan lanjutan, mengetahui cara menghadapi situasi krisis, dan memiliki akses terhadap bantuan jika risiko kekerasan muncul kembali. Keluarga perlu mengetahui kapan harus segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan, misalnya jika pasien mulai mengancam, membawa benda berbahaya, tidak tidur sehari-hari, menolak obat, mengalami halusinasi perintah, atau menunjukkan kecurigaan berat. Kesiapan keluarga dalam menghadapi kondisi darurat merupakan bagian penting dari pencegahan kekerasan berulang.

Dalam proses evaluasi, perawat juga perlu menilai hubungan antara keluarga dan pasien. Dukungan keluarga akan lebih efektif jika hubungan antara pasien dan

keluarga cukup baik. Jika hubungan penuh konflik, pasien mungkin menolak bantuan keluarga atau merasa semakin terancam ketika keluarga mencoba mengingatkan. Dalam kondisi seperti ini, perawat perlu membantu keluarga memilih pendekatan yang lebih tepat, misalnya menggunakan anggota keluarga yang paling dipercaya pasien sebagai pendamping utama. Perawat juga dapat membantu keluarga memahami pentingnya komunikasi yang tidak menyudutkan dan memberi ruang kepada pasien untuk merasa dihargai.

Dengan demikian, evaluasi peran keluarga dalam mendukung keberhasilan intervensi pada pasien risiko perilaku kekerasan mencakup kemampuan keluarga mengenali tanda awal kemarahan, memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan rumah yang aman, mengingatkan pasien menggunakan teknik kontrol marah, mendukung kepatuhan minum obat dan kontrol ulang, memahami hambatan dalam perawatan, serta menerima edukasi lanjutan sesuai kebutuhan. Keluarga merupakan bagian penting dari sistem pendukung pasien, sehingga keberhasilan intervensi keperawatan tidak dapat dipisahkan dari kesiapan dan kemampuan keluarga. Melalui evaluasi yang komprehensif, perawat dapat membantu keluarga menjadi mitra perawatan yang lebih efektif, sehingga risiko kekerasan berulang dapat dikurangi dan proses pemulihan pasien dapat berlangsung lebih optimal.

K. Simpulan

Evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan merupakan tahap penting dalam proses asuhan keperawatan karena menjadi dasar untuk menilai efektivitas tindakan yang telah diberikan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada tidak terjadinya perilaku kekerasan, tetapi juga mencakup perubahan respons pasien secara kognitif, afektif, perilaku, sosial, serta kepatuhan terhadap terapi. Melalui evaluasi yang sistematis, perawat dapat mengetahui apakah pasien sudah mampu mengenali penyebab kemarahan, memahami tanda-tanda peningkatan emosi, mengungkapkan perasaan secara verbal tanpa mengancam, menggunakan teknik pengendalian marah, serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Keberhasilan intervensi keperawatan pada pasien risiko perilaku kekerasan dapat dilihat dari kemampuan pasien dalam mengontrol dorongan agresif dan memilih cara yang aman saat marah. Intervensi yang diberikan, seperti membina hubungan saling percaya, membantu pasien mengenali penyebab marah, melatih napas dalam, relaksasi, komunikasi asertif, aktivitas fisik terarah, pendekatan spiritual, serta dukungan farmakologis, perlu dievaluasi secara berkesinambungan. Evaluasi juga harus mencakup aspek keamanan pasien dan lingkungan, termasuk

penilaian risiko mencederai diri sendiri, mencederai orang lain, merusak benda, kebutuhan pengawasan ketat, pengurangan benda berbahaya, serta pencegahan kekerasan berulang. Dengan demikian, evaluasi menjadi dasar bagi perawat untuk menentukan apakah intervensi perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan secara bertahap.

Selain pasien, keluarga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan intervensi dan mencegah kekambuhan perilaku kekerasan. Keluarga perlu dievaluasi kemampuannya dalam mengenali tanda awal kemarahan, memberikan dukungan emosional, menciptakan lingkungan rumah yang aman, mengingatkan pasien menggunakan teknik kontrol marah, serta mendukung kepatuhan minum obat dan kontrol ulang. Hambatan keluarga dalam merawat pasien juga perlu dikaji agar perawat dapat memberikan edukasi lanjutan yang sesuai. Dengan evaluasi yang objektif, terukur, sistematis, dan melibatkan pasien, keluarga, serta tim kesehatan, asuhan keperawatan jiwa dapat berjalan lebih aman, efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan pasien secara optimal.

L. Referensi

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.). American Psychiatric Association Publishing.
- American Nurses Association. (2015). *Nursing: Scope and standards of practice* (3rd ed.). American Nurses Association.
- Butcher, H. K., Bulechek, G. M., Dochterman, J. M. M., & Wagner, C. M. (Eds.). (2018). *Nursing interventions classification (NIC)* (7th ed.). Elsevier.
- Damaiyanti, M., & Iskandar. (2012). *Asuhan keperawatan jiwa*. Refika Aditama.
- Halter, M. J. (2022). *Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing: A clinical approach* (9th ed.). Elsevier.
- Herdman, T. H., Kamitsuru, S., & Lopes, C. T. (Eds.). (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023* (12th ed.). Thieme.
- Keliat, B. A. (2014). *Proses keperawatan jiwa* (Edisi 2). EGC.
- Keliat, B. A., & Akemat. (2012). *Keperawatan kesehatan jiwa komunitas: CMHN (basic course)*. EGC.

- Keliat, B. A., Akemat, & Nurhalimah. (2013). *Keperawatan kesehatan jiwa: Konsep dan aplikasi praktik klinik*. EGC.
- Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (Eds.). (2018). *Nursing outcomes classification (NOC): Measurement of health outcomes* (6th ed.). Elsevier.
- Nasir, A., & Muhith, A. (2011). *Dasar-dasar keperawatan jiwa: Pengantar dan teori*. Salemba Medika.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2015). *Violence and aggression: Short-term management in mental health, health and community settings* (NICE Guideline No. 10). National Institute for Health and Care Excellence.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Richmond, J. S., Berlin, J. S., Fishkind, A. B., Holloman, G. H., Zeller, S. L., Wilson, M. P., Rifai, M. A., & Ng, A. T. (2012). Verbal de-escalation of the agitated patient: Consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup. *Western Journal of Emergency Medicine*, 13(1), 17–25.
- Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Stuart, G. W. (2022). *Prinsip dan praktik keperawatan kesehatan jiwa Stuart* (Edisi Indonesia 11; B. A. Keliat & J. Pasaribu, Eds.). Elsevier Health Sciences.
- Sutejo. (2018). *Keperawatan jiwa: Konsep dan praktik asuhan keperawatan kesehatan jiwa: Gangguan jiwa dan psikososial*. Pustaka Baru Press.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Townsend, M. C., & Morgan, K. I. (2020). *Essentials of psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice* (8th ed.). F. A. Davis

Company.

Videbeck, S. L. (2020). *Psychiatric-mental health nursing* (8th ed.). Wolters Kluwer.

Yusuf, A., Fitryasari, R., & Nihayati, H. E. (2015). *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa*. Salemba Medika.

M. Glosarium

- **Evaluasi Keperawatan**

Proses menilai respons pasien setelah diberikan intervensi keperawatan untuk mengetahui apakah tujuan asuhan telah tercapai, belum tercapai, atau perlu dilakukan perubahan tindakan.

- **Intervensi Keperawatan Jiwa**

Serangkaian tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan masalah kesehatan jiwa untuk membantu mengurangi gejala, meningkatkan coping, menjaga keselamatan, dan mendukung pemulihan.

- **Risiko Perilaku Kekerasan**

Keadaan ketika pasien berpotensi melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan akibat ketidakmampuan mengontrol emosi, marah, atau dorongan agresif.

- **Perilaku Kekerasan**

Tindakan verbal maupun fisik yang dapat menimbulkan cedera, ancaman, kerusakan, atau rasa tidak aman, seperti memukul, mengancam, membentak, melempar benda, atau merusak lingkungan.

- **Pengendalian Marah**

Kemampuan pasien mengenali, mengelola, dan menyalurkan emosi marah dengan cara yang aman, tepat, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

- **Agresivitas**

Kecenderungan atau perilaku menyerang secara verbal maupun fisik yang muncul akibat kemarahan, frustrasi, ketakutan, atau perasaan terancam.

- **Respons Kognitif**

Respons yang berkaitan dengan cara pasien berpikir, memahami penyebab marah, mengenali pencetus, dan menyadari akibat dari perilaku kekerasan.

- **Respons Afektif**

Respons yang berhubungan dengan perasaan atau emosi pasien, seperti marah, kecewa, takut, cemas, tersinggung, atau frustrasi.

- **Respons Perilaku**

Bentuk tindakan atau perilaku yang ditunjukkan pasien sebagai reaksi terhadap emosi, seperti berbicara keras, mengancam, menarik diri, melakukan relaksasi, atau meminta bantuan.

- **Komunikasi Asertif**

Kemampuan menyampaikan perasaan, pendapat, kebutuhan, atau ketidaksetujuan secara jelas dan tegas tanpa mengancam, menyakiti, atau merendahkan orang lain.

- **Relaksasi Napas Dalam**

Teknik pengendalian emosi dengan menarik napas secara perlahan, menahan sejenak, lalu menghembuskannya secara perlahan untuk menurunkan ketegangan fisik dan emosional.

- **Kepatuhan Terapi**

Kesediaan pasien mengikuti anjuran pengobatan dan perawatan, termasuk minum obat sesuai jadwal, mengikuti kontrol ulang, serta menjalankan latihan pengendalian marah.

- **Efek Samping Obat**

Reaksi yang tidak diharapkan dari penggunaan obat, seperti mengantuk, pusing, mulut kering, tremor, kaku otot, atau keluhan lain yang perlu dilaporkan kepada tenaga kesehatan.

- **Keselamatan Pasien**

Upaya mencegah cedera atau bahaya pada pasien selama proses perawatan, termasuk pengawasan risiko mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

- **Dukungan Keluarga**

Bantuan emosional, sosial, dan praktis yang diberikan keluarga kepada pasien, seperti mengenali tanda awal marah, mengingatkan teknik kontrol marah, mendukung minum obat, dan menciptakan lingkungan rumah yang aman.

PROFIL PENULIS



Ns. Femi Kesumawati, S.Kep, M.Kep Lahir di Sungailiat, 20 November 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas 2014 dan lulus tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 pertama kali magang kerja di RSUD Koja Jakarta Utara, lanjut di tahun 2008 -2010 berkesempatan mulai karir menjadi dosen di STIKes Istara Nusantara Jakarta, Tahun 2010 – 2025

berkesempatan bekerja di Akademi Keperawatan Bina Insan Jakarta. Dan pada tahun 2025 – Sekarang bekerja di STIKES RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. Saat ini penulis bekerja di STIKES RSPAD Gatot Soebroto Jakarta mengampu mata kuliah Psikologi, Keperawatan Dasar, Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan Psikososial, Keperawatan Jiwa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

femikesumawati@gmail.com

Motto: "Living your life well"

PROFIL PENULIS



Ns. Sondang Selviana Silitonga, S.Kep., M.Kes. lahir pada tanggal 09 Juni 1973. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma III Keperawatan pada tahun 1995 di Akademi Keperawatan Universitas Advent Indonesia, Bandung. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep.) di STIKES Binawan Jakarta dan lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian menyelesaikan pendidikan Profesi Ners pada tahun 2014 serta meraih gelar Magister Kesehatan (M.Kes.) pada tahun yang sama.

Penulis memiliki pengalaman lebih dari 29 tahun di bidang keperawatan dengan berbagai jenjang karier dan tanggung jawab profesional. Karier keperawatan diawali sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, kemudian melanjutkan pengabdian di Rumah Sakit Pluit Jakarta. Berkat pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, penulis dipercaya menduduki berbagai posisi manajerial dan pendidikan keperawatan, antara lain sebagai Kepala Ruangan di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi, Clinical Educator di Rumah Sakit Siloam Jambi, serta Kepala Seksi Keperawatan di Rumah Sakit Royal Prima Jambi.

Selain berkiprah dalam pelayanan dan manajemen keperawatan, penulis juga aktif dalam bidang pendidikan tinggi. Saat ini penulis bertugas sebagai Dosen Keperawatan di Universitas Adiwangsa Jambi dan mengampu berbagai mata kuliah keperawatan. Penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penulisan buku ajar, publikasi karya ilmiah, seminar, pelatihan, serta berbagai kegiatan akademik lainnya yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu dan praktik keperawatan di Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui email: selvianasondang@gmail.com.

Motto: "Living Your Life Well."

PROFIL PENULIS



Ns. Reta Renylda, S.Kep., M.Kep. Lahir di Jambi pada 23 Maret 1981. Menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di STIK Bina Husada Palembang Tahun 2002-2007 dan S2 Keperawatan di Universitas Andalas Padang Tahun 2014-2016. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi.

SINOPSIS

Bunga Rampai **“Peran Perawat dalam Pencegahan Risiko Perilaku Kekerasan pada Pasien Gangguan Jiwa”** membahas secara ringkas namun terarah mengenai peran penting perawat dalam mengenali dan mencegah risiko kekerasan pada pasien dengan gangguan jiwa. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai peran perawat dalam pencegahan risiko kekerasan, termasuk pemahaman terhadap faktor predisposisi perilaku kekerasan yang dapat memengaruhi kondisi pasien. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting bagi perawat untuk melakukan pengkajian awal, mengenali tanda risiko, serta menentukan pendekatan keperawatan yang aman dan tepat.

Selanjutnya, buku ini menguraikan komunikasi terapeutik dan teknik de-eskalasi sebagai keterampilan utama dalam menghadapi pasien yang mengalami kecemasan, kemarahan, agitasi, atau menunjukkan tanda-tanda peningkatan agresivitas. Pembahasan mencakup konsep dasar komunikasi terapeutik, prinsip dan tahapan komunikasi, teknik komunikasi dalam keperawatan, hambatan komunikasi, serta konsep dan pelaksanaan teknik de-eskalasi dalam praktik keperawatan. Materi ini menekankan bahwa komunikasi yang empatik, tenang, tidak menghakimi, dan tidak provokatif berperan besar dalam menciptakan hubungan saling percaya serta mencegah situasi berkembang menjadi perilaku kekerasan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan pasien dalam mengenali penyebab marah, memahami tanda peningkatan emosi, menggunakan teknik pengendalian marah, menjaga keamanan diri dan lingkungan, mematuhi terapi, serta menerima dukungan keluarga. Buku ini juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan kolaborasi tim kesehatan dalam mendukung keberhasilan intervensi. Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat jiwa, tenaga kesehatan, serta keluarga pasien dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan jiwa yang aman, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

Bunga Rampai “Peran Perawat dalam Pencegahan Risiko Perilaku Kekerasan pada Pasien Gangguan Jiwa” membahas secara ringkas namun terarah mengenai peran penting perawat dalam mengenali dan mencegah risiko kekerasan pada pasien dengan gangguan jiwa. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai peran perawat dalam pencegahan risiko kekerasan, termasuk pemahaman terhadap faktor predisposisi perilaku kekerasan yang dapat memengaruhi kondisi pasien. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting bagi perawat untuk melakukan pengkajian awal, mengenali tanda risiko, serta menentukan pendekatan keperawatan yang aman dan tepat.

Selanjutnya, buku ini menguraikan komunikasi terapeutik dan teknik de-eskalasi sebagai keterampilan utama dalam menghadapi pasien yang mengalami kecemasan, kemarahan, agitasi, atau menunjukkan tanda-tanda peningkatan agresivitas. Pembahasan mencakup konsep dasar komunikasi terapeutik, prinsip dan tahapan komunikasi, teknik komunikasi dalam keperawatan, hambatan komunikasi, serta konsep dan pelaksanaan teknik de-eskalasi dalam praktik keperawatan. Materi ini menekankan bahwa komunikasi yang empatik, tenang, tidak menghakimi, dan tidak provokatif berperan besar dalam menciptakan hubungan saling percaya serta mencegah situasi berkembang menjadi perilaku kekerasan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas evaluasi keberhasilan intervensi keperawatan jiwa pada pasien risiko perilaku kekerasan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan pasien dalam mengenali penyebab marah, memahami tanda peningkatan emosi, menggunakan teknik pengendalian marah, menjaga keamanan diri dan lingkungan, mematuhi terapi, serta menerima dukungan keluarga. Buku ini juga menekankan pentingnya keterlibatan keluarga dan kolaborasi tim kesehatan dalam mendukung keberhasilan intervensi. Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat jiwa, tenaga kesehatan, serta keluarga pasien dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan jiwa yang aman, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



Optimal
Untuk
Negeri



ISBN 978-634-7756-49-7 (PDF)



9

786347

756497